



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE
MESTRADO PROFISSIONAL**



DENISE WISNIEWSKI DE MATTOS

**GUIA PRÁTICO SOBRE FLUXOS E DIRECIONAMENTOS NA APS DE
PORTO ALEGRE PARA PROFISSIONAIS EM UNIDADES DE SAÚDE**

Porto Alegre, 2026



DENISE WISNIEWSKI DE MATTOS

**GUIA PRÁTICO SOBRE FLUXOS E DIRECIONAMENTOS NA APS DE
PORTO ALEGRE PARA PROFISSIONAIS EM UNIDADES DE SAÚDE**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Ensino na Saúde.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Mariangela Kraemer Lenz Ziede

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Wisniewski de Mattos, Denise
Guia Prático sobre fluxos e direcionamentos na APS
de Porto Alegre para profissionais em Unidades de
Saúde / Denise Wisniewski de Mattos. -- 2026.
124 f.
Orientadora: Mariângela Kraemer Lenz Ziede.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Ensino na Saúde, Porto Alegre, BR-RS,
2026.

1. Atenção primária à saúde. 2. Rede de atenção à
saúde. 3. Guia de prática clínica. 4. Tecnologia
Educacional. 5. Educação em Saúde. I. Kraemer Lenz
Ziede, Mariângela, orient. II. Título.

Denise Wisniewski de Mattos

GUIA PRÁTICO SOBRE FLUXOS E DIRECIONAMENTOS NA APS DE PORTO
ALEGRE PARA PROFISSIONAIS EM UNIDADES DE SAÚDE

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Ensino na Saúde da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul como
requisito parcial para a obtenção do título de mestre em
Ensino na Saúde.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Mariangela Kraemer Lenz Ziede

Aprovada em: 12 de março de 2026

BANCA EXAMINADORA:

Prof. ^a Dra. Camila Giugliani

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Prof. ^a Dra. Betânia Barreto de Athayde Bohrer

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Prof. ^a Dra. Gisele Martins Gomes

Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA)

A meu Pai Martin in memoriam, por ter me deixado a melhor herança possível, pois como dizia, "ninguém pode tirar o estudo de vocês" sei que aí de cima estará orgulhoso da tua filha, Este título é nosso, Pai!

AGRADECIMENTOS

Ao amor da minha vida, Luiz, por acreditar, me incentivar em todos meus sonhos e sempre ajudar a torná-los realidade; este mestrado é um desses sonhos. À minhas filhas, Luiza, Fernanda e Laura, por todo amor incondicional, mesmo sendo uma mãe “tão ocupada”, fica a culpa, mas fica todo o exemplo que quero transmitir; que nunca é tarde e que somos aquilo que que ousamos ser, por isso, voem meus amores ... Luiza, sem você não seria possível, não apenas no site, mas na vida, no incentivo, por ser a segunda mãe das manas e fazer com que todos os dias eu tenha que ser melhor que o anterior para seguir te levar comigo! À minha mãe e meus familiares por ajudarem principalmente com as crianças. Aos meus colegas de mestrado, foi tão bom compartilhar experiências, afetos e boas idas em bares, que também fazem parte desta caminhada. Às minhas colegas de trabalho, Milene, Ana, Fernanda e Eveline pelo incentivo e pela colaboração para que eu pudesse me ausentar do trabalho e comparecer às aulas e especialmente à Gláucia que me ajudou desde a “entrar no site da UFRGS” para fazer a matrícula até “dar jeito na proficiência”. Também em especial à minha chefia Cristiane, pelo apoio, confiança e incentivo ao meu desenvolvimento profissional e acadêmico, sempre acolhendo e viabilizando minha participação em capacitações, preceptorias e demais iniciativas formativas. Aos pacientes que já passaram por mim e que me ensinaram muito sobre a vida. Aos meus alunos de todas as preceptorias, por tudo o que me ensinam e por despertarem em mim, de forma tão profunda, o desejo de seguir me qualificando e trilhando esse caminho que me enche de sentido. À minha orientadora, Prof. Mariângela, que me apoiou e me deixou muito segura em todos os momentos, foi muito bom desenvolver este trabalho junto com alguém tão especial, que transmitiu sempre tranquilidade e sempre esteve à disposição, espero que nosso caminho siga se cruzando, na amizade e na vida acadêmica. Ao corpo docente e discente do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde – Mestrado Profissional da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), por todas as trocas de ideias e em especial à minha banca, Camila por nos acalmar a aconchegar no primeiro semestre, nos mostrando que era possível. Bethânia, que me fez acreditar muito no produto quando falei dele numa aula de sexta à noite e me falaste que estava esperando ansiosa para repassar aos residentes, saí tão feliz, que nunca mais esqueci e pensava no quanto o guia tinha que estar bom para que tu pudesses indicar aos teus alunos mesmo. À Gisele, que em 2018 me mostrou o que era acolhimento em atenção primária e a todos que de alguma forma cruzaram meu caminho, muito obrigado.

RESUMO

Introdução: A Atenção Primária à Saúde (APS) é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e desempenha papel estratégico na coordenação do cuidado, na organização das Redes de Atenção à Saúde e na resposta às necessidades da população a partir do território. **Objetivo:** Compreender as principais dificuldades e necessidades dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) de Porto Alegre em relação à organização e utilização dos fluxos de trabalho, a fim de subsidiar a elaboração de uma ferramenta de apoio técnico-institucional que contribua para o aprimoramento das práticas e para a qualificação das ações na APS. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa, desenvolvido com profissionais médicos e enfermeiros da Atenção Primária à Saúde de Porto Alegre. A coleta de dados ocorreu por meio de dois questionários on-line, elaborados na plataforma Google Forms. O primeiro instrumento foi composto por questões fechadas e abertas, contemplando caracterização sociodemográfica e profissional, percepção sobre o ingresso na APS, dificuldades relacionadas aos fluxos assistenciais e autopercepção de aptidão para encaminhamentos em diferentes temáticas prioritárias. O segundo instrumento consistiu na avaliação de uma pré-versão do guia digital, contendo itens em escala de concordância e questões abertas para sugestões. **Análise dos dados:** Os dados qualitativos foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo temática, conforme Bardin. Os dados quantitativos foram organizados e analisados de forma descritiva, com cálculo de frequências e percentuais. **Resultados:** O primeiro questionário contou com 34 participantes. Evidenciaram-se fragilidades no processo de inserção e apoio institucional, com 63,6% relatando ausência de capacitação formal no ingresso e 45,5% referindo não ter recebido material estruturado de apoio. Observou-se heterogeneidade na autopercepção de aptidão para encaminhamentos, com maior segurança em agravos mais prevalentes e lacunas em temáticas específicas. O segundo questionário foi respondido por 7 participantes e revelou alta aceitação da ferramenta, destacando seu potencial como instrumento centralizado e aplicável à prática cotidiana. As sugestões apontaram para ajustes na organização visual e na padronização das informações. **Conclusão:** A fragmentação das informações e a dificuldade de acesso a materiais técnicos impactam a organização do trabalho e a tomada de decisão na APS. O guia digital constitui-se como ferramenta de apoio à qualificação da prática profissional, ao planejamento das ações em saúde e ao fortalecimento da coordenação do cuidado no contexto da Atenção Primária à Saúde em Porto Alegre. Como produto técnico desenvolvido no Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, foi elaborado um guia – *Portas Abertas: Guia Prático sobre fluxos na APS de Porto Alegre* - em formato de site com o objetivo de apoiar os profissionais das unidades de saúde. O conteúdo foi estruturado de forma sistematizada, possibilitando consulta rápida aos fluxos assistenciais e aos direcionamentos necessários para a tomada de decisão no cotidiano do trabalho na Atenção Primária à Saúde.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Guia; Processo de Trabalho.

ABSTRACT

Introduction: Primary Health Care (PHC) is the main entry point to the Brazilian Unified Health System (SUS) and plays a strategic role in care coordination, organization of Health Care Networks, and in responding to population needs based on the territory. **Objective:** To understand the main difficulties and needs of Primary Health Care (PHC) professionals in Porto Alegre regarding the organization and use of work processes and care flows, in order to support the development of a technical-institutional support tool aimed at improving practices and qualifying actions within PHC. **Methodology:** This is an applied study with a qualitative and quantitative approach, conducted with physicians and nurses working in Primary Health Care in Porto Alegre. Data collection was carried out through two online questionnaires developed using Google Forms. The first instrument included closed and open-ended questions addressing sociodemographic and professional characteristics, perceptions regarding entry into PHC, difficulties related to care flows, and self-perceived aptitude for referrals in priority health topics. The second instrument consisted of an evaluation of a preliminary version of a digital guide, including Likert-scale items and open-ended questions for suggestions. **Data analysis:** Qualitative data were analyzed using thematic content analysis according to Bardin. Quantitative data were organized and analyzed descriptively, with calculation of frequencies and percentages. **Results:** Thirty-four professionals participated in the first questionnaire. The findings revealed weaknesses in the process of professional integration and institutional support, with 63.6% reporting absence of formal training upon entry and 45.5% indicating lack of structured support materials. Heterogeneity was observed in self-perceived aptitude for referrals, with greater confidence in more prevalent conditions and gaps in specific thematic areas. The second questionnaire was completed by seven participants and demonstrated high acceptance of the tool, highlighting its potential as a centralized and practical resource. Suggestions pointed to improvements in visual organization and information standardization. **Conclusion:** The fragmentation of information and difficulties in accessing technical materials negatively impact work organization and decision-making in PHC. The digital guide constitutes a support tool for professional qualification, health planning, and strengthening care coordination in the context of Primary Health Care in Porto Alegre. As a technical product developed within the Professional Master's Program (PPGENSAU), a website-based guide was created to support health professionals, offering a systematized structure for quick consultation of care flows and decision-making pathways in daily practice.

Keywords: Primary Health Care; Guide; Work Process

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Rede SUS POA	21
Figura 2. Mapa das Coordenadorias de Saúde de POA	24
Gráfico 1. Distribuição do número de nascidos vivos (NV) POA 2001-2024	27
Gráfico 2. População Idosa (60+) por Sexo - 2010 e 2022	28
Gráfico 3. Índice de Envelhecimento por cor ou raça - 2010 e 2022	29
Figura 3. Questão 1	40
Figura 4. Questão 2	41
Figura 5. Questão 3	43
Figura 6. Questão 4	44
Figura 7. Questão 5	46
Figura 8. Questão 6	47
Figura 9. Questão 9.1	52
Figura 10. Questão 9.2	53
Figura 11. Questão 9.3	54
Figura 12. Questão 9.4	55
Figura 13. Questão 9.5	56
Figura 14. Questão 9.6	57
Figura 15. Questão 9.7	58
Figura 16. Questão 9.8	59
Figura 17. Questão 9.9	60
Figura 18. Questão 9.10	61
Figura 19. Questão 9.11	62
Figura 20. Captura de tela “Capa” na versão preliminar do guia Portas Abertas	67
Figura 21. Captura de tela ao clicar no agravo “HIV” na versão preliminar do guia digital Portas Abertas	68
Figura 22. Captura de tela da aba “HIV – Suspeita” na versão preliminar do guia.	68
Figura 23. Captura de tela ao clicar no agravo “HIV-Confirmado” na versão preliminar do guia digital Portas Abertas	69
Figura 24. Captura de tela ao clicar no agravo “SÍFILIS” na versão preliminar do guia digital Portas Abertas	69
Figura 25. Captura de tela da aba “Sífilis Adquirida” na versão preliminar do guia.	70

Figura 26. Questão II da avaliação do guia no Questionário 2.	72
Figura 27. Distribuição das respostas na parte II na avaliação do guia quanto à relevância, clareza e aplicabilidade, conforme Questionário 2.	73
Figura 28. Questão 1 da seção III da avaliação do guia no Questionário 2.	74
Figura 29. Questão 2 da seção III da avaliação do guia no Questionário 2.	75
Figura 30. Captura de tela da busca por “hanseníase” no site BVAPS de POA	82
Figura 31. Captura de tela da busca por “tuberculose” no site BVAPS de POA	83
Figura 32. Captura de tela da busca por “tuberculose” no site BVAPS de Porto Alegre na aba Protocolos de Enfermagem	83
Figura 33. Captura de tela da busca por “Serviços Laboratoriais” no site BVAPS de Porto Alegre	84
Figura 34. Captura de tela da busca por “Políticas-População Negra” no site BVAPS de Porto Alegre.	85
Figura 35. Captura de tela do site “Assistência Laboratorial” de Porto Alegre	86
Figura 36. Captura de tela da busca por “Tabagismo” no site BVAPS de POA	87
Figura 37. Captura de tela da busca por “Programa Saúde na Escola” no site BVAPS de Porto Alegre	88
Figura 38. Captura de tela da busca por “Imunizações” no site da Vigilância de Porto Alegre	89
Figura 39. Digitalização de esboço inicial da estrutura do guia, elaborado pela autora.	91
Figura 40. Digitalização de esboço inicial da estrutura do guia, elaborado pela autora.	92
Figura 41. Digitalização de esboço inicial da estrutura do guia, elaborado pela autora.	93
Figura 42. Digitalização de esboço inicial da estrutura do guia, elaborado pela autora.	94

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Descrição do Produto Técnico Final	39
Quadro 2. Síntese de sugestões dos participantes e dos encaminhamentos após análise.	76

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Cenário Atual das US de APS de Porto Alegre	24
Tabela 2. Índice de Envelhecimento por Distrito Sanitário, Porto Alegre, 2020	28
Tabela 3. Tabela comparativa – Questões 9.1 a 9.11	63

ABREVIATURAS

APS: Atenção Primária à Saúde

ACE : Agente de combate à Endemias

ACS: Agente Comunitário de Saúde

BVAPS: Biblioteca Virtual da Atenção Primária à Saúde

CAIST: Coordenação de atenção a tuberculose e infecções transmissíveis

DAPS: Diretoria da Atenção Primária em Saúde

EPS: Educação Permanente em Saúde

ESF: Estratégia de Saúde da Família

GAL: Gerenciador de Ambiente Laboratorial

GERCON: Gerenciamento de Consultas

NASF: Núcleo de Apoio à Saúde da Família

OSC: Organizações da Sociedade Civil

PMPA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

PNAB: Política Nacional de Atenção Básica

POA: Porto Alegre

SUS: Sistema Único de Saúde

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	15
1.2 OBJETIVOS	18
1.2.1 OBJETIVO GERAL	18
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	18
2 REFERENCIAL TEÓRICO	19
3 METODOLOGIA	37
4 IMPACTOS ACADÊMICOS E SOCIAIS DO TRABALHO	40
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO	43
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	100
REFERÊNCIAS	102
APÊNDICE A - Questionário 1	108
APÊNDICE B - Questionário 2	111
APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO	111
APÊNDICE D – PRODUTO	113

1 INTRODUÇÃO

A Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil é compreendida como o conjunto de ações individuais e coletivas que envolvem promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Constitui-se como porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), exercendo papel central na coordenação e ordenação do cuidado nos diferentes níveis de atenção.

A APS desenvolve-se por meio de práticas gerenciais e assistenciais, orientadas pelos princípios da participação social e do trabalho em equipe, direcionadas a populações de territórios definidos, pelos quais as equipes assumem responsabilidade sanitária (Brasil, 2017).

No campo conceitual, a APS é definida como o primeiro nível de contato dos indivíduos, das famílias e da comunidade com o sistema de saúde, sendo caracterizada por atributos essenciais como acesso, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado (Starfield, 2002). Conforme a autora, esse nível de atenção “oferece a entrada no sistema para todas as novas necessidades e problemas, fornecendo atenção sobre a pessoa [...] no decorrer do tempo” (Starfield, 2002, p. 28), o que reforça seu papel estruturante na organização dos sistemas de saúde orientados pela integralidade.

No contexto brasileiro, a Estratégia Saúde da Família (ESF) constitui o principal modelo de operacionalização da APS, ao propor a reorientação do modelo assistencial e a consolidação dos princípios da universalidade, da equidade e da integralidade que fundamentam o SUS (Brasil, 2017; Giovanella; Mendes, 2018). Apesar dos avanços alcançados desde sua implementação, persistem desafios estruturais e organizacionais que impactam diretamente o processo de trabalho das equipes e a qualidade da atenção ofertada à população.

Entre esses desafios, destacam-se aqueles relacionados à formação, à qualificação e à organização do processo de trabalho dos profissionais de saúde (E-book 2 e-SUS Profissionais de Saúde, 2024). A qualificação profissional figura como um dos principais entraves à consolidação de uma APS resolutiva, sendo necessária a construção de estratégias que possibilitem respostas mais adequadas às necessidades dos usuários, considerando a complexidade dos territórios e das demandas em saúde (Oliveira; Pereira, 2013).

Entretanto, a crescente demanda nos serviços de APS tem gerado sobrecarga das equipes multiprofissionais, comprometendo a qualidade da assistência e o alcance da integralidade do cuidado. Nesse contexto, a reorganização dos fluxos de trabalho apresenta-se

como alternativa necessária para otimizar recursos, reduzir gargalos assistenciais e ampliar a resolutividade do atendimento.

A atualização permanente dos profissionais de saúde é um desafio para a gestão, pois, além da velocidade com que conhecimentos e saberes tecnológicos se renovam na área da saúde, a distribuição de profissionais e de serviços, segundo o princípio da acessibilidade, torna o processo ainda mais complexo. Nessa busca constante por atualização, torna-se crucial o desenvolvimento de recursos tecnológicos que qualifiquem a organização do trabalho, fundamentados na noção de aprender a aprender, de trabalhar em equipe e de transformar o cotidiano em objeto de aprendizagem individual, coletiva e institucional. (Ceccim, 2005) Há inúmeras dificuldades a serem transpostas para efetivação desta atualização profissional tais como a falta de ferramentas que auxiliem a gestão na operacionalização do proposto na Política, a necessidade de articulação entre os níveis de gestão, a falta de profissionais qualificados e de adesão desses para as atividades educacionais, a falta de planejamento pelos gerentes de unidades, a rotatividade dos profissionais devido ao vínculo superficial com o serviço, a baixa participação do controle social e o enfoque de trabalho fragmentado por profissões.

Essas são dificuldades que precisam ser enfrentadas e repensadas no sentido de mudanças efetivas para que possamos evoluir nesta política de Educação, pois de acordo com a perspectiva do Sistema Único de Saúde (SUS) e da transformação das práticas de saúde, coloca-se a necessidade de ampliação do debate em torno da EPS como política. (Ceccim, 2005; Peduzzi et al., 2009).

A autora desta pesquisa exerce a profissão de enfermeira na Atenção Primária à Saúde (APS) em Porto Alegre desde 2017 e, desde 2022, atua como assessoria na gestão. Essa trajetória possibilitou refletir sobre as próprias dificuldades enfrentadas ao ingressar na APS e reconhecer que muitos profissionais recém-chegados vivenciam desafios semelhantes, especialmente diante das dúvidas recorrentes sobre os processos de trabalho. A partir dessa percepção, emergiu a necessidade de criar um espaço que reúna, de maneira organizada e acessível, informações e orientações sobre os principais temas da APS, de modo a facilitar o cotidiano profissional, qualificar os encaminhamentos e otimizar o tempo de trabalho, contribuindo para uma APS mais resolutiva e fortalecida.

Apesar de contarmos com a Biblioteca Virtual de APS na capital (BVAPS), os conteúdos estão organizados por temáticas que nem sempre facilitam a consulta, e parte do material

disponível precisa de atualização. Diante disso, percebe-se a necessidade de construir uma forma mais prática e integrada de apoiar os profissionais no desempenho de suas atividades.

Entre os benefícios esperados com esta pesquisa, destaca-se a qualificação dos profissionais ao ingressarem na APS, promovendo maior segurança no cotidiano de trabalho e reduzindo a ocorrência de erros. Espera-se também contribuir para o fortalecimento das práticas e para o aprendizado contínuo, estimulando o aprimoramento profissional e a tomada de decisões mais seguras.

Diante desse contexto, formula-se a seguinte questão de pesquisa: Como auxiliar os profissionais da Atenção Primária à Saúde de Porto Alegre na organização e utilização dos fluxos de trabalho, considerando suas principais dificuldades e necessidades?

Para responder à questão proposta, definiram-se os seguintes objetivos:

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 OBJETIVO GERAL

Compreender as principais dificuldades e necessidades dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) de Porto Alegre em relação à organização e utilização dos fluxos de trabalho, a fim de subsidiar a elaboração de uma ferramenta de apoio técnico-institucional que contribua para o aprimoramento das práticas e para a qualificação das ações na APS.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais da APS de Porto Alegre na organização e utilização dos fluxos de trabalho;
- Mapear as necessidades relacionadas ao acesso, à clareza e à aplicabilidade dos fluxos assistenciais no cotidiano dos serviços;
- Analisar as percepções dos profissionais acerca da organização do processo de trabalho e da utilização dos fluxos na APS;
- Elaborar uma ferramenta de apoio técnico-institucional sobre fluxos de trabalho na APS de Porto Alegre, com base nos resultados da pesquisa;
- Contribuir para a qualificação dos processos de trabalho e dos atendimentos na APS, promovendo maior resolutividade e integração das ações de saúde.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ATENÇÃO PRIMÁRIA

A Atenção Primária à Saúde (APS) abrange serviços que visam à atenção integral ao usuário e/ou comunidade, dentre os quais estão inclusos, a promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação da saúde. É a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), constituindo como primeiro nível de atenção e centro de comunicação com todas as ações e serviços da Rede de Atenção à Saúde (Brasil, 2023).

O SUS é orientado pelos princípios da universalidade, da integralidade e da equidade como modelo de cuidados. O foco na APS representa a conformidade com estes princípios, seguindo exemplos de sistemas de saúde que vinham adotando cuidados primários para qualificar o bem-estar da população, como o modelo cubano e britânico (Côrtes, 2009).

Uma atenção primária à saúde, na perspectiva das redes de atenção à saúde, deve cumprir três funções essenciais que lhe imprimem a característica de uma estratégia de ordenação dos sistemas de atenção à saúde: a função resolutiva de atender a 85% dos problemas mais comuns de saúde; a função ordenadora de coordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e informações nas redes; e a função de responsabilização pela saúde da população usuária que está adscrita, nas redes de atenção à saúde, às equipes de cuidados primários. Só será possível organizar o SUS em redes de atenção à saúde se a atenção primária à saúde estiver capacitada a desempenhar adequadamente essas três funções. Só assim, ela poderá coordenar as redes de atenção à saúde e constituir a estratégia de reordenamento do SUS. (Mendes, 2012) Estas três funções só podem ser plenamente alcançadas com processos de trabalho bem delineados e capacitações destes profissionais que atuam na APS.

2.1.2 ATENÇÃO PRIMÁRIA NO BRASIL

A Atenção Primária à Saúde vem sendo apresentada, desde a década de 1960, como uma estratégia nacional de saúde baseada em um modelo preventivo, coletivo e democrático, adotado por diversos países, incluindo o Brasil (Fausto; Matta, 2007). Ao longo das últimas décadas, acumulou-se um conjunto de evidências demonstrando que países com sistemas de

cuidados primários fortes apresentam sistemas de saúde mais efetivos, eficientes, com melhor qualidade e maior equidade quando comparados aqueles com cuidados primários frágeis (Mendes, 2012). Essa relação é amplamente discutida por Starfield (2002), ao destacar que sistemas orientados por uma APS forte, baseada em atributos como primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado, produzem melhores resultados em saúde e maior equidade (Starfield, 2002).

No contexto brasileiro, a Atenção Primária à Saúde estruturou-se prioritariamente a partir da Estratégia Saúde da Família (ESF), assumindo uma conformação fortemente territorializada. Sua rede é composta por numerosas unidades distribuídas no espaço urbano, o que assegura ampla capilaridade e proximidade com a população. Essa organização busca ofertar uma atenção integral, com potencial para produzir impactos positivos tanto na saúde individual quanto na saúde coletiva (Giovanella; Franco; Almeida, 2020).

As diversas experiências de organização e oferta da APS no sistema de saúde brasileiro convergiram, a partir dos anos 1990, para o modelo de Saúde da Família, adotado como estratégia prioritária para a expansão e consolidação da APS no país. A ESF passou a ser considerada a principal vertente da Atenção Primária, com o objetivo de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), reorganizando as práticas de cuidado e substituindo o modelo tradicional, aproximando os serviços de saúde das famílias e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Nesse sentido, a Política Nacional de Atenção Básica enfatiza a responsabilidade compartilhada entre as diferentes esferas de governo no apoio e estímulo à adoção da ESF como estratégia prioritária de expansão, consolidação e qualificação da Atenção Básica, cabendo às Secretarias Municipais de Saúde incorporá-la como eixo organizador de suas redes de serviços (Brasil, 2011).

O modelo brasileiro de Saúde da Família pode ser considerado autóctone, ainda que tenha recebido influências externas relevantes. Seu protagonismo decorre, sobretudo, do fato de não se constituir como uma proposta restrita à medicina familiar, mas como uma política pública voltada à saúde da família. O Programa Saúde da Família (PSF) distanciou-se dos modelos de medicina familiar predominantes nos países desenvolvidos, que, em geral, se organizam em torno do papel central do médico generalista ou de família (Mendes, 2012).

Apesar dos avanços, a universalidade do SUS enfrenta limites impostos pela escassez de recursos, o que tem levado à adoção de estratégias de direcionamento do acesso aos serviços.

Nesse cenário, emergem políticas seletivas focalizadas em grupos populacionais mais vulneráveis, resultando em um universalismo básico e restrito (Giovanella, 2018). Essa lógica tensiona o princípio da integralidade, uma vez que as necessidades de saúde extrapolam recortes programáticos e seletivos e demandam respostas mais abrangentes por parte do sistema de saúde (Cecílio, 2011). Alguns anos após a Conferência de Alma-Ata, o conceito de Primary Health Care (PHC), originalmente associado a uma abordagem abrangente, passou a assumir uma perspectiva mais seletiva, voltada principalmente às populações mais pobres. Tal inflexão esteve relacionada, em grande medida, às expectativas das agências financiadoras por soluções rápidas e de curto prazo, em contraposição à necessidade de transformações estruturais para o enfrentamento das desigualdades em saúde (Melo et al., 2019).

À medida que se ampliam as flexibilizações no modelo de atenção, observa-se também uma maior abertura para a articulação com o setor privado na prestação de serviços. Esse movimento explicita o tensionamento existente em torno do modelo de cuidado adotado pela APS, seja ele seletivo ou abrangente. Tal cenário pode favorecer a implementação de serviços focalizados nos grupos mais vulneráveis, em detrimento da lógica fundante da ESF, que propõe um cuidado integral voltado ao indivíduo, à família e à comunidade, em consonância com os princípios do SUS (Martins; Carbonai, 2021).

Nesse contexto, Mendes (2012) destaca a necessidade de uma ruptura ideológica com as concepções de atenção primária seletiva e com a compreensão da APS apenas como um nível de atenção. O autor defende o enfrentamento da ideia de uma atenção primária pobre para populações pobres, ressaltando que um país com a dimensão econômica e social do Brasil não pode se contentar com modelos restritivos, retomando o ensinamento de Beveridge (1942) de que políticas públicas exclusivas para os pobres tendem a resultar em políticas pobres.

Desde a Conferência de Alma-Ata, foram definidos elementos essenciais da APS, que incluem a educação em saúde, o saneamento básico, o cuidado materno-infantil, com ênfase na imunização e no planejamento familiar, a prevenção de endemias, o tratamento adequado das doenças mais comuns, a provisão de medicamentos essenciais, a promoção da alimentação saudável e a valorização das práticas complementares, reafirmando a saúde como expressão de um direito humano (Mendes, 2012). Esses princípios foram reafirmados e atualizados na Declaração de Astana, que reforça a APS como base dos sistemas de saúde universais, equitativos e sustentáveis no contexto contemporâneo (OMS, 2018).

Em 2017, o Brasil vivenciou uma orientação normativa do Ministério da Saúde voltada à reforma da Atenção Primária à Saúde, tendo a Estratégia Saúde da Família como base, com apoio de especialistas e instituições de ensino e pesquisa, com o objetivo de fortalecer a APS como porta de entrada resolutive do sistema de saúde. No entanto, passados alguns anos, o país ainda enfrenta dificuldades relacionadas à definição clara dos papéis entre os diferentes tipos de serviços de saúde, o que compromete a organização do sistema de forma integrada e coordenada (Portela, 2017).

Esse cenário se agrava diante de uma situação de saúde marcada por uma transição demográfica acelerada e por uma transição epidemiológica singular, expressa na tripla carga de doenças. Persistem doenças infecciosas e carenciais não superadas, coexistindo com uma carga relevante de causas externas e com a hegemonia crescente das condições crônicas (Mendes, 2012).

Por fim, é importante destacar que o trabalho em saúde se caracteriza por intensas relações intersubjetivas, presentes tanto no encontro entre profissionais e usuários quanto nas relações estabelecidas entre os diferentes trabalhadores que compõem as equipes e instituições de saúde. Nessas interações, o cuidado é produzido no encontro entre sujeitos, mobilizando diferentes tecnologias do trabalho vivo em ato, o que influencia diretamente a produção do cuidado na Atenção Primária à Saúde (Pires, 2000; Merhy, 2014).

2.1.3 Atenção Primária em Porto Alegre

O município de Porto Alegre possui uma área de 496,684km², dividida em um centro urbano que ocupa em torno de 65% do seu território e uma extensa área rural, com cerca de 30%; a segunda maior área rural entre as capitais. Aproximadamente 44 km² estão distribuídos em 16 ilhas do Lago Guaíba sob jurisdição do município. O Lago contorna a cidade numa extensão de 70 km de orla fluvial, a expressão geográfica mais marcante da capital gaúcha. (Plano Municipal de Saúde 2022-2025).

Figura 1: Rede SUS Porto Alegre 2024



Fonte: Apresentação DAPS em Reunião Geral 2024 (Plano Municipal de Porto Alegre 2022-2025)

Organograma da APS de Porto Alegre é constituído por 132 Unidades de Saúde, sendo 12 Clínicas da Família, 1 Unidade de Saúde Indígena Kaingang e 1 Equipe Consultório na Rua e 1 Unidade Móvel. (Prefeitura Municipal de POA, 2024)

Devido a esse grande número de Unidades de serviço que compõem a rede de Porto Alegre faz-se necessário que pensemos em um modelo de educação e atualização de processos de trabalho constantes.

A Atenção Primária à Saúde é o conjunto de ações em saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e realizada por equipes multiprofissionais, dirigida para uma população em território definido sob responsabilidade das equipes de saúde. É norteada pela Política de Atenção Primária do Município de Porto Alegre (2024), que visa delimitar princípios e diretrizes gerais de organização dos serviços. Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde vemse consolidando como a forma mais eficiente de organização dos Serviços de Saúde enquanto ordenadora da rede e coordenadora do cuidado, sendo constituída por equipe multidisciplinar que deve cobrir toda a população, integrando, coordenando o cuidado e

atendendo as necessidades de saúde da população bem como resolvendo a maioria dos problemas de saúde.

Porto Alegre iniciou a implantação do Programa de Saúde da Família (PSF) em 1995, caracterizado pela forte participação popular e pela atuação ativa dos conselhos de saúde locais, distritais, embora hoje um pouco enfraquecidos, conta com um municipal exercendo um papel essencial na defesa de uma Atenção Primária à Saúde pública, integral e comprometida com a valorização dos direitos de suas trabalhadoras e trabalhadores. (Carneiro,2023)

A ESF deve acompanhar as condições de saúde da população do seu território e através do ACS deve realizar o cadastro das famílias, registrar os problemas familiares e sanitários e orientar as pessoas sobre ações de cuidado à saúde (Brasil,2017).

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) de 2017 estabelece que a equipe de Saúde da Família deve ser composta, minimamente, por médico, preferencialmente com especialização em Medicina de Família e Comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em Saúde da Família, auxiliar e ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS). Poderão ainda integrar a equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de saúde bucal, incluindo cirurgião-dentista, auxiliar ou técnico em saúde bucal. A normativa define que cada equipe deve ser responsável por um território com população adscrita entre 2.000 e 3.500 pessoas, e que cada ACS acompanhe, em média, até 750 pessoas (Brasil, 2017).

Entretanto, diferentemente da PNAB de 2012, que estabelecia parâmetros mínimos e máximos para a composição de ACS nas equipes, variando de quatro a doze profissionais por equipe (Brasil, 2012), a versão de 2017 suprimiu a exigência de um número mínimo de agentes comunitários. Essa alteração introduz maior flexibilidade na organização local das equipes, mas também tem sido analisada criticamente na literatura, que aponta possíveis repercussões sobre a territorialização e o vínculo comunitário, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade social (Baratieri et al., 2018; Melo et al., 2018).

Ao reduzir a exigência mínima de ACS por equipe, essa normativa criou condições para a diminuição desse profissional na Atenção Primária, com impactos na dimensão territorial do cuidado (Martins; Carbonai, 2021). No município de Porto Alegre, esse cenário foi intensificado pela extinção do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (IMESF), em 2019, que resultou, em 2020, na demissão de 552 trabalhadores, entre eles agentes comunitários de saúde, além de técnicos e enfermeiros (Krieger; Todeschini, 2021). Esse processo contribuiu para um

contexto de escassez de ACS na APS, repercutindo no trabalho junto ao território, na construção de vínculos com as famílias e na capacidade de acompanhamento longitudinal das equipes.

A demissão dos Agentes Comunitários de Saúde vinculados ao extinto IMESF, com posterior reintegração parcial por decisão judicial e enquadramento em cargos celetistas em extinção, produziu impactos na configuração das equipes de Atenção Primária. A redução do número de ACS, associada à ampliação de equipes com arranjo organizacional, sinaliza mudanças no modelo assistencial adotado, com repercussões sobre a centralidade da Estratégia Saúde da Família e sobre atributos como territorialização e vínculo. Parte da literatura analisa esse movimento como um tensionamento entre diferentes concepções de organização da APS, com possíveis efeitos sobre a integralidade e a universalidade do cuidado. Paralelamente, registram-se mobilizações de trabalhadores e usuários, com apoio do Conselho Municipal de Saúde, no acompanhamento e debate dessas transformações (Carneiro, 2023).

A Lei nº 13.019 instituiu o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), estabelecendo regras para parcerias entre a administração pública e as OSCs, por meio de instrumentos como termo de colaboração e termo de fomento. No campo da saúde, essa legislação passou a fundamentar juridicamente a contratualização de serviços e equipes no âmbito do SUS.

No município de Porto Alegre, a regulamentação local das parcerias foi formalizada por meio da Lei nº 12.701, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a administração pública municipal e as OSCs. Essa normativa passou a estruturar a forma como serviços e equipes, inclusive na Atenção Primária, podem ser executados por entidades parceiras.

Embora Porto Alegre já utilizasse alguns tipos contratos pontuais, a mudança estrutural ocorreu a partir de setembro de 2019, com a decisão do STF sobre a inconstitucionalidade da criação do IMESF (Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família). Isso levou à demissão em massa de trabalhadores celetistas públicos e à necessidade de uma substituição rápida do modelo de gestão para evitar o colapso do sistema.

De certa forma, podemos organizar Porto Alegre em 4 modelos que coexistem na Atenção Primária. (Porto Alegre, Relatório de Gestão, 2023).

- Gestão Indireta por Lotes (86% da rede): Gerida pelas OSCs AHVN (Sul, Centro-Sul, Restinga e Extremo-Sul), Santa Casa (Norte, Eixo Baltazar, Humaitá/Navegantes e Ilhas), Divina Providência (Leste, Nordeste, Partenon e Lomba do Pinheiro), IB Saúde (Glória/Centro/Cruzeiro/Cristal));

- Gestão Direta Federal (GHC): 12 unidades na Zona Norte e Leste;
- Parceria Acadêmica (Vila Fátima/PUCRS e Santa Cecília/Clínicas): Zona Leste e oeste
- Gestão Municipal: Equipes de servidores estatutários que ainda atuam na rede nas Unidades Bananeiras, Modelo, IAPI, Camaquã e Belém Novo.

A seguir, tabela com a quantidade de Unidades de Saúde por OSCs.

Tabela 1: Cenário Atual das US de APS de Porto Alegre

Entidade/Organização Social	Nº de Unidades de Saúde
Prefeitura Municipal de Porto Alegre	5
Grupo Hospitalar Conceição	12
Hospital de Clínicas de Porto Alegre	1
Hospital São Lucas/PUC	1
IBSAÚDE	19
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre	27
Hospital Divina Providência	38
Hospital Vila Nova	29
Total	132

Fonte: DAPS - CNES/2025.

Fonte: Plano Municipal de Saúde 2026-2029 (CNES/2025)

A seguir, o mapa de Porto Alegre com a divisão por Coordenadorias de Saúde.

Figura 2: Mapa das Coordenadorias de Saúde de Porto Alegre



Fonte: Plano Municipal de Porto Alegre 2022-2025

Recentemente, o governo federal lança através da Portaria GM/MS nº635 de 22 de maio de 2023 a criação das Equipes Emulti com o intuito de realizar atendimento e ações em conjunto

com as demais equipes de saúde que atuam na APS, além de ampliar o leque de práticas em saúde no território e ofertar um cuidado integral para a comunidade, melhorando o acompanhamento em saúde dos usuários e resolubilidade. (Brasil,2023)

Nesse sentido, o Ministério da Saúde pretende facilitar o acesso da população aos cuidados em saúde, por meio do trabalho colaborativo entre profissionais das eMulti e das outras equipes de saúde da APS, impulsionando o cuidado compartilhado na Atenção Primária e buscando superar as barreiras na integração com os demais serviços das redes regionais, incorporando também saberes e práticas de especialistas e fortalecendo a atenção interprofissional no SUS. (Brasil,2023)

Desde março de 2024, Porto Alegre iniciou a incorporação de nove equipes multiprofissionais (eMulti) na rede municipal, ampliando esse quantitativo com a inclusão de mais seis equipes em setembro do mesmo ano. O município, com população estimada em 1,3 milhão de habitantes, apresenta taxa de cobertura da Atenção Primária à Saúde de 82,15%, com potencial de ampliação para 97,95%, sendo que aproximadamente 27% da população encontrase em situação de extrema vulnerabilidade. A previsão é de que 43% das equipes de APS contem com cobertura de eMulti, configurando importante estratégia de qualificação do cuidado frente às demandas territoriais. As nove primeiras equipes foram compostas por servidores estatutários municipais, enquanto as seis incorporadas posteriormente passaram a contar com profissionais vinculados a Organizações da Sociedade Civil (OSCs). (Seminário de Integração de Novas eMulti, Porto Alegre, 17 set. 2024; IBGE, 2021).

Atualmente, Porto Alegre vive uma transição nos contratos de gestão. Em janeiro de 2026, a Santa Casa e o Divina Providência anunciaram a rescisão de seus contratos, o que forçou a prefeitura a lançar o Edital de Chamamento Público nº 01/2026 para reorganizar a rede.

Na Atenção Primária à Saúde, o debate sobre organização do trabalho assume contornos próprios, uma vez que esse nível de atenção se estrutura sobre atributos como longitudinalidade, vínculo e coordenação do cuidado, conforme sistematizado por Barbara Starfield (2002). Tais atributos pressupõem continuidade assistencial e responsabilização sanitária sobre uma população adscrita, elementos centrais para a efetividade da APS. Na mesma direção, Eugênio Vilaça Mendes (2011) destaca que a Atenção Primária deve exercer a função de ordenadora das Redes de Atenção à Saúde, o que implica estabilidade das equipes, coordenação clínica e integração dos fluxos assistenciais no território.

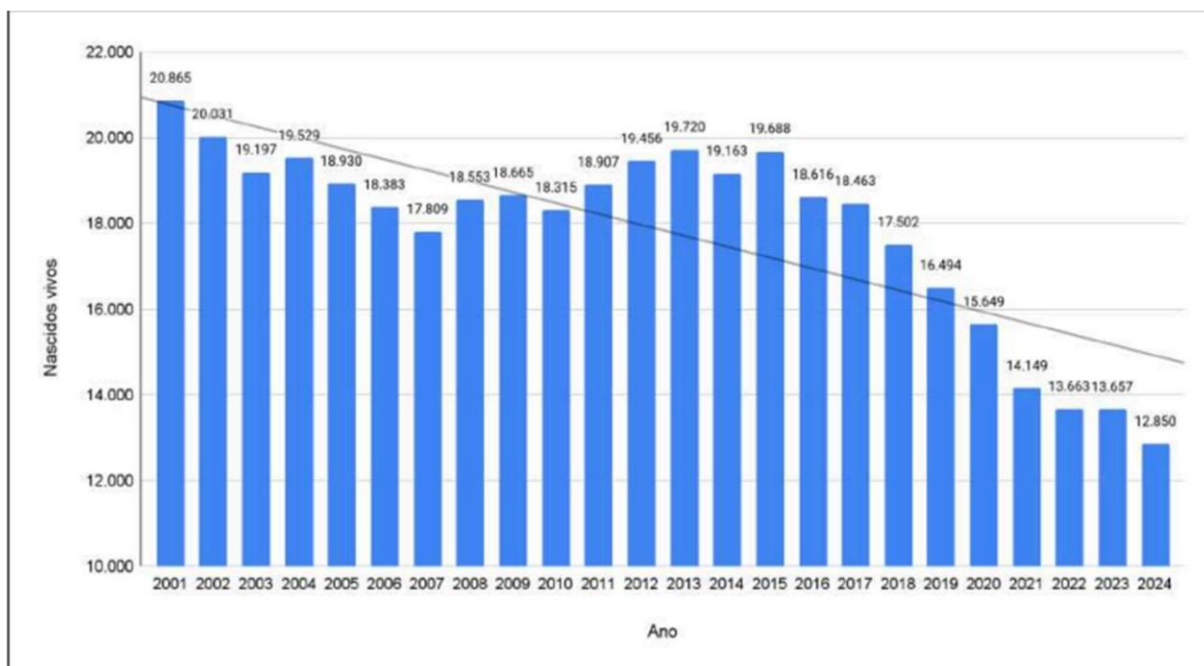
Sob o enfoque da gestão do trabalho em saúde, estudos de Maria Helena Machado (2014) indicam que vínculos instáveis, fragmentação contratual e elevada rotatividade contribuem para a descontinuidade dos processos assistenciais e para dificuldades na consolidação das equipes. Como a Atenção Primária à Saúde se organiza a partir da lógica territorial e da construção de vínculos de confiança com a população, essas condições podem repercutir na organização do processo de trabalho e na capacidade de coordenação do cuidado, sobretudo em territórios marcados por maior vulnerabilidade social (Giovanella et al., 2018).

Assim, o debate sobre precarização do trabalho ultrapassa a dimensão estritamente laboral e deve ser compreendido também à luz de seus efeitos na continuidade do cuidado e na sustentação dos atributos estruturantes da Atenção Primária, como longitudinalidade, vínculo e responsabilização sanitária.

A análise sobre organização do trabalho e sustentabilidade das equipes na Atenção Primária à Saúde também precisa ser situada no contexto das transformações demográficas e epidemiológicas em curso. O Brasil vivencia um processo acelerado de envelhecimento populacional, com aumento da expectativa de vida e crescimento da proporção de pessoas idosas, passando por um processo de transição epidemiológica na queda relativa das condições agudas e pelo aumento relativo das condições crônicas. (Mendes, 2012).

Em Porto Alegre percebe-se esta situação também, conforme gráfico abaixo, a partir de 2016, tem uma queda consistente nos nascimentos vivos, reduzindo cerca de 5 mil nascimentos. Conforme o Plano Municipal de Saúde (2022-2025) os motivos para essa diminuição são vários: maior escolarização, aumento do número de mulheres no mercado de trabalho, maior adesão ao uso de contraceptivos, entre outros.

Gráfico 1 - Distribuição do número de Nascidos Vivos (NV) Porto Alegre, 2001- 2024



Fonte: Plano Municipal de Porto Alegre 2026-2029 (Vitalis/SINASC/EVEV/DVS. Atualização em 01/09/2025)

O gráfico evidencia uma tendência consistente de redução no número de nascidos vivos ao longo do período analisado. Em 2001 foram registrados 20.865 nascimentos, enquanto em 2024 esse número caiu para 12.850, representando uma diminuição absoluta de 8.015 nascimentos. No intervalo de 23 anos, observa-se uma redução média aproximada de 348 nascimentos por ano. Em termos proporcionais, a queda acumulada no período foi de cerca de 38,4%, correspondendo a uma taxa média anual de decréscimo em torno de 2%.

Esses dados apontam para um processo contínuo de redução da natalidade, com implicações diretas na estrutura etária da população e no planejamento das políticas públicas, especialmente no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

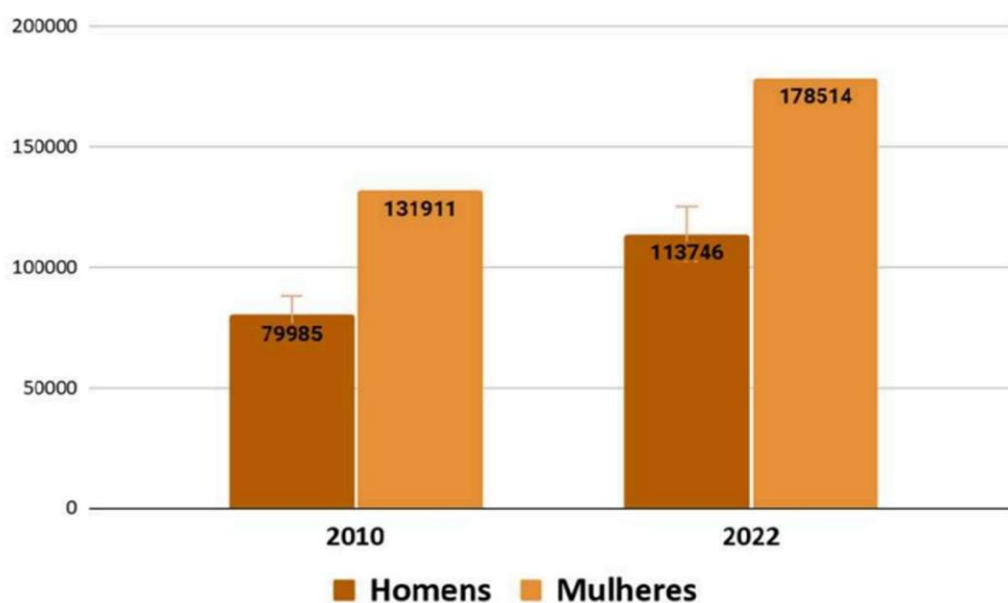
Tabela 2: Índice de Envelhecimento por Distrito Sanitário, Porto Alegre, 2020

Distrito Sanitário	Índice de Envelhecimento		Índice de envelhecimento (%)
	Pop. 0 a 14 anos (N)	Pop. 60 anos e mais (N)	
Centro	28.613	60.372	211%
Centro-sul	18.760	14.150	75%
Cristal	6.835	4.306	63%
Cruzeiro	13.344	8.376	63%
Eixo Baltazar	19.124	11.458	60%
Extremo Sul	7.838	4.073	52%
Glória	12.760	6.398	50%
Humaitá Navegantes	9.307	6.189	66%
Ilhas	2.373	803	34%
Leste	22.824	15.366	67%
Lomba Do Pinheiro	15.314	4.952	32%
Nordeste	10.743	2.313	22%
Noroeste	17.894	26.501	148%
Norte	21.787	12.520	57%
Partenon	23.614	15.168	64%
Restinga	16.239	5.786	36%
Sul	16.795	12.882	77%
Porto Alegre	264.163	211.614	80%

Fonte: Plano Municipal de Porto Alegre 2022-2025 (IBGE: Censo Demográfico 2010)

Segue abaixo gráfico demonstrando o envelhecimento da população da capital entre os anos de 2010 e 2022.

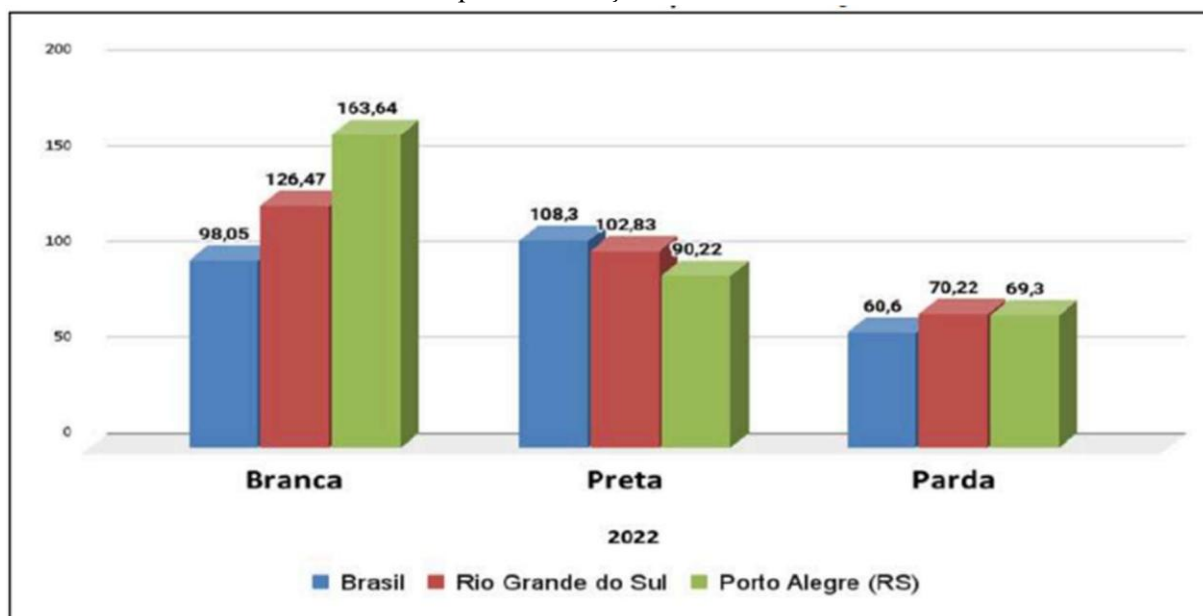
Gráfico 2: População Idosa (60+) por Sexo - 2010 e 2022



Fonte: Plano Municipal de Porto Alegre 2026-2029 (IBGE – Censos Demográficos de 2010 e 2022)

A análise do índice de envelhecimento em Porto Alegre, que alcança 136,84, indica que para cada 100 crianças de 0 a 14 anos há aproximadamente 137 pessoas idosas. Esse dado evidencia que o município já apresenta maior contingente populacional com 65 anos ou mais, estimado em 232 mil pessoas, em comparação ao total de crianças de 0 a 14 anos, que soma cerca de 224 mil.

Gráfico 3: Índice de Envelhecimento por cor ou raça - 2010 e 2022



Fonte: Plano Municipal de Porto Alegre 2026-2029 (IBGE – Censos Demográficos de 2010 e 2022)

Percebe-se que as desigualdades raciais impactam os índices de envelhecimento, evidenciando diferenças entre a distribuição da população por cor ou raça na população geral e no grupo de pessoas idosas. Ao analisar especificamente a população preta e parda, observa-se um índice de envelhecimento inferior ao da população geral, o que revela iniquidades no processo de envelhecimento. Esse cenário reforça a necessidade de formulação e implementação de políticas públicas que atuem sobre os determinantes sociais da saúde, considerando as especificidades dessa população e os efeitos do racismo estrutural nas condições de vida, no adoecimento e na expectativa de vida (Werneck, 2016).

Nesse contexto, a APS assume papel estratégico na coordenação do cuidado, no acompanhamento longitudinal e na organização das respostas às necessidades complexas da população, o que recoloca no centro do debate a capacidade instalada das equipes, a continuidade assistencial e a articulação em rede.

A flexibilização entre Estado e parcerias promoveu uma redução nos gastos sociais e precarizou as condições de trabalho dos profissionais (Menicucci; Gomes, 2018), além de alterar a operação dos cuidados à saúde. No contexto local de Porto Alegre, além das consequências das reformas no Governo Federal, o município passou por uma fase de transição em relação ao órgão responsável pela gestão, coordenação e contratação das equipes de APS, indicando uma ampliação da participação de Organizações Sociais (OS) na prestação destes serviços. (Giovanella, 2018)

A ampliação da contratualização da saúde no município de Porto Alegre com as OSC apresenta grande rotatividade em todas as categorias profissionais, fazendo com que as equipes não consigam se estabelecer por tempo suficiente à organização de processos de trabalho e capacitação do cuidado, a descontinuidade e falta de vinculação às unidades de saúde compromete a longitudinalidade dos cuidados básicos de saúde em fase de mudança demográfica importante, com maior envelhecimento populacional e incidência de doenças crônicas, sem aderência do paciente aos cuidados e recomendações da equipe de saúde, fica comprometida a prevenção e, não se atuando efetivamente nas complicações evitáveis no nível primário, sobrecarrega-se a demanda por mais consultas em média e alta complexidade, emergências, internações o que provoca a insustentabilidade do sistema como um todo, desorganizando a rede como um todo. (Melo, 2023)

Os serviços de saúde operam em uma lógica intrinsecamente complexa: os novos modelos híbridos de gestão intensificam essa complexidade, exigindo a coordenação de múltiplos agentes e instituições. Nessa realidade, os sistemas de saúde demandam cada vez mais um monitoramento sistemático. Além disso, é fundamental que o Estado tenha elevada capacidade regulatória, para evitar que disfunções ou falhas de mercado se aprofundem e comprometam os objetivos do modelo. (Neves; Guimarães; Júnior, 2017)

Com o objetivo de qualificar os serviços e assegurar o cuidado integral às pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde ao longo de todas as fases da vida, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre organiza sua rede de atenção a partir de alguns eixos estruturantes. Entre eles estão a ampliação do acesso à assistência, considerando as necessidades específicas de cada pessoa, a integração entre os diferentes pontos da rede assistencial, como a atenção primária, as especialidades ambulatoriais, os serviços de urgência e a atenção hospitalar, além da definição de fluxos e regras que garantam um cuidado contínuo e organizado. Também se

destacam as ações voltadas à promoção da saúde, à prevenção de agravos e à vigilância em saúde direcionadas aos diferentes grupos populacionais. (Plano Municipal de POA ,20222025).

Corroborando a isso, Agostinho et al 2010 discorre sobre a importância do vínculo do usuário com o Serviço. Ressaltando-se que a maior satisfação com Serviço de APS está associada à melhor autopercepção de saúde, justificando a reorganização do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da ampliação da rede de serviços de APS, como a ESF. Percebe-se ainda que a satisfação dos usuários relaciona-se com fatores como a cordialidade do profissional, a atenção dada às queixas, a confiança despertada pelo profissional, a confiança na receita e as explicações com a doença, demonstrando a necessidade de apropriação de fluxos e encaminhamentos para que exames, especialistas e condutas sejam resolutivos.

Como elemento de fechamento desta discussão, retoma-se a Política Nacional de Atenção Básica de 2017, que, no capítulo “Das responsabilidades”, atribui às três esferas de governo o compromisso com a qualificação da força de trabalho na gestão e na atenção à saúde. A normativa prevê o aprimoramento da formação, a promoção da educação permanente e continuada e a garantia de direitos trabalhistas e previdenciários aos profissionais do SUS. Também estabelece a responsabilidade dos entes federativos quanto à qualificação dos vínculos de trabalho, à implantação de planos de carreira e ao planejamento de estratégias que favoreçam a fixação dos profissionais na Atenção Básica, fortalecendo o cuidado e o vínculo com o território (art. 7º, incisos VII e VIII) (Brasil, 2017).

Ao explicitar a centralidade da formação e da valorização dos trabalhadores como responsabilidade institucional, a PNAB oferece um ponto de inflexão para avançar na discussão sobre educação na saúde, tema que passa a ser abordado no capítulo seguinte como dimensão estruturante da qualificação das práticas e da consolidação da Atenção Primária.

2.1.4 EDUCAÇÃO EM SAÚDE

A ESF não é um problema sem solução; a ESF é uma solução com problemas. (Mendes,2012) Esta ideia nos faz refletir em alternativas para melhorar a APS, inicialmente, com foco na educação.

A Educação Permanente em Saúde (EPS) foi instituída como política pública pelo Ministério da Saúde em 2007, tendo como proposta a "aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam no cotidiano das organizações e ao trabalho" (Portaria nº 1.996/2007, p. 6). A aprendizagem é feita a partir da problematização das questões vivenciadas nos cotidianos do trabalho em saúde, favorecendo a aproximação do profissional com as realidades locais e suas diferentes demandas

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), instituída pela Portaria nº 1.996, consolidou a educação permanente como estratégia estruturante do SUS, propondo que os processos formativos partam das necessidades reais do trabalho e do território. Para Ceccim (2005), a educação permanente em saúde deve ser entendida como aprendizagem no e pelo trabalho, produzida a partir da problematização das práticas cotidianas.

A formação e qualificação dos profissionais é um processo histórico que vem passando por atualizações ao longo dos tempos, esta qualificação dos profissionais inseridos no Sistema Único de Saúde (SUS) vem sendo referendada por meio de movimentos sociais, legislações e políticas públicas que defendem que o Sistema de Saúde deve exigir uma reorientação das políticas de gestão do trabalho e da educação na saúde, com definição de diretrizes para o setor e fortalecimento da integração ensino-serviço-comunidade (Costa, 2006). Como exemplo de um programa que abrange este fortalecimento temos o PET Saúde, que tem como pilar esta integração ensino-serviço-comunidade (controle social). O PET-Saúde é um importante instrumento de reorientação da formação em nível de graduação, onde os alunos conseguem ter contato com as problemáticas reais da saúde da população. (Plano Municipal de Saúde 2022-2025 POA)

A EPS é um processo dinâmico e que ganha existência ao se constituir como parte de lugares e fazeres do cotidiano das práticas em saúde. Desse modo, a EPS pode ser realizada através das/nas capacitações, seminários, reuniões de equipe, matriciamento e fóruns de serviços. Os espaços que foram apontados pelos profissionais têm como característica comum a possibilidade de serem espaços de compartilhamento de saberes e fazeres, de construção coletiva e de aprendizado. Esses espaços podem promover conexões entre os diferentes participantes, reforçando diálogos e articulações através do como fazer. Os espaços mencionados por Leite e Rocha (2017) estão em nosso cotidiano na APS como reuniões e matriciamentos.

Dessa forma, a qualificação profissional deixa de ser apenas transmissão de conteúdos e passa a constituir dispositivo de transformação das práticas, fortalecendo a capacidade crítica e a autonomia dos trabalhadores.

Muitas vezes, os processos de educação permanente das equipes de PSF não são efetivas, apresentam altos custos diretos e indiretos pelo tempo subtraído constantemente do trabalho dos profissionais nas unidades de PSF e porque muitas vezes são utilizadas metodologias centradas nos professores, com ênfase na transmissão de conhecimentos e separando intervenções educacionais e desempenho Leite e Rocha (2017).

Porto Alegre ainda possui alguns desafios acerca do avanço na constituição de novos Núcleos de Educação Permanente (NEPs), com a criação do NEP na Atenção Primária e tratativas para formar o NEP do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, necessita-se de profissionais com carga horária direcionada para este trabalho, bem como a redefinição de papéis dos NEPs e uma aproximação dos mesmos para que se qualifique a integração e articulação das ações e se priorize a Educação Permanente como Política estratégica e transversal para o SUS, dentro da SMS. (Plano Municipal de Saúde 2022-2025 POA)

Os fluxos de informação são constituídos naturalmente ou induzidos formalmente nos ambientes organizacionais, bem como perpassam do nível estratégico ao nível operacional, refletindo e impactando nos processos que compõem a organização, inclusive o processo decisório e, por consequência as estratégias de ações. (Valentim, Teixeira, 2012).

Na atenção básica os fluxogramas descrevem o “caminho” pelo qual o usuário terá de passar ao entrar na rede de atenção à saúde. Existem diversos serviços prestados e em muitas ocasiões os profissionais não detêm as informações com propriedade, não sabendo informar ao usuário com clareza ou às vezes desconhece o serviço ofertado no município e como esse funciona. Por isso faz-se necessário tornar esses serviços esquematizados e demonstrados aos profissionais para que possam sem dúvidas atender de maneira resolutiva e com qualidade os usuários. (Nayara, Laís, 2021)

Materiais educativos como guias, manuais, e-books e plataformas digitais têm sido utilizados como ferramentas de apoio à prática profissional. Diferentemente de capacitações pontuais, esses instrumentos permanecem disponíveis para consulta contínua, funcionando como suporte à tomada de decisão no cotidiano do serviço.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2021), as tecnologias digitais em saúde ampliam o acesso ao conhecimento, fortalecem capacidades profissionais e

contribuem para a qualificação dos sistemas de saúde, inclusive por meio do apoio à educação contínua e à tomada de decisão baseada em evidências.

Contudo, é necessário distinguir conceitualmente essas ferramentas da própria Educação Permanente em Saúde. Um guia digital de consulta rápida aproxima-se mais do campo da gestão da informação e da educação continuada, por sistematizar conteúdos e facilitar o acesso a orientações institucionais. Ele não substitui a EPS em sua essência, que pressupõe problematização coletiva do processo de trabalho. Entretanto, pode funcionar como tecnologia de apoio, criando condições para que as equipes tenham maior segurança técnica e possam dedicar-se à reflexão crítica sobre suas práticas.

A educação continuada caracteriza-se, em geral, por iniciativas organizadas para atualização técnica e aprimoramento de competências específicas, estruturadas a partir de conteúdos previamente planejados e ofertados aos profissionais. Trata-se de uma estratégia importante para manter a qualidade assistencial, mas que nem sempre dialoga diretamente com as singularidades do território ou com as dinâmicas concretas do processo de trabalho. Em contraste, a Educação Permanente em Saúde desloca o eixo formativo para o cotidiano dos serviços, tomando como ponto de partida os desafios vivenciados pelas equipes. Seu objetivo não é apenas suprir lacunas de conhecimento, mas fomentar reflexão crítica e promover mudanças na organização do cuidado, integrando formação, gestão e atenção de maneira articulada. (Ceccim,2005)

Dessa forma, o uso de um guia digital na Atenção Primária deve ser compreendido como instrumento complementar, que fortalece a organização do trabalho, apoia processos educativos e contribui para maior resolutividade, sem perder de vista que a transformação das práticas depende do diálogo coletivo, da análise crítica do cotidiano e do compromisso ético com o cuidado.

Além disso, materiais digitais estruturados favorecem a padronização de informações, reduzem a dependência de comunicação informal e contribuem para maior equidade no acesso ao conhecimento institucional. Em contextos de rotatividade profissional, funcionam como instrumento de acolhimento e integração de novos trabalhadores.

3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, com abordagem qualitativa e quantitativa, configurando-se como um estudo de método misto. O objetivo foi compreender os desafios e as necessidades dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) de Porto Alegre, bem como levantar informações que subsidiam a análise da organização dos fluxos de trabalho.

De acordo com Gil (2019), a pesquisa qualitativa busca interpretar os significados atribuídos pelos sujeitos às suas práticas e experiências, possibilitando a apreensão de dimensões que não estariam acessíveis apenas por meio da mensuração estatística. A combinação entre dados qualitativos e quantitativos amplia a compreensão dos fenômenos investigados, ao integrar a análise de significados às frequências numéricas observadas nos dados.

A análise qualitativa foi realizada com base nos procedimentos de análise de conteúdo descritos por Bardin (2011), reconhecida como referência clássica na área, complementada pela perspectiva de Minayo (2022), que amplia a aplicabilidade dessa abordagem no campo da saúde. Esse processo permitiu a identificação de categorias e padrões emergentes a partir das respostas abertas, possibilitando uma interpretação aprofundada das percepções dos profissionais.

Os dados quantitativos, por sua vez, foram analisados de forma estatística descritiva, permitindo a identificação de tendências e a sistematização das informações obtidas por meio das questões fechadas.

A investigação foi organizada em quatro etapas:

1ª etapa – Revisão documental

Revisão documental: Levantamento e análise de notas técnicas, instruções normativas, Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) e documentos institucionais referentes à organização dos fluxos de trabalho na APS de Porto Alegre; 2ª etapa – Diagnóstico inicial.

Aplicação de um questionário online (Apêndice A) aos profissionais da Atenção Primária à Saúde, com o objetivo de identificar desafios, necessidades e percepções

relacionadas à organização dos fluxos de trabalho na APS, subsidiando a construção inicial do guia digital.

3ª etapa – Construção do guia digital.

Sistematização e análise das respostas obtidas: Com base nessas análises dos dados obtidos, procedeu-se à compilação e organização dos links institucionais e materiais normativos já vigentes, reunindo-os em um único ambiente digital. O objetivo foi facilitar o acesso, reduzir retrabalho e apoiar o processo de trabalho das equipes, sem alterar protocolos ou redefinir fluxos previamente estabelecidos. A elaboração do guia digital de fluxos assistenciais teve como priorização inicial das seções referentes aos temas HIV e sífilis.

4ª etapa – Avaliação parcial do guia.

Avaliação parcial do guia digital, por meio de questionário específico (Apêndice B), com o objetivo de analisar as seções já concluídas referentes aos temas HIV e sífilis quanto à utilidade, clareza e aplicabilidade do material, subsidiando a continuidade da construção do site.

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA E PARTICIPANTES

O estudo foi realizado no contexto da Atenção Primária à Saúde do município de Porto Alegre, considerando suas unidades de saúde e equipes que compõem a atenção primária. A escolha desse cenário justifica-se pela relevância da APS como porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde e como nível de atenção responsável pela coordenação do cuidado, bem como pelos desafios relacionados à organização dos fluxos de trabalho vivenciados cotidianamente pelos profissionais que atuam nesse nível de atenção.

A pesquisa foi desenvolvida junto a médicos e enfermeiros vinculados à Atenção Primária à Saúde de Porto Alegre, contemplando as quatro Coordenadorias Distritais de Saúde (Leste, Oeste, Norte e Sul).

Os critérios de inclusão foram: ser médico ou enfermeiro atuante na APS de Porto Alegre no período da coleta e possuir vínculo ativo com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA) ou com Organizações da Sociedade Civil (OSC) ou com programas de residência multiprofissional ou com o Programa Mais Médicos, pois todos atuam na APS do município.

O convite para participação na pesquisa foi encaminhado por meio das Coordenadorias Distritais de Saúde, que o repassaram às Unidades sob sua gestão, utilizando e-mails institucionais e mensagens via aplicativo WhatsApp, com o objetivo de ampliar o alcance da divulgação.

Estimou-se a participação de aproximadamente 134 profissionais, correspondente ao número de Unidades de Saúde do município. Ao final do período de coleta, foram obtidas 34 respostas, sendo 32 consideradas válidas. Embora esse número tenha sido inferior ao inicialmente projetado, a amostra foi considerada suficiente para subsidiar as análises qualitativas e possibilitar a identificação de tendências nos dados quantitativos.

3.3 PROCEDIMENTOS DE PRODUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

A coleta de dados foi realizada por meio de dois questionários online, elaborados na plataforma Google Forms, direcionado a profissionais médicos e enfermeiros atuantes na Atenção Primária à Saúde (APS) do município de Porto Alegre.

O primeiro instrumento contemplou questões abertas e fechadas, com o objetivo de integrar abordagens qualitativas e quantitativas. As questões abertas possibilitaram a captação de percepções, experiências e sugestões mais detalhadas acerca dos fluxos de trabalho, enquanto as questões fechadas permitiram a obtenção de dados passíveis de análise estatística. Parte dos itens do questionário foi elaborada com base na experiência da pesquisadora na APS, considerando demandas e dúvidas recorrentes observadas em sua atuação como assessora de monitoramento em uma das Coordenadorias.

O questionário iniciava-se com a apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo o acesso às demais questões liberadas apenas após a seleção da opção “Sim, autorizo e aceito participar”. Caso o participante optasse por não autorizar sua participação, o formulário era automaticamente encerrado, assegurando a voluntariedade da participação.

No primeiro questionário preliminar ao guia, o fornecimento do endereço de e-mail constituiu um campo obrigatório, sendo utilizado exclusivamente para o envio posterior dos resultados da pesquisa, para a avaliação preliminar do guia e retorno do produto técnico aos participantes. Ressalta-se que foi garantido o sigilo das respostas, não havendo qualquer associação entre a identificação dos participantes e o conteúdo dos questionários, em conformidade com os princípios éticos que regem a pesquisa envolvendo seres humanos.

A opção pelo formato digital justificou-se pela maior agilidade no processo de coleta de dados, pela ampliação do alcance geográfico (incluindo unidades localizadas em áreas de difícil

acesso, como as ilhas) e pela redução de possíveis vieses de influência, uma vez que eliminou o contato direto da pesquisadora durante o preenchimento dos questionários.

Os dados foram analisados de forma integrada, combinando procedimentos qualitativos e quantitativos:

Dados qualitativos: as respostas abertas foram examinadas segundo a técnica de análise de conteúdo temática, proposta por Bardin (2011), em três fases: (1) pré-análise; (2) exploração do material; e (3) tratamento, inferência e interpretação. Essa técnica possibilitou a identificação de categorias emergentes e a sistematização de padrões de sentido.

Dados quantitativos: Os dados quantitativos foram organizados e apresentados de forma descritiva, considerando a frequência das respostas e as tendências observadas entre os participantes. Esses resultados ajudaram a complementar a análise qualitativa, oferecendo uma visão geral sobre as práticas e os desafios vivenciados na APS do município.

3.5 RECOMENDAÇÕES SOBRE ÉTICA NA PESQUISA

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer consubstanciado nº 86216525.0.0000.5347. Todos os participantes aceitaram o TCLE em formato digital antes de acessar os questionários. Foi assegurada a confidencialidade das informações, o direito de desistência e o uso restrito dos e-mails para devolutiva e validação do guia prático.

4 IMPACTOS ACADÊMICOS E SOCIAIS DO TRABALHO

No âmbito acadêmico, o projeto contribui ao produzir conhecimento aplicado a partir de uma demanda concreta da gestão da Atenção Primária à Saúde. A pesquisa articulou dados quantitativos e qualitativos para compreender a percepção dos profissionais acerca de sua aptidão para encaminhamentos, evidenciando que fragilidades operacionais muitas vezes decorrem da dispersão das informações e não da ausência de normativas. Ao trazer essa análise, o estudo amplia o debate sobre organização do conhecimento institucional, educação permanente e qualificação dos processos de trabalho no SUS.

A produção do guia digital como produto técnico reforça o papel do mestrado profissional na proposição de soluções contextualizadas e factíveis. Além disso, pretende-se dar visibilidade acadêmica aos achados por meio da submissão de artigo a revistas da área da saúde

e apresentação em Encontros e Feiras de Saúde, ampliando o alcance da discussão e possibilitando que a experiência seja compartilhada e potencialmente replicada em outros territórios.

No campo institucional, percebe-se na capital um movimento voltado à qualificação dos profissionais ingressantes na rede. Nesse cenário, pretende-se apresentar o guia à DAPS, com a proposta de integrá-lo a plataformas institucionais como o Educa POA ou a BVAPS, consolidando-o como instrumento de consulta e apoio ao processo de trabalho. Essa inserção pode fortalecer sua sustentabilidade, ampliar o acesso e incorporá-lo às estratégias formais de educação permanente.

Do ponto de vista social, o principal impacto do projeto está na qualificação do cotidiano dos profissionais e, conseqüentemente, na organização do cuidado ofertado à população. Ao facilitar o acesso a fluxos e documentos oficiais em um único ambiente digital, o guia tende a tornar o dia a dia mais dinâmico e assertivo, contribuindo para encaminhamentos mais precisos e maior agilidade no atendimento. Em contextos marcados por rotatividade de trabalhadores, a ferramenta também funciona como apoio à integração de novos profissionais, reduzindo a dependência de informações informais.

Como efeito indireto, espera-se que a melhoria na organização dos encaminhamentos repercuta na experiência dos usuários, com respostas mais rápidas às demandas, maior clareza nos fluxos e economia de tempo. Assim, o projeto ultrapassa a dimensão técnica de sistematização de links e se insere em uma perspectiva mais ampla de fortalecimento da Atenção Primária, qualificação da gestão do cuidado e valorização do trabalho em saúde.

Quadro 1 - Descrição do Produto Técnico Final

Descrição do produto	Trata-se de um guia prático digital, disponibilizado em formato de site, que reúne e organiza fluxos assistenciais e orientações operacionais da Atenção Primária à Saúde (APS) de Porto Alegre. O conteúdo foi estruturado a partir da pesquisa Guia Prático sobre fluxos e direcionamentos na APS de Porto Alegre para profissionais em Unidades de Saúde.
Finalidade do produto	Apoiar os profissionais da APS na organização do cuidado e na tomada de decisão no cotidiano assistencial, qualificação do processo de trabalho e melhoria do acesso e da resolutividade dos serviços.
Público de interesse	Profissionais de nível superior atuantes na APS de Porto Alegre, especialmente médicos e enfermeiros, além de outros trabalhadores da rede interessados na organização dos fluxos assistenciais.
Divulgação do produto	O produto será divulgado por meio das Coordenadorias Distritais de Saúde, e-mail institucional, grupos de comunicação das equipes (como WhatsApp) e encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, com proposta de inclusão na Biblioteca Virtual em Atenção Primária à Saúde (BVAPS). Além disso, o site encontra-se disponível na web, permitindo acesso livre e facilitado aos profissionais.
Projeto de pesquisa	Guia Prático sobre fluxos e direcionamentos na APS de Porto Alegre para profissionais em Unidades de Saúde
Linha de Pesquisa Vinculada	Processos de Ensino na Saúde
Disponibilização do produto	O acesso pode ser feito pelo link: https://guia-pratico-aps-poa.netlify.app
Autoria	Denise Wisniewski de Mattos (discente) Mariangela Kraemer Lenz Ziede (docente)

Fonte: elaborado pela autora

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir, são apresentados os resultados referentes ao Questionário 1 (Apêndice A).

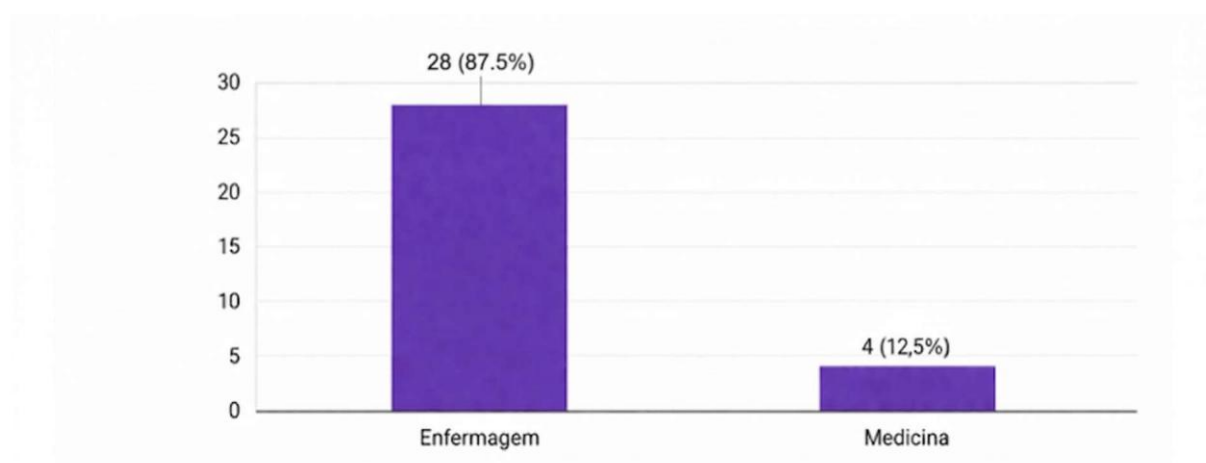
Os dados serão descritos conforme a ordem original das questões, respeitando a sequência em que foram apresentadas aos participantes. Essa organização busca preservar a lógica do instrumento e facilitar a compreensão do percurso analítico, permitindo que o leitor acompanhe a relação entre cada pergunta e os achados correspondentes. Inicialmente, são apresentados os dados de caracterização dos respondentes, seguidos das questões relativas ao ingresso na APS, às dificuldades nos fluxos assistenciais e à autopercepção de aptidão para encaminhamentos nas diferentes temáticas investigadas.

5.1 ACHADOS E ANÁLISES DO QUESTIONÁRIO 1:

As questões 1 a 3 destinaram-se à caracterização dos participantes, permitindo delinear o perfil profissional dos respondentes quanto a aspectos sociodemográficos e de inserção na Atenção Primária à Saúde.

Figura 3. Questão 1:

1. Qual seu cargo



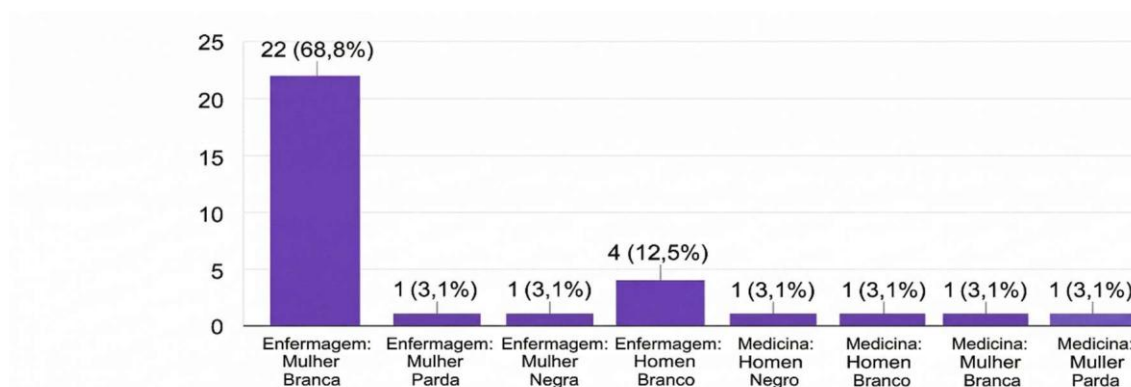
Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Questionário 1 (Questão 1), 2026.

As respostas referentes ao cargo apresentaram múltiplas denominações, como gerente, assessoria e funções assistenciais. Para viabilizar a análise, essas respostas foram sintetizadas em duas categorias profissionais, Enfermagem e Medicina. A classificação foi realizada com base nas informações de identificação profissional disponíveis no instrumento, garantindo a confidencialidade dos participantes e sem possibilidade de identificação individual.

Foi identificado a participação de uma técnica de enfermagem e uma auxiliar de saúde bucal. Entretanto, esses profissionais não se enquadram nos critérios de inclusão previamente estabelecidos, que restringiam a participação a médicos e enfermeiros atuantes na APS de Porto Alegre. Dessa forma, essas duas participantes foram excluídas da análise final, não constando no gráfico acima e assegurando a metodologia e a validade dos resultados.

Figura 4. Questão 2:

2. Qual seu gênero ? Qual sua raça/cor ?



Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Questionário 1 (Questão 2), 2026.

A maior parte das respostas se concentra em mulheres brancas, somando cerca de 70% dos respondentes.

A análise dos gráficos apresentados evidencia uma predominância expressiva de profissionais brancos na Atenção Primária à Saúde, com baixa representação de pessoas pretas e pardas. Esse achado, quando contextualizado com o modelo de contratação por terceirização, suscita a

discussão sobre racismo institucional, entendido como o conjunto de práticas, rotinas e normas que, mesmo sem intenção explícita, produzem e mantêm desigualdades raciais no acesso a oportunidades e posições de trabalho (Ministério da Saúde, 2017; Organização PanAmericana da Saúde, 2019).

No campo da saúde, o racismo institucional se manifesta de forma estrutural, influenciando processos seletivos, critérios de contratação, oportunidades de progressão profissional e distribuição de cargos. A terceirização, embora seja uma estratégia administrativa adotada para gestão de recursos humanos, pode contribuir para a reprodução dessas desigualdades quando não incorpora mecanismos explícitos de equidade racial. Processos seletivos pouco transparentes, exigências que favorecem trajetórias historicamente mais acessíveis à população branca e ausência de monitoramento de diversidade são fatores que reforçam a sub-representação de profissionais negros (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2021; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022).

A baixa presença de trabalhadores pretos e pardos na APS também reflete desigualdades históricas no acesso à formação superior, especialmente em cursos da área da saúde. Mesmo com avanços nas políticas de ações afirmativas, ainda há repercussões desse cenário na composição da força de trabalho. Quando somadas à terceirização, essas desigualdades tendem a se perpetuar, pois o vínculo mais flexível e descentralizado dificulta a implementação de políticas institucionais de inclusão e diversidade (Ministério da Educação, 2020; Fundação Oswaldo Cruz, 2022).

Esse resultado está em consonância com estudos que demonstram a persistência de dificuldades na utilização adequada das categorias de raça/cor, bem como fragilidades na incorporação das discussões sobre diversidade de gênero e raça na formação profissional em saúde (Batista; Werneck, 2019; Lopes; Almeida, 2020).

A maioria das respostas obtidas correspondem a mulheres brancas, o que evidencia um fenômeno já descrito na literatura sobre a feminização das profissões da saúde e a predominância de pessoas brancas nesses espaços. Historicamente, profissões como Enfermagem foram socialmente associadas ao cuidado, sendo culturalmente atribuídas às mulheres, o que ajuda a explicar o predomínio feminino na Atenção Primária à Saúde (Lopes; Leal, 2005; Machado, 2010).

Além disso, a escassez de profissionais negros pode estar relacionada a barreiras estruturais de acesso à formação superior em saúde, bem como a processos de seleção e

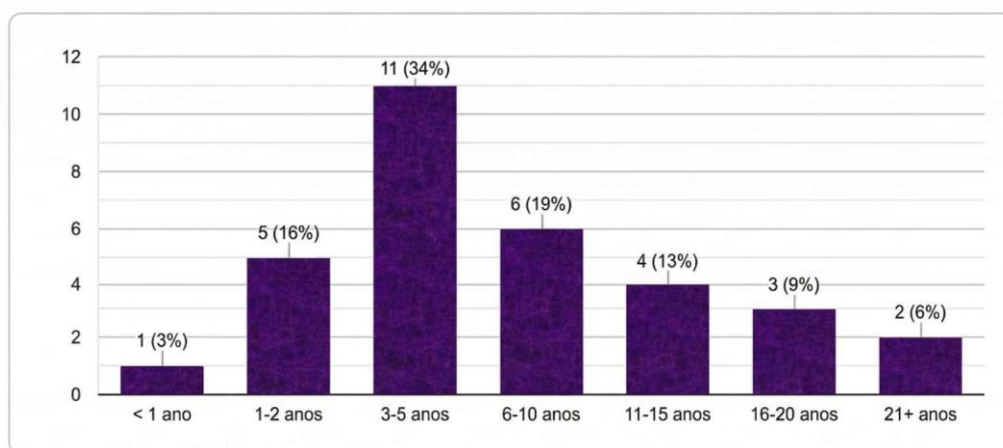
contratação que, em contextos de vínculos CLT e de gestão por Organizações Sociais podem privilegiar determinados perfis profissionais (Pinto et al., 2018). Tal fato pode influenciar na capacidade dos serviços de saúde de dialogar com as necessidades diversas da população.

A predominância de mulheres brancas, portanto, pode ser resultado tanto da histórica feminização e branqueamento de determinadas profissões, quanto de critérios implícitos do mercado de trabalho em saúde, que favorecem perfis específicos. Em contrapartida, a contratação por concurso público, no caso de profissionais estatutários tende a promover maior diversidade, ao passo que a contratação CLT tende a reproduzir desigualdades sociais (Wermelinger et al., 2020).

Ainda que o SUS seja orientado pelos princípios da equidade e da diversidade, a composição da força de trabalho demonstra desigualdades persistentes, com baixa representatividade de pessoas negras e de outros grupos sociais.

Figura 5. Questão 3:

2. Quanto tempo você trabalha na APS de Porto Alegre?



Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Questionário 1 (Questão 3), 2026.

A maior concentração encontra-se na faixa de 3 a 5 anos, com 11 participantes, correspondendo a 34% do total. Em seguida, aparecem os profissionais com 6 a 10 anos, somando 6 respondentes, ou 19%. A faixa de 1 a 2 anos reúne 5 participantes, equivalente a 16%.

De forma geral, o gráfico indica predominância de profissionais com até cinco anos de atuação na APS. Esse padrão sugere presença significativa de trabalhadores com experiência recente ou intermediária, enquanto a participação de profissionais com vínculos mais longos é menor. Ao mesmo tempo, somando aqueles com mais de seis anos de atuação, observa-se uma parcela relevante do grupo, indicando coexistência de profissionais com maior experiência no serviço.

Há uma parcela considerável que se encontra na APS em período intermediário de carreira, possivelmente ligada a vínculos celetistas ou programas específicos como o Mais Médicos e Médicos pelo Brasil. Mesmo assim, esses achados não refletem exatamente a realidade local. Diversos estudos apontam que a alta rotatividade de trabalhadores e a presença de profissionais contratados com pouca ou nenhuma experiência prévia na APS são características marcantes do setor (BRASIL, 2017; Giovanella et al., 2021). Nesse sentido, Pontes (2025, p. 12) complementa: “Paralelamente, inserido em um contexto de rotatividade frequente entre profissionais da saúde”, o que reforça o impacto desse cenário sobre a consolidação de práticas e a continuidade do cuidado.

Assim, a rotatividade, aliada à instabilidade contratual, representa um desafio central para a implementação efetiva de protocolos, para o fortalecimento da integralidade da atenção e para a construção de vínculos duradouros entre equipes e usuários.

O capitalismo, sob a hegemonia neoliberal, modificou as formas de venda de força do trabalho, o que intensificou sua precarização, fenômeno que se expandiu globalmente. Esse fenômeno mantém a classe trabalhadora em condições de insegurança e instabilidade, atingindo os diversos setores, incluindo o serviço público, estendendo seus efeitos por todas as dimensões da vida em sociedade. (Antunes, 2018).

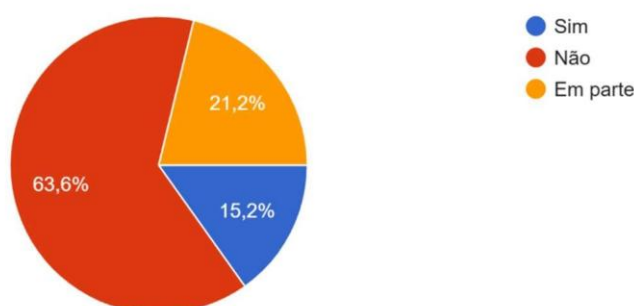
Para a construção do guia pode ser positivo essa diferenciação no tempo de atuação, uma vez que teremos o conhecimento e percepção da realidade da APS há muitos anos e de quem ingressou mais recentemente, contribuindo para a produção de um material abrangente e representativo.

As questões 4 a 6 abordaram o processo de ingresso dos profissionais na Atenção Primária à Saúde de Porto Alegre, com foco nas estratégias de acolhimento, capacitação e oferta de materiais de apoio institucional. Buscou-se compreender se, no momento da inserção no serviço, foram disponibilizados espaços formativos, referências técnicas e instrumentos que

auxiliassem na organização do trabalho e na tomada de decisão no cotidiano da prática profissional.

Figura 6. Questão 4:

4. Quando ingressou na Atenção Primária de Porto Alegre foi oferecido algum encontro em forma de oficina, curso ou capacitação com objetivo de fo... do trabalho que seria desenvolvido no dia a dia ?
33 respostas



Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Questionário 1 (Questão 4), 2026.

Quando questionados sobre a oferta de oficinas, cursos ou capacitações no momento do ingresso na APS de Porto Alegre, a maioria dos respondentes (63,6%) afirmou não ter recebido nenhum tipo de capacitação formal. Outros 21,2% relataram que houve alguma orientação, mas de forma parcial, enquanto apenas 15,2% confirmaram ter participado de atividades estruturadas nesse sentido.

Esse resultado evidencia uma fragilidade importante nos processos de acolhimento e integração de novos profissionais. A ausência de treinamentos formais compromete a adaptação inicial, pode gerar insegurança quanto às atribuições e impactar diretamente a qualidade do cuidado ofertado.

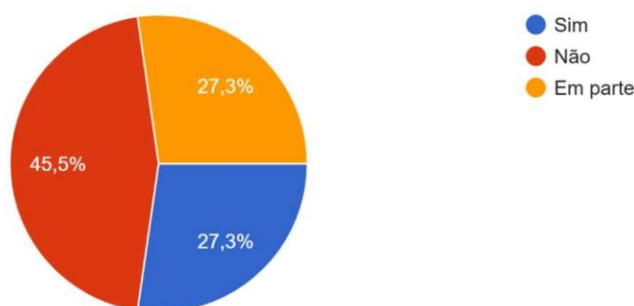
A literatura reforça que a integração qualificada de novos trabalhadores é fundamental para fortalecer a identidade profissional, alinhar práticas à Política Nacional de Atenção Básica e reduzir a rotatividade (Mendes, 2015; Giovanella et al., 2021). A falta de capacitação sistematizada no ingresso tende a aprofundar dificuldades já conhecidas, como a heterogeneidade das práticas, o sentimento de isolamento profissional e a sobrecarga decorrente do "aprender fazendo", sem acompanhamento adequado.

Os resultados obtidos reforçam a importância da construção de materiais de apoio. Considerando que a maioria dos respondentes relatou não ter recebido capacitação formal ao ingressar na APS, observa-se que o guia de fluxos proposto nesta pesquisa pode se tornar um instrumento estratégico, especialmente para os profissionais recém-chegados. Ao reunir informações de forma organizada, acessível e visual, o guia vai funcionar como uma ferramenta de consulta rápida, reduzindo incertezas no cotidiano de trabalho e apoiando a prática clínica.

Figura 7. Questão 5:

5. Quando ingressou na Atenção Primária de Porto Alegre foi oferecido algum material como referências para estudo e para ser utilizado em caso de dúvidas ?

33 respostas



Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Questionário 1 (Questão 5), 2026.

Em relação à oferta de materiais de referência no ingresso dos profissionais, 45,5% dos participantes afirmaram não ter recebido nenhum recurso de apoio, enquanto 27,3% indicaram que receberam apenas parcialmente e outros 27,3% relataram ter recebido material de forma adequada. Esses resultados evidenciam uma lacuna relevante no processo de integração e formação inicial, uma vez que estes materiais são essenciais para embasar as práticas cotidianas e favorecer a padronização das condutas na Atenção Primária à Saúde.

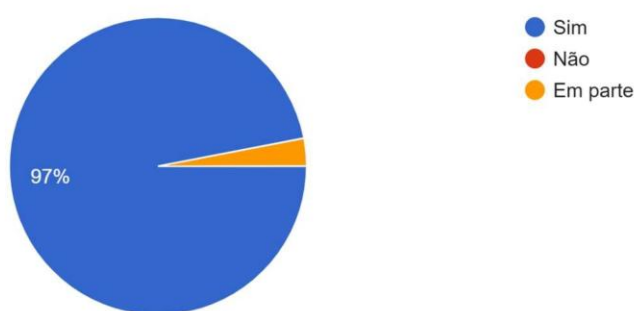
A ausência dos mesmos pode contribuir para a insegurança profissional e para a heterogeneidade das práticas, sobretudo em contextos de alta rotatividade, como é característico da APS em Porto Alegre. Nesse sentido, o guia de fluxos proposto neste estudo se apresenta como um instrumento estratégico de apoio ao cuidado, servindo não apenas como material de consulta rápida, mas também como um dispositivo de educação permanente, facilitando o aprendizado em serviço e a integração de novos profissionais.

Conforme Freire (1996), o acesso a ferramentas pedagógicas que dialoguem com a realidade do trabalhador fortalece a autonomia e promove maior qualificação do processo de trabalho. Da mesma forma, Campos e Ferraz (2020) destacam que a disponibilização de materiais de apoio auxilia a construção coletiva do conhecimento e a segurança na tomada de decisão clínica.

Figura 8. Questão 6:

6. Quando ingressou na Atenção Primária de Porto Alegre considera que teria sido importante um material que servisse de apoio para a tomada de decisões referentes aos processos de trabalho?

33 respostas



Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Questionário 1 (Questão 6), 2026.

Os dados mostram um consenso quase unânime entre os participantes: 97% afirmaram que seria importante dispor de um material de apoio para a tomada de decisões referentes aos processos de trabalho. Apenas uma minoria (3%) respondeu “em parte”, não havendo registros de respostas negativas.

Esse resultado reforça a percepção de que há uma lacuna significativa de suporte institucional oferecido aos profissionais no momento do ingresso na APS de Porto Alegre. A ausência de fluxos claros, protocolos organizacionais e materiais de orientação compromete a segurança e a autonomia dos trabalhadores, principalmente daqueles que não possuem experiência prévia em Atenção Primária (Mendes, 2011; Giovanella et al., 2021).

A literatura aponta que a construção de guias de fluxo, manuais operacionais ou protocolos assistenciais favorece a padronização das práticas, fortalece a capacidade resolutiva das equipes e contribui para a integração dos profissionais ao processo de trabalho (Campos;

Malik, 2008). Além disso, materiais de apoio funcionam como instrumentos de educação permanente, permitindo consultas rápidas no cotidiano e estimulando a autonomia técnica (Ceccim 2005; Feuerwerker, 2004).

Esse conjunto de questões permitiu analisar como se deu o apoio institucional no início da atuação na APS, identificando lacunas na qualificação inicial e na disponibilização de recursos técnicos para o exercício das atividades assistenciais.

O guia de fluxos da APS de Porto Alegre pretende representar não apenas um recurso de acolhimento aos trabalhadores ingressantes, mas também uma ferramenta de qualificação para os profissionais já inseridos.

Após a análise das questões relacionadas ao apoio institucional no momento de ingresso na APS, passa-se à análise das questões 7 e 7.1, que investigaram as principais dificuldades referidas pelos profissionais quanto à compreensão dos fluxos assistenciais e à realização de encaminhamentos, bem como as sugestões apresentadas para o enfrentamento dessas fragilidades.

Questão 7 e Questão 7.1:

7. Sobre quais temas teve ou tem mais dificuldade de saber os fluxos e realizar encaminhamentos?

7.1 Gostaria de deixar uma sugestão sobre o que poderia ser feito em relação à questão anterior (7)?

A análise das respostas à questão 7 evidenciou múltiplas dificuldades relatadas pelos profissionais em relação aos fluxos e encaminhamentos na Atenção Primária à Saúde. Os achados puderam ser organizados em cinco grandes categorias.

A primeira delas refere-se aos encaminhamentos para níveis secundário e terciário, especialmente em especialidades médicas como neurologia, cardiologia, dermatologia, reumatologia e saúde mental infantil. Também se destacou a insegurança quanto ao uso do GERCON (Sistema de Gerenciamento de Consultas de Porto Alegre) e aos critérios de regulação, além de dificuldades relacionadas à solicitação de exames e aos devidos encaminhamentos. Esse cenário reforça a fragmentação entre os níveis de atenção do SUS, já

apontada pela literatura como um dos principais entraves à integralidade do cuidado (Mendes, 2010).

Outra categoria emergente diz respeito à saúde mental e às demandas sociais, mencionada de forma recorrente por profissionais que relataram insegurança na condução de casos de adultos e crianças, bem como em situações de vulnerabilidade social, violência doméstica e encaminhamentos ligados ao serviço social. Esse achado reflete a crescente demanda por saúde mental na APS e a insuficiência de dispositivos especializados, o que gera sobrecarga e insegurança profissional (Campos; Amarante, 2015).

Também se evidenciaram dificuldades no manejo de doenças crônicas e agravos de notificação compulsória, como tuberculose, hanseníase, hepatites e HIV/Aids, além de dúvidas relacionadas a prazos de vigilância e sistemas de notificação. A constante atualização das normativas, aliada à ausência de instrumentos acessíveis de consulta, compromete a continuidade do cuidado e a vigilância em saúde.

A saúde da mulher e da criança foi outro campo destacado, sobretudo após a saída de ginecologistas e pediatras das equipes, gerando fragilidade na condução de fluxos relacionados ao pré-natal, anticoncepção cirúrgica, climatério e puericultura. As dificuldades também se estenderam à vacinação em situações em que não havia protocolos específicos para a prática de enfermagem, revelando limitações da APS em sustentar cuidados prioritários em meio à rotatividade e ausência de especialistas (Brasil, 2017).

Por fim, emergiram questões relacionadas à dimensão administrativa e aos protocolos internos, que incluíram dúvidas sobre solicitações de exames, organização da vacinação, transporte social, curativos e medicamentos especiais, além de processos de gestão de pessoas, como férias, folgas e licenças. Esse achado reforça que a insegurança profissional na APS não se restringe ao campo clínico, mas também alcança aspectos organizacionais do processo de trabalho, o que demanda instrumentos de apoio que contemplem ambas as dimensões (Starfield, 2002). Estas dúvidas referentes aos processos de Recursos Humanos englobam principalmente profissionais estatutários.

Na questão 7.1, quando convidados a sugerir melhorias para as dificuldades relatadas, os profissionais destacaram principalmente a necessidade de materiais de apoio práticos e objetivos, tais como fluxogramas resumidos, cards com contatos estratégicos, painéis digitais e ferramentas interativas (aplicativos ou sites) que favoreçam o acesso rápido às informações.

Essas sugestões convergem diretamente com a proposta de elaboração de um guia prático de fluxos, objetivo deste estudo.

Outra demanda recorrente foi a de capacitação e qualificação profissional, com menções a minicursos, treinamentos mais aprofundados e orientações específicas sobre fluxos da APS. Os participantes apontaram que as capacitações atualmente ofertadas são superficiais e insuficientes, evidenciando a necessidade de formação continuada contextualizada à realidade local.

A atualização e integração dos protocolos também foi mencionada, com críticas à fragmentação das informações disponíveis. Embora os profissionais reconheçam a existência de protocolos, a forma como estão organizados não favorece a consulta prática, reforçando a importância de instrumentos que unifiquem os fluxos.

Por fim, surgiram sugestões relacionadas ao apoio institucional e à intersetorialidade, como o fortalecimento da comunicação com setores da secretaria, a presença de assistente social nas equipes e o suporte de telegestão para dúvidas cotidianas. Essas propostas refletem a compreensão dos trabalhadores sobre a complexidade do trabalho na APS, que demanda tanto instrumentos objetivos de consulta quanto suporte institucional permanente.

De modo geral, as respostas às questões 7 e 7.1 demonstram que as dificuldades vivenciadas pelos profissionais abrangem desde os aspectos clínicos de regulação e inclusive de dimensões organizacionais e sociais. Ao mesmo tempo, as sugestões apontam para soluções que reforcem a pertinência da elaboração de um guia prático de fluxos como instrumento de apoio ao cotidiano da APS, capaz de fortalecer a autonomia profissional e qualificar a integralidade do cuidado.

As questões 8 e 8.1 buscaram compreender a percepção dos profissionais quanto à sua capacidade de solucionar dúvidas de forma rápida e eficaz no cotidiano da Atenção Primária à Saúde. Além da resposta objetiva, foi disponibilizado espaço para sugestões, permitindo identificar possíveis estratégias de aprimoramento no acesso às informações e no suporte técnico oferecido.

Questão 8 e Questão 8.1

8. Você considera que hoje consegue solucionar a maioria das suas dúvidas de forma rápida e eficaz?

8.1 Gostaria de deixar uma sugestão sobre o que poderia ser feito em relação à questão anterior (8)?

A questão 8 buscou compreender se os profissionais consideram que atualmente conseguem solucionar a maioria de suas dúvidas de forma rápida e eficaz. Das 33 respostas obtidas, verificou-se que 11 participantes (33,3%) responderam afirmativamente (“sim” ou variações como “sim, na maioria das vezes”), enquanto 7 (21,2%) declararam não conseguir e 15 (45,5%) situam-se em uma posição intermediária, com respostas como “em parte”, “mais ou menos” ou “depende”.

Embora parte dos trabalhadores reconheça que consegue resolver suas dúvidas, muitos apontaram dificuldades associadas principalmente às recentes mudanças na BVAPS (Biblioteca Virtual da Atenção Primária à Saúde de Porto Alegre). Comentários como “a última atualização da BVAPS prejudicou o trabalho” e “a ferramenta de busca se tornou mais confusa” foram recorrentes, sugerindo que a atualização da plataforma comprometeu sua usabilidade. Além disso, observou-se que a resolução de dúvidas frequentemente depende de redes informais de contato dentro da rede municipal, evidenciando a fragilidade das ferramentas institucionais disponíveis.

Outro ponto ressaltado foi a constante mudança de fluxos e protocolos, considerada excessiva e acelerada, o que gera insegurança e dúvidas quanto à conduta mais adequada. Um dos relatos sintetiza esse sentimento ao afirmar que “as informações estão mudando numa aceleração que nos torna reféns da mudança, por vezes duvidando do que já se sabe”. Esse cenário corrobora a análise de Starfield (2002), que defende que a Atenção Primária deve ser organizada de forma clara, coordenada e acessível, de modo a sustentar sua função de ordenadora do cuidado. Também dialoga com Minayo (2010), ao destacar que a sobreposição de normas e a ausência de linguagem acessível dificultam a prática cotidiana e comprometem a resolutividade da APS.

Na questão 8.1, em que os profissionais foram convidados a sugerir melhorias, emergiram quatro grandes eixos de propostas. O primeiro refere-se à inovação tecnológica, com sugestões de criação de aplicativos, melhorias na BVAPS e até uso de inteligência artificial como ferramenta de apoio. O segundo eixo destacou a necessidade de capacitação e formação continuada, por meio de minicursos e treinamentos mais aprofundados, que

contemplem a realidade da prática cotidiana, em contraposição às capacitações consideradas superficiais ou insuficientes.

O terceiro eixo evidenciou demandas ligadas à acessibilidade da informação, com sugestões de fluxos simples, didáticos e de fácil acesso, além da disponibilização de contatos diretos (telefone ou pessoa de referência) capazes de orientar os profissionais diante das dúvidas. Já o quarto eixo trouxe a questão do tempo de adaptação e da experiência profissional, com alguns respondentes ressaltando que apenas a vivência cotidiana permite conhecer plenamente os fluxos e responsabilidades de cada setor.

De forma geral, os achados revelam que a dificuldade em solucionar dúvidas não se limita a uma lacuna técnica, mas envolve aspectos organizacionais e estruturais da APS. A crítica recorrente à BVAPS, a percepção de capacitações inadequadas e a necessidade de recursos de apoio mais objetivos e acessíveis reforçam a importância da construção de um guia prático de fluxos, conforme proposto neste estudo. Tal instrumento tem potencial para reduzir a dependência de estratégias informais, aumentar a autonomia dos profissionais e fortalecer a resolutividade da Atenção Primária.

Questão 9.1 à Questão 9.11

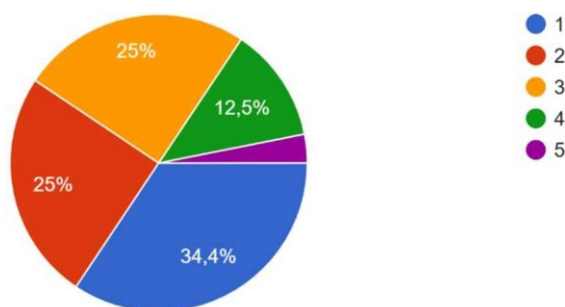
Após a caracterização dos participantes e a análise das questões relacionadas ao ingresso e aos fluxos assistenciais, passa-se à apresentação dos resultados referentes à questão 9, que investigou a autopercepção de aptidão para realização de encaminhamentos em temáticas prioritárias da APS. Os subitens 9.1 a 9.11 contemplaram diferentes agravos e grupos populacionais, sendo analisados individualmente, com apresentação dos dados em figuras e discussão específica de cada temática.

A questão 9 foi estruturada em formato de escala numérica do tipo Likert, variando de 0 a 5, em que 0 correspondia a nenhuma aptidão e 5 a muita aptidão para realização dos encaminhamentos pertinentes. As temáticas foram apresentadas em subitens (9.1 a 9.11), e os participantes deveriam selecionar apenas uma alternativa por tema, marcando a opção que melhor representasse sua autopercepção de aptidão.

9. Numa pontuação de 0 à 5, o quão você considera que está apto a fazer os encaminhamentos pertinentes às seguintes temáticas, sendo 0 nenhuma aptidão e 5 muita aptidão:

Figura 9. Questão 9.1:

9.1 Hanseníase
32 respostas



Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Questionário 1 (Questão 9.1), 2026.

Observa-se que a maioria dos participantes se concentrou nas notas 1, 2 e 3 (84,4%), o que revela baixa ou moderada autopercepção de aptidão para lidar com fluxos de encaminhamento em hanseníase. Apenas 15,6% atribuíram notas altas (4 ou 5), indicando maior segurança no tema.

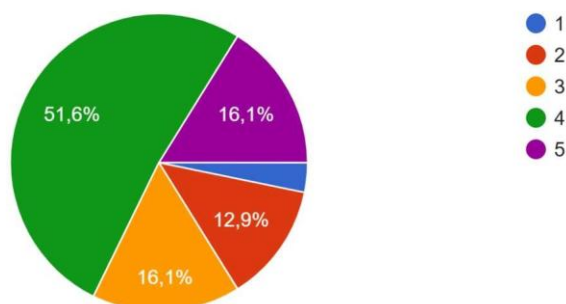
Esse resultado evidencia uma fragilidade importante na formação e no apoio institucional frente a uma doença que ainda constitui um agravo relevante de saúde pública. A baixa confiança dos profissionais sugere necessidade de capacitações específicas, protocolos acessíveis e fluxos claros.

Starfield (2002) ressalta que a resolutividade da APS depende da capacidade dos profissionais de manejar tanto condições prevalentes quanto agravos de menor frequência, mas de grande impacto social, como a hanseníase. Também Mendes (2010) reforça que redes de atenção bem estruturadas são fundamentais para garantir a integralidade e o cuidado adequado, o que implica fortalecer a comunicação entre APS e serviços de referência.

Figura 10. Questão 9.2

9.2 Tuberculose

31 respostas



Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Questionário 1 (Questão 9.2), 2026.

Diferente do observado em hanseníase, aqui predomina uma autopercepção positiva de conhecimento. A maioria dos respondentes (67,7%) atribuiu notas 4 e 5, indicando que se sentem preparados para conduzir encaminhamentos relacionados à tuberculose.

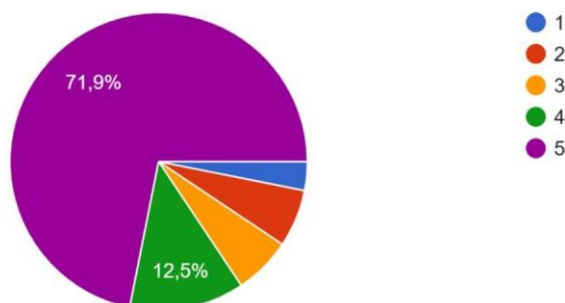
O grupo que demonstra maior insegurança (notas 1, 2 e 3) representa 32,2% dos participantes, revelando que ainda há lacunas de conhecimento e necessidade de reforço em protocolos, especialmente diante da relevância epidemiológica da tuberculose no Brasil.

Esse resultado sugere que, embora a tuberculose seja um agravo prioritário com protocolos mais consolidados e treinamentos mais frequentes, ainda é fundamental fortalecer a continuidade da educação permanente e garantir apoio sistemático às equipes de APS.

Mendes (2010) destaca que a tuberculose é um exemplo clássico de agravo que demanda uma rede de atenção organizada, integrando vigilância, diagnóstico oportuno, tratamento supervisionado e acompanhamento intersetorial.

Figura 11. Questão 9.3

9.3 Dengue
32 respostas



Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Questionário 1 (Questão 9.3), 2026.

Neste agravo observa-se que a grande maioria dos profissionais se sente com grande aptidão, sendo 84,4% se atribuiu notas 4 e 5, sendo a maior parte 71,9% com a pontuação máxima.

Esse resultado sugere que a dengue é um tema já bastante consolidado no cotidiano da APS, possivelmente em função da alta prevalência da doença em Porto Alegre nos últimos dois anos principalmente (2023 e 2024) e da frequência de capacitações que ocorrem com esta temática, reforçando o preparo das equipes para atuar desde a suspeita diagnóstica até os encaminhamentos necessários.

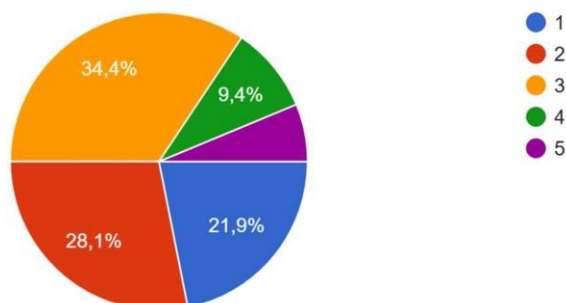
Em contrapartida, a parcela de profissionais que se autoavaliaram com notas baixas (1, 2 ou 3) representa apenas 15,7%, o que aponta que eventuais inseguranças podem estar associadas a situações mais complexas da doença, como o manejo clínico de casos graves e profissionais mais novos na rede ou desafios nos fluxos que passam por constantes mudanças.

Conforme Starfield (2002), o fortalecimento da atenção primária em contextos de doenças transmissíveis se dá pela capacidade de resposta rápida e resolutiva diante de agravos de grande impacto populacional. Nesse contexto, a dengue, pela sua relevância epidemiológica, tem impulsionado investimentos contínuos em capacitação das equipes, na formulação e atualização do Plano de Contingência, bem como na realização de reuniões intersetoriais e campanhas educativas, o que se reflete nos resultados positivos observados neste estudo.

Figura 12. Questão 9.4

9.4 Anemia falciforme

32 respostas



Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Questionário 1 (Questão 9.3), 2026.

Diferente de doenças como a dengue e a tuberculose, aqui há uma maior insegurança dos profissionais em relação aos encaminhamentos. A soma das notas baixas (1, 2 e 3) representa 84,4% dos respondentes, sendo que apenas 15,7% se consideram com alto conhecimento sobre esta patologia (notas 4 e 5).

Esse resultado pode estar relacionado a alguns fatores tais como a baixa prevalência desta patologia em Porto Alegre, o que reduz a experiência prática dos profissionais. Também é uma doença bem complexa, que envolve aspectos genéticos, complicações clínicas (crises vaso-oclusivas, risco infeccioso, internações recorrentes) e acompanhamento multiprofissional.

Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo permite identificar que a fragilidade no domínio de fluxos e condutas se manifesta claramente na predominância das respostas intermediárias e baixas, evidenciando a necessidade de treinamentos dirigidos.

Além disso, esse dado reforça o que foi apontado pelos participantes na questão 8.1, sobre a importância de fluxos mais objetivos, capacitações práticas e suporte de especialistas em condições menos prevalentes, mas de alto impacto clínico.

Recentemente, Porto Alegre, por meio da Área Técnica de Saúde da População Negra, tem intensificado ações voltadas à capacitação das equipes sobre anemia falciforme, além de divulgar listas de usuários diagnosticados com a doença, a fim de subsidiar a busca ativa e o acompanhamento do tratamento e da evolução clínica desses pacientes pelas unidades de saúde.

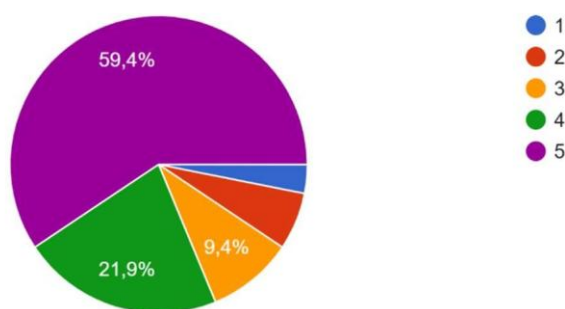
Em 2023, o município de Porto Alegre institucionalizou uma linha de cuidado estruturada para pessoas com doença falciforme, adotando um protocolo clínico com fluxo de

atendimento que organiza o itinerário terapêutico desde o diagnóstico até a atenção especializada. O documento define os papéis de cada ponto de serviço, assegura o diagnóstico precoce e promove mecanismos de monitoramento e contrarreferência. Essa iniciativa local encontra respaldo nas orientações nacionais do Ministério da Saúde para hemoglobinopatias, o que reforça a coerência entre a política municipal e o âmbito federal. (Porto Alegre, 2023)

Assim, para a população que vive com anemia falciforme em Porto Alegre, esse fluxo representa um avanço significativo na garantia da integralidade do cuidado, ao articular de forma explícita a rede de atenção e reduzir lacunas de atendimento, sobretudo no cenário da atenção primária.

Figura 13. Questão 9.5

9.5 Gestante com HIV
32 respostas



Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Questionário 1 (Questão 9.2), 2026.

Os resultados mostram um cenário oposto ao da anemia falciforme. A maioria absoluta (81,3% dos profissionais) se sente bem-preparada (notas 4 e 5) para encaminhar gestantes com HIV. Pode estar relacionado com alguns fatores tais como: Protocolos bem estabelecidos e amplamente divulgados no SUS para o manejo da gestante HIV+, especialmente no pré-natal e parto; Maior oferta de capacitações específicas nessa área devido à relevância para a saúde pública e metas globais de redução da transmissão vertical; canal de matriciamento pelo celular com Equipe de apoio e encaminhamento para setor Secundário de gestante com HIV.

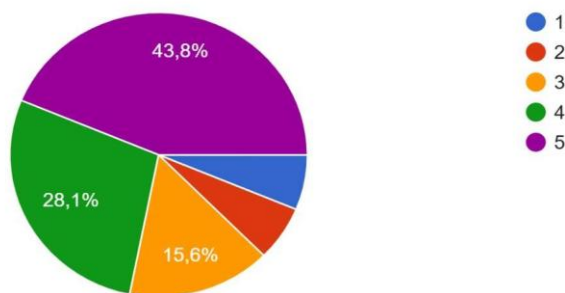
Em Porto Alegre, a Atenção Primária à Saúde desempenha papel central no manejo da gestante com HIV, iniciando precocemente pelo teste rápido em todos os trimestres e retomando-se também durante a amamentação conforme notas técnicas municipais. A gestante soropositiva é acompanhada de maneira integrada com os serviços especializados, garantindo vínculo, adesão ao tratamento e monitoramento da criança exposta ao vírus. Além disso, a APS participa da notificação e encaminhamento às instâncias como consultas em rede secundária como hospitalar e SAE. (Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, 2024).

Esse modelo de cuidado permite que a APS não opere apenas como porta de entrada, mas como ator articulador da rede, contribuindo para a redução da transmissão vertical do HIV e promoção de desfechos mais favoráveis.

Segundo Bardin (2011), esse dado evidencia uma categoria de segurança profissional, contrastando com a insegurança manifestada em temáticas menos frequentes na prática cotidiana, como a anemia falciforme.

Figura 14. Questão 9.6

9.6 Criança exposta ao HIV
32 respostas



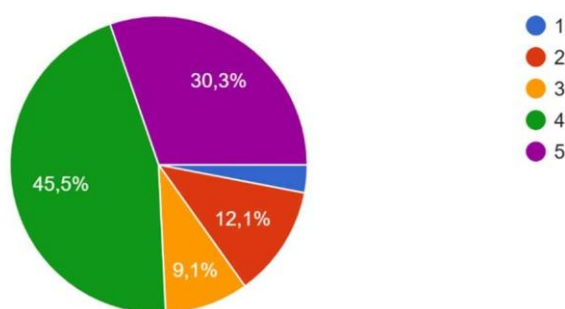
Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Questionário 1 (Questão 9.6), 2026.

Os resultados revelam que 71,9% dos profissionais (notas 4 e 5) se sentem preparados para atuar nos encaminhamentos de crianças expostas ao HIV, mas há uma parcela relevante (28,2%) que demonstra baixa ou média segurança (notas 1 a 3).

Através destes resultados é possível identificar uma maior familiaridade em relação ao cuidado da gestante HIV+ comparadas à criança exposta. Uma hipótese é de que as crianças permanecem acompanhadas no setor secundário e terciário dependendo do caso, acessando menos a APS e consequentemente gerando um menor conhecimento sobre esta temática. Segundo Bardin (2011), essa distribuição aponta para uma categoria de competência parcial, em que existe segurança, mas ainda acompanhada de insegurança diante de casos mais complexos.

Figura 15. Questão 9.7

9.7 Tabagismo
33 respostas



Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Questionário 1 (Questão 9.7), 2026.

A maioria dos profissionais (75,8% com notas 4 e 5) demonstra segurança sobre o tema do tabagismo. Apenas 24,2% apresentaram baixa ou média confiança (notas 1 a 3), revelando que, embora existam dificuldades, a maior parte da equipe se sente apta a atuar. Esse resultado sugere que o manejo do tabagismo está mais consolidado nas práticas de saúde, possivelmente devido a protocolos bem definidos e programas já estabelecidos através do Programa Nacional de Controle do Tabagismo e capacitações periódicas com profissionais do município com apoio do INCA.

A consolidação das práticas de cessação do tabagismo na Atenção Primária à Saúde de Porto Alegre reflete atributos centrais da APS descritos por Starfield (2002), como a integralidade, a longitudinalidade e a coordenação do cuidado. O acompanhamento contínuo, a escuta qualificada e o vínculo entre profissionais e usuários favorecem não apenas a redução do

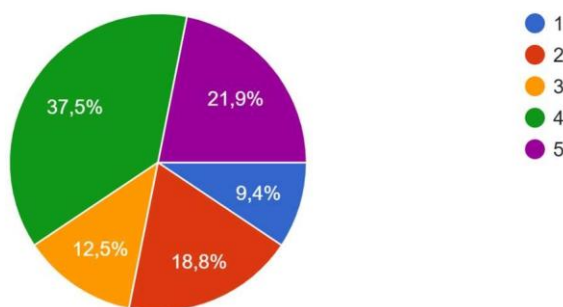
consumo de tabaco, mas também a promoção de hábitos saudáveis e o fortalecimento da autonomia dos indivíduos. Nesse sentido, a abordagem do tabagismo se aproxima da concepção de cuidado proposta por Minayo (2014), que valoriza a dimensão relacional, educativa e subjetiva das práticas em saúde. Os resultados alcançados nos grupos de cessação do município reforçam esse papel da APS como espaço de escuta, vínculo e transformação, sustentado por protocolos consolidados e por uma atuação multiprofissional integrada (Pretto et al., 2018]; Krinski et al., 2018)

Estudos realizados em unidades de saúde do município evidenciaram que os grupos de cessação do tabagismo podem alcançar taxas expressivas de abstinência, variando entre 35% e 50%, com destaque para o papel da equipe multiprofissional e o vínculo estabelecido com os usuários (Pretto et al., 2018).

Seguindo a análise de Bardin (2011), o conjunto de respostas aponta para uma categoria de domínio elevado, embora ainda demande reforço para parte da equipe que não se sente totalmente segura.

Figura 16. Questão 9.8

9.8 Vacinação com indicação para CRIE
32 respostas



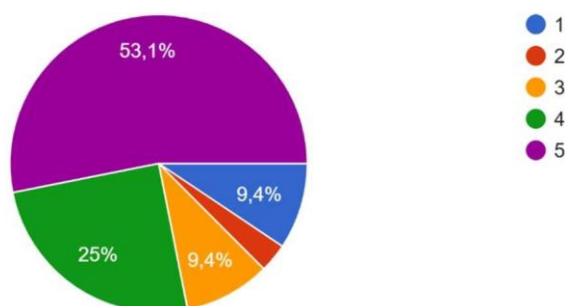
Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Questionário 1 (Questão 9.8), 2026.

A maioria dos participantes (59,4% com notas 4 e 5) demonstra segurança no manejo da vacinação com indicação para CRIE. Entretanto, 40,6% atribuíram notas entre 1 e 3, indicando fragilidades relevantes neste tema.

Esse resultado sugere que, embora parte da equipe se sinta capacitada, há um contingente expressivo que ainda apresenta insegurança na condução desses casos. Pela perspectiva da análise de conteúdo de Bardin (2011), emergem duas categorias distintas: Categoria de domínio parcial (maioria com segurança moderada a alta) e Categoria de dificuldade significativa (profissionais que precisam de reforço teórico-prático).

Figura 17. Questão 9.9

9.9 Programa Porto Olhar Alegre
32 respostas



Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Questionário 1 (Questão 9.9), 2026.

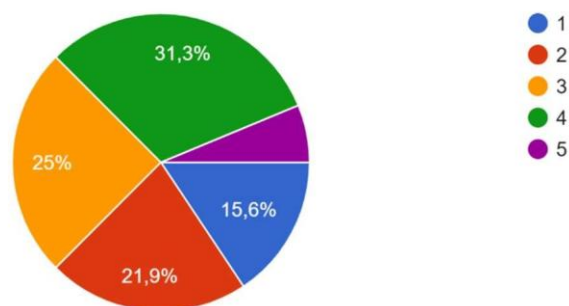
A maioria dos respondentes (78,1% com notas 4 e 5) demonstra alto grau de conhecimento e segurança em relação ao Programa Porto Olhar Alegre. Apenas 21,9% atribuíram notas entre 1 e 3, indicando pequenas lacunas de compreensão, mas sem comprometer o domínio geral do tema.

A análise evidencia um cenário amplamente favorável ao entendimento do Programa Porto Olhar Alegre entre os profissionais da APS. No entanto, a presença de uma minoria com dificuldades indica a necessidade de reforçar ações de comunicação, capacitação e suporte contínuo, de forma a garantir que o programa seja plenamente compreendido e aplicado por todos os envolvidos.

Figura 18. Questão 9.10

9.10 Saúde da População Negra

32 respostas



Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Questionário 1 (Questão 9.10), 2026.

O resultado demonstra heterogeneidade no conhecimento, com distribuição equilibrada entre notas baixas (1 a 3 = 62,5%) e altas (4 e 5 = 37,6%). Isso evidencia que o tema apresenta lacunas significativas de compreensão entre os respondentes, configurando-se como um ponto crítico a ser priorizado em formações futuras.

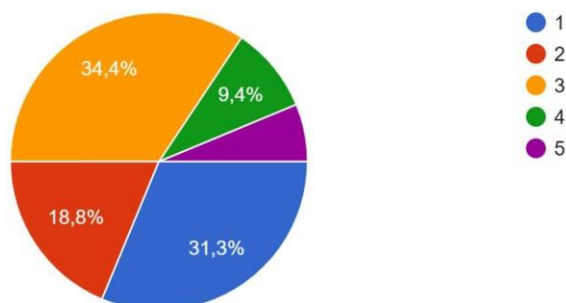
Diferentemente de outros tópicos analisados (como HIV e Programa Porto Alegre, que tiveram alta concentração em notas 4 e 5), este item apresenta um nível de dispersão que sugere insegurança conceitual e prática profissional limitada.

Conforme Bardin (2011), pode-se categorizar este resultado como uma área de fragilidade, necessitando de maior ênfase pedagógica e estratégias específicas de sensibilização.

Figura 19. Questão 9.11

9.11 Saúde da População Imigrante

32 respostas



Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Questionário 1 (Questão 9.11), 2026.

Este foi um dos temas com menor concentração de notas altas (4 e 5 = apenas 15,7%) em comparação aos demais. A maioria das respostas ficou entre nota 1, 2 e 3 (84,5%), o que evidencia baixa familiaridade dos respondentes com a temática da saúde da população imigrante.

Apesar de Porto Alegre possuir uma grande concentração de imigrantes, essa nota pode estar associada ao fato de que nem todos os profissionais têm contato direto com esse público, o que pode reduzir a prática e o conhecimento aplicado.

Em termos de análise categorial (Bardin, 2011), este resultado pode ser interpretado como uma categoria crítica de conhecimento deficitário, demandando ações específicas de capacitação e sensibilização intercultural.

Tabela 3. Tabela comparativa – Questões 9.1 a 9.11

Questão	Tema	N1	N2	N3	N4	N5
9.1	Hanseníase	34,4	25,0	25,0	12,5	3,1

9.2	Tuberculose	3,2	12,9	16,1	51,6	16,1
9.3	Dengue	3,1	6,3	6,3	12,5	71,9
9.4	Anemia Falciforme	21,9	28,1	13,4	9,4	6,3
9.5	Gestante HIV	3,1	6,3	9,4	21,9	59,4
9.6	Criança exposta ao HIV	6,3	6,3	15,6	28,1	43,8
9.7	Tabagismo	3,0	12,1	9,1	45,5	30,3
9.8	Vacinação no CRIEE	9,4	18,8	12,5	37,5	21,9
9.9	Porto Olhar Alegre	9,4	3,1	9,4	25,0	53,1
9.10	Saúde da população negra	15,6	21,9	25,0	31,3	6,3
9.11	Saúde da população imigrante	31,3	18,8	34,4	9,4	6,3

Fonte: Elaborado pela autora

A análise comparativa evidencia diferenças importantes na percepção de aptidão dos profissionais para realização de encaminhamentos nas diferentes temáticas. Observa-se maior concentração de respostas nos níveis 4 e 5 nas temáticas relacionadas à Dengue (84,4%), gestante vivendo com HIV (81,3%), Porto Olhar Alegre (78,1%), Tabagismo (75,8%), Criança exposta ao HIV (71,9%) e Tuberculose (67,7%), indicando maior segurança percebida nessas áreas. Esses resultados sugerem que se trata de temas mais incorporados ao cotidiano das equipes, possivelmente com fluxos mais consolidados e maior oferta de capacitações.

Por outro lado, temáticas como Hanseníase (15,6%), Anemia falciforme (15,7%) e População Imigrante (15,7%) apresentaram baixos percentuais nos níveis mais elevados da escala, além de concentração expressiva nos níveis 1 e 2. Esses achados apontam para menor segurança percebida, o que pode estar relacionado à menor frequência dos casos, à fragmentação das informações ou à dificuldade de acesso aos fluxos e normativas específicas.

A temática Vacinas CRIE também demonstra espaço para qualificação, com apenas 29,4% nos níveis 4 e 5, o que pode refletir dúvidas quanto aos critérios de encaminhamento e à organização do acesso.

De modo geral, os resultados evidenciam que a percepção de aptidão não é homogênea entre os diferentes temas, reforçando a importância de estratégias direcionadas de educação permanente e de organização das informações. A sistematização dos links e fluxos em um único guia digital dialoga diretamente com essas lacunas identificadas, buscando fortalecer a segurança dos profissionais e qualificar o processo de encaminhamento na Atenção Primária à Saúde.

Questão 10 e questão 10.1

10. Gostaria de sugerir temas que possuem dificuldades em obter informações sobre atendimentos e encaminhamentos na Atenção Primária de Porto Alegre?

10.1 Gostaria de deixar uma sugestão sobre como poderia ser feito em relação à questão anterior (10)?

As sugestões de temas sobre os quais os profissionais relatam dificuldades em obter informações na Atenção Primária de Porto Alegre podem ser agrupadas em cinco grandes eixos:

Encaminhamentos e fluxos assistenciais: Dificuldade em encaminhar para especialidades, ausência de fluxos claros para situações sociais e vulneráveis (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar), Programa Porto Olhar Alegre, problemas no atendimento de urgência (DEA, ausência de capacitação, POPs insuficientes, tempo-resposta do SAMU).

Saúde de populações específicas: Dificuldades em temas de saúde da mulher, gestação em casal homoafetivo (mulheres), questões relacionadas ao pré-natal.

Doenças infectocontagiosas e raras: Hanseníase, HTLV, hepatites, tuberculose, HIV (adultos e pediatria), doenças infectocontagiosas no geral, doenças raras.

Zoonoses: Esporotricose e leishmaniose, com ênfase em notificação, tratamento e manejo dos animais conviventes.

Outros temas clínicos/administrativos: Oxigênio domiciliar, atestados de saúde ocupacional na APS, exames pré-operatórios na APS.

Sem sugestões: Alguns participantes responderam "sem sugestões" ou "não".

A análise das respostas demonstra que os profissionais apresentam dificuldades em diferentes áreas, que vão desde aspectos clínicos até questões administrativas e sociais.

Entre os principais pontos levantados, destacam-se as fragilidades relacionadas aos encaminhamentos e fluxos assistenciais, tanto para especialidades médicas quanto para serviços da rede de apoio social, como CRAS, CREAS e Conselho Tutelar. Observa-se, ainda, menção a problemas na articulação com programas específicos, como o Porto Olhar Alegre, bem como falhas no suporte ao atendimento de urgência, especialmente no uso do DEA, ausência de capacitações adequadas e tempo-resposta do SAMU.

Outro eixo importante refere-se à saúde da mulher e de populações específicas, com destaque para dificuldades no manejo do pré-natal e entre casais homoafetivos. Soma-se a isso a necessidade de maior suporte técnico em doenças infectocontagiosas, incluindo hanseníase, HTLV, hepatites, tuberculose, HIV (adultos e pediátrico) e doenças raras.

As zoonoses também foram mencionadas, em especial esporotricose e leishmaniose, com preocupação não apenas no diagnóstico e tratamento, mas também no manejo dos animais que convivem com os usuários.

Além desses aspectos, os profissionais relataram lacunas em demandas práticas e administrativas do cotidiano da APS, como oxigenoterapia domiciliar, emissão de atestados de saúde ocupacional e realização de exames pré-operatórios.

Na questão 10.1 foram registradas 16 respostas que trazem propostas de melhoria frente às dificuldades relatadas anteriormente (Questão 10). De modo geral, observa-se uma forte ênfase em capacitação contínua e na organização de fluxos de trabalho mais transparentes e acessíveis.

Verifica-se a solicitação por espaços de formação continuada, que contemplem estudos de casos clínicos, treinamentos práticos e protocolos atualizados, sobretudo em situações de maior complexidade ou urgência. Essa necessidade está diretamente relacionada com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), que defende processos formativos integrados ao cotidiano do trabalho e voltados para a resolução de problemas reais do território (BRASIL, 2004).

A solicitação de diferentes turnos e múltiplas datas de capacitação evidencia a busca por equidade de acesso, assegurando que todos os profissionais possam participar, conforme sua disponibilidade.

Os participantes sugerem a criação de materiais objetivos e acessíveis (painéis, tutoriais, fluxogramas) que permitam consulta rápida durante a prática profissional. Essa demanda se relaciona ao conceito de gestão da informação e do conhecimento em saúde, apontado por Feuerwerker (2005) como essencial para aumentar a autonomia dos profissionais e a qualidade do cuidado.

Também emerge a necessidade de integração entre diferentes serviços e órgãos, evitando a fragmentação do sistema e assegurando um cuidado coordenado, princípio estruturante da APS segundo Starfield (2002).

Em síntese, as respostas revelam a urgência de instrumentos que combinem formação continuada e praticidade na gestão da informação, oferecendo subsídios para decisões rápidas e seguras no cotidiano da APS.

O Guia digital se apresenta como uma resposta estratégica às lacunas identificadas nesta questão, não substituindo os processos formativos, mas constituindo uma ferramenta complementar e permanente, favorecendo a atualização contínua e a autonomia dos profissionais da APS.

A validação da versão pré-final do produto educacional foi realizada por meio da aplicação de um instrumento específico, denominado ‘Questionário 2’, encaminhado aos profissionais atuantes na Atenção Primária à Saúde que haviam participado da etapa anterior da pesquisa, respondendo ao Questionário 1. Tal escolha metodológica mostrou-se estratégica, uma vez que possibilitou a avaliação do material por sujeitos que já detinham conhecimento prévio acerca do guia em processo de construção, favorecendo análises mais qualificadas e fundamentadas.

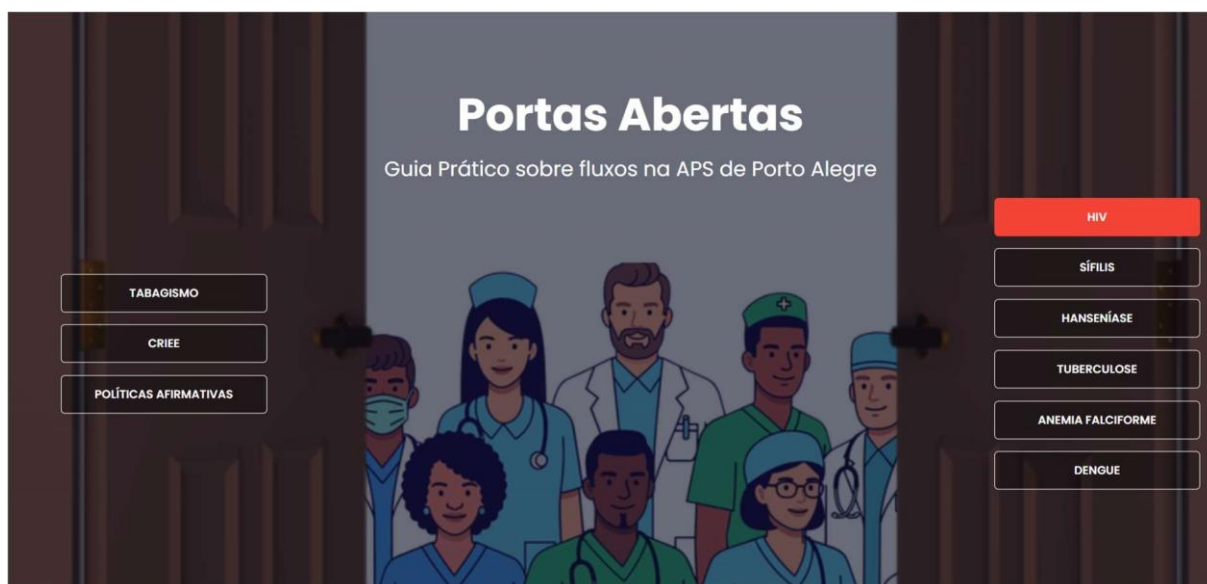
Esta etapa consistiu em verificar a adequação do guia digital quanto ao conteúdo apresentado, à linguagem utilizada e à organização estrutural, subsidiando os ajustes necessários antes da consolidação de sua versão definitiva.

Para tanto, os participantes receberam acesso à versão preliminar do material, sendo convidados a realizar uma apreciação crítica. O processo de validação assumiu caráter eminentemente formativo, na medida em que não se buscou a homologação de um produto acabado, mas sim a incorporação das contribuições dos profissionais que atuam diretamente no cotidiano das unidades de saúde, de modo a identificar fragilidades, potencialidades e possibilidades de aprimoramento do guia, assegurando sua pertinência e aplicabilidade no contexto da Atenção Primária à Saúde.

Optou-se por apresentar a seguir a versão preliminar do guia por meio de capturas de tela, considerando que o link atualmente disponível direciona à versão revisada, já modificada a partir das sugestões e contribuições recebidas ao longo do processo. A inclusão dos prints justifica-se pela necessidade de preservar o registro da versão correspondente à etapa analisada nesta pesquisa, assegurando fidedignidade entre o material examinado, as discussões realizadas e o estágio de desenvolvimento do produto educacional naquele momento.

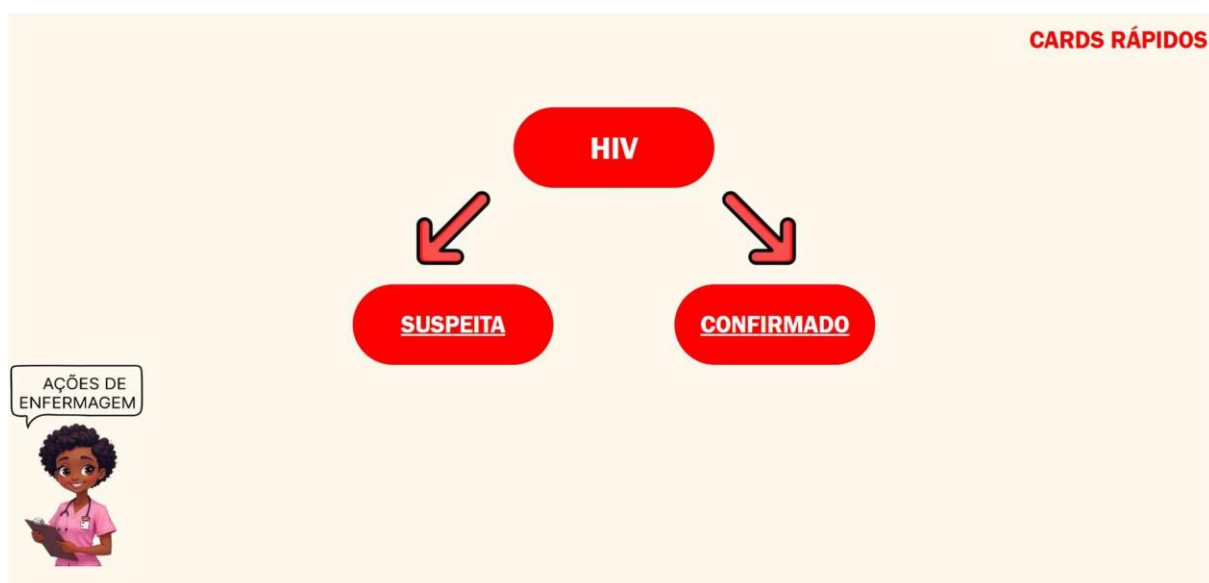
Tal procedimento contribui para a transparência metodológica do estudo, ao explicitar a evolução do guia e situar o leitor quanto às modificações posteriores, que não integram a versão submetida à análise neste capítulo.

Figura 20. Captura de tela “Capa” na versão preliminar do guia Portas Abertas



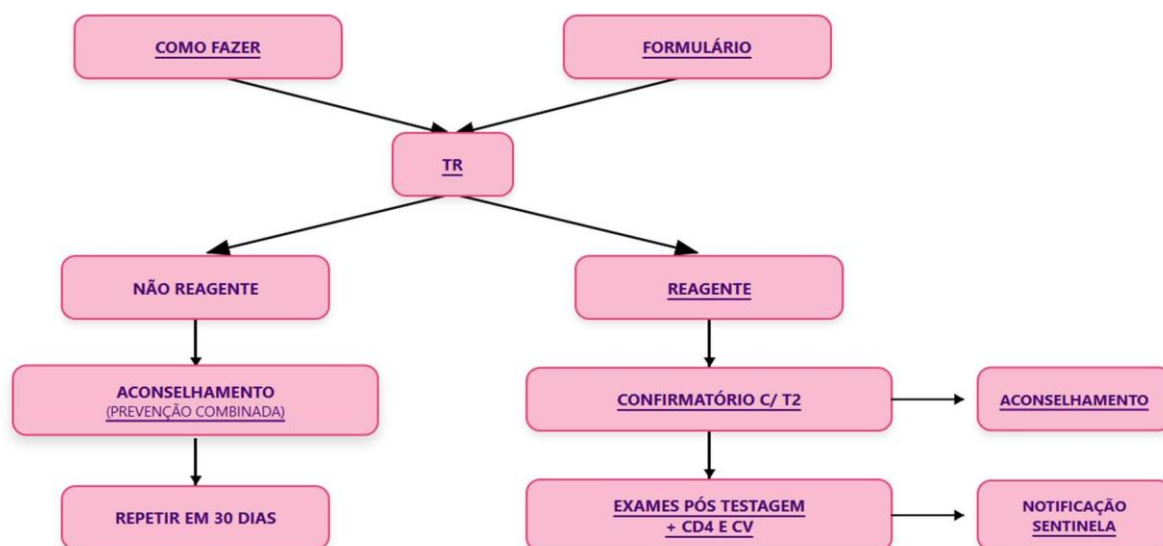
Fonte: Elaboração própria, referente à versão preliminar do Guia Digital Portas Abertas (2025).

Figura 21. Captura de tela ao clicar no agravo “HIV” na versão preliminar do guia digital Portas Abertas



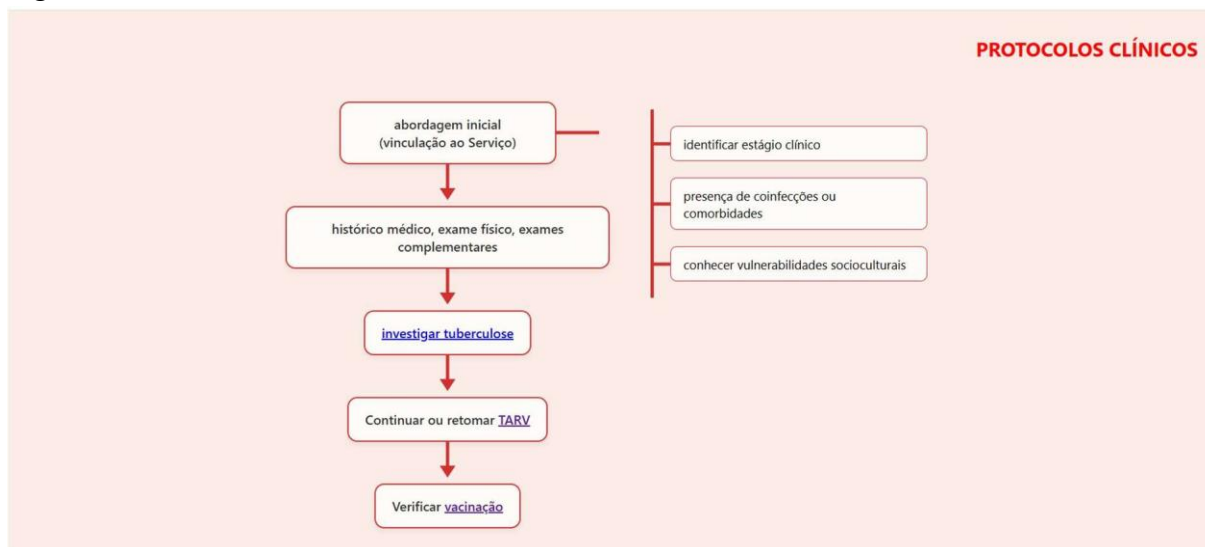
Fonte: Elaboração própria, referente à versão preliminar do produto educacional Portas Abertas (2025).

Figura 22. Captura de tela da aba “HIV – Suspeita” na versão preliminar do guia.



Fonte: Elaboração própria, referente à versão preliminar do Guia Digital Portas Abertas (2025).

Figura 23. Captura de tela ao clicar no agravo “HIV-Confirmado” na versão preliminar do guia digital Portas Abertas



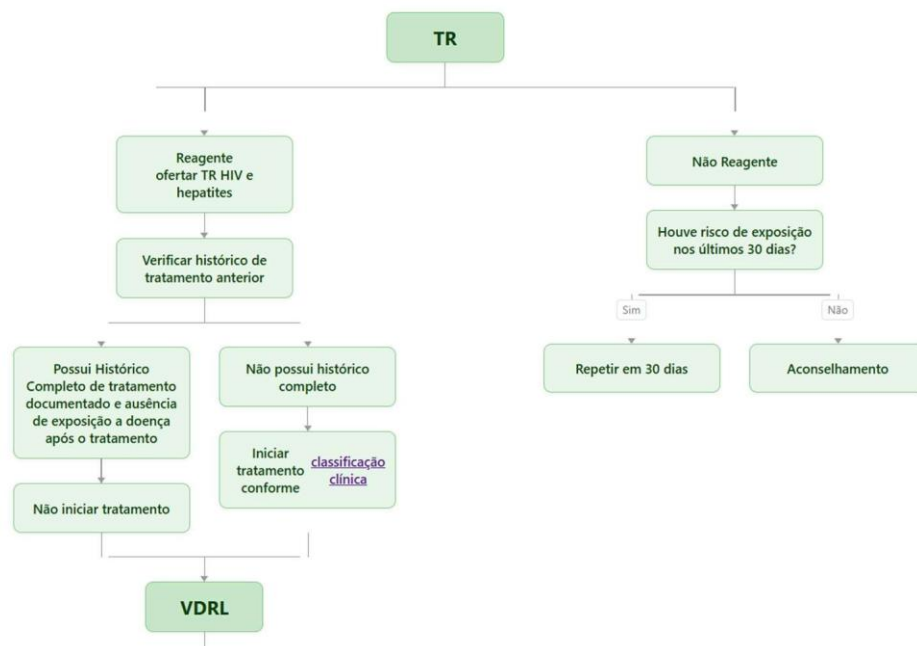
Fonte: Elaboração própria, referente à versão preliminar do Guia Digital Portas Abertas (2025).

Figura 24. Captura de tela ao clicar no agravo “SÍFILIS” na versão preliminar do guia digital Portas Abertas



Fonte: Elaboração própria, referente à versão preliminar do Guia Digital Portas Abertas (2025).

Figura 25. Captura de tela da aba “Sífilis Adquirida” na versão preliminar do guia.



Fonte: Elaboração própria, referente à versão preliminar do Guia Digital Portas Abertas (2025).

Considerando o volume de conteúdo do guia, foi apresentado apenas capturas de tela selecionadas, de modo a não tornar o capítulo excessivamente extenso. As imagens incluídas têm caráter ilustrativo e buscam situar o leitor quanto à organização, à disposição dos conteúdos e ao formato do material na versão preliminar analisada, não se propondo a reproduzi-lo integralmente.

5.2 ACHADOS E ANÁLISES DO QUESTIONÁRIO 2:

As análises referentes ao Questionário 2 consideram que o instrumento foi encaminhado, via correio eletrônico (e-mail), a todos os participantes que responderam ao Questionário 1, totalizando 34 envios. Desse total, foram obtidas oito respostas válidas, o que corresponde a uma adesão parcial dos participantes ao segundo momento da pesquisa.

Parte I – Caracterização dos avaliadores

No que se refere à formação profissional, os respondentes foram compostos por sete enfermeiros e um médico. Quanto ao campo de atuação, todos os participantes exerciam suas atividades na Atenção Primária à Saúde. Em relação à função desempenhada no período da pesquisa, dois profissionais ocupavam cargos de gestão, enquanto os demais atuavam diretamente na assistência. O tempo de experiência profissional evidenciou um perfil com trajetória consolidada na área, variando entre três e vinte anos de atuação, com média aproximada de doze anos.

Ao analisar o tempo médio de atuação na Atenção Primária à Saúde (APS) dos respondentes, estimado em 12 anos, faz-se necessária uma ressalva de natureza metodológica e contextual. Embora expressivo, este dado possivelmente não representa a realidade atual da totalidade da rede municipal de Porto Alegre, caracterizada por um modelo de gestão predominantemente terceirizado e por elevada rotatividade de profissionais.

Parte-se da hipótese de que a amostra tenha sido composta majoritariamente por servidores estatutários, cujos vínculos laborais estáveis favorecem trajetórias longitudinais no serviço. Ademais, é imprescindível considerar o contexto político-institucional marcado por processos de transição contratual das entidades parceiras, cenário que tem produzido insegurança laboral e sobrecarga emocional entre os profissionais contratados, fatores que podem ter influenciado negativamente a adesão e a disponibilidade desses sujeitos para participação em pesquisas acadêmicas.

Apesar de terem sido apenas oito profissionais respondentes, destaca-se que a profundidade e a qualidade do conhecimento técnico acumulado por esses profissionais conferem elevada relevância aos dados obtidos. A experiência construída ao longo de mais de uma década de atuação direta na ponta do serviço assegura que as contribuições incorporadas à construção deste Guia com os fluxos da Atenção Primária à Saúde estejam fundamentadas em uma vivência prática e histórica consolidada, permitindo a validação do produto por profissionais que detêm a memória institucional e técnica da rede.

Parte II – Avaliação do conteúdo do guia

A Parte II do instrumento de coleta de dados foi destinada à avaliação do conteúdo do guia prático desenvolvido, com foco na análise da qualidade técnica e da aplicabilidade do material no contexto da Atenção Primária à Saúde. Para essa etapa, foi elaborado um

questionário estruturado contendo oito itens avaliativos, contemplando os seguintes aspectos: clareza dos objetivos, adequação ao público-alvo, coerência com os princípios da Atenção Primária à Saúde, coerência temática, linguagem, organização e estrutura, relevância para a prática profissional e aplicabilidade no cotidiano dos serviços.

Cada item foi avaliado por meio de uma escala do tipo Likert de quatro pontos, variando de 1 a 4, sendo: 1 – não relevante/inadequado; 2 – pouco relevante/necessita muitas revisões; 3 – relevante/necessita pequenas revisões; e 4 – muito relevante/adequado.

A escolha de uma escala sem ponto neutro teve como objetivo estimular um posicionamento mais definido por parte dos respondentes quanto à qualidade do material.

Abaixo, apresenta-se a reprodução da escala utilizada no Questionário 2 para avaliação da percepção de aptidão profissional.

Figura 26. Questão II da avaliação do guia no Questionário

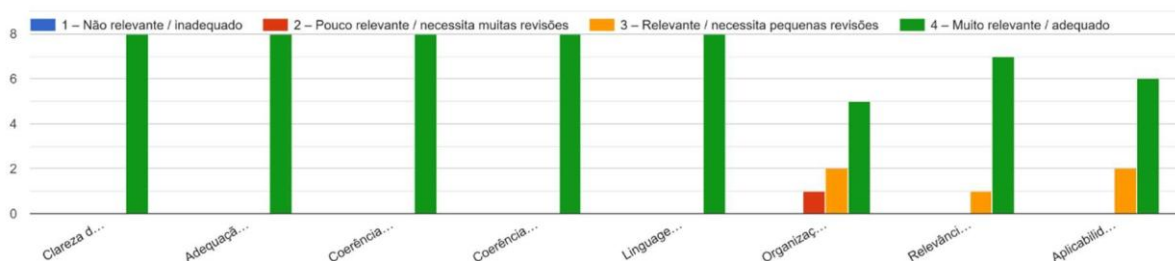
	1 – Não relevante / inadequado	2 – Pouco relevante / necessita muitas revisões	3 – Relevante / necessita pequenas revisões	4 – Muito relevante / adequado
Clareza dos objetivos do guia	☐	☐	☐	☐
Adequação do conteúdo ao público-alvo	☐	☐	☐	☐
Coerência do conteúdo com os princípios da Atenção Primária à Saúde	☐	☐	☐	☐
Coerência do conteúdo com a Atenção Primária à Saúde	☐	☐	☐	☐
Linguagem clara e acessível	☐	☐	☐	☐
Organização e estrutura do material	☐	☐	☐	☐
Relevância do conteúdo para a prática profissional	☐	☐	☐	☐
Aplicabilidade do guia no cotidiano dos serviços de saúde	☐	☐	☐	☐

Fonte: Elaboração própria, a partir do Questionário 2 da pesquisa (2025).

A Figura a seguir apresenta a distribuição das respostas dos profissionais quanto à percepção de aptidão para realização dos encaminhamentos, conforme escala de 0 a 5.

Figura 27. Distribuição das respostas na parte II na avaliação do guia quanto à relevância, clareza e aplicabilidade, conforme Questionário 2.

Avalie cada item de acordo com sua percepção, considerando a relevância, clareza e aplicabilidade do guia no contexto da Atenção Primária à Saúde.



Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Questionário 2 da pesquisa (2026)

A análise dos resultados da parte II evidencia uma avaliação predominantemente positiva dos respondentes em relação ao guia prático desenvolvido, considerando os critérios de relevância, clareza e aplicabilidade no contexto da Atenção Primária à Saúde. Observa-se que a maior parte dos itens avaliados se concentrou na categoria “muito relevante/adequado”, indicando boa aceitação geral do material entre os profissionais participantes.

Os aspectos relacionados à clareza, adequação do conteúdo, coerência interna e linguagem apresentaram avaliações unânimes ou quase unânimes na categoria mais alta da escala, o que sugere que o guia foi compreendido de forma consistente e alinhado às necessidades informacionais do cotidiano dos serviços de saúde. Esse resultado reforça a importância da organização de conteúdos técnicos em linguagem acessível, especialmente no contexto da APS, onde a tomada de decisão é frequentemente rápida e baseada em protocolos e orientações práticas.

Em relação à organização do material, embora a maioria dos respondentes tenha atribuído a classificação de “muito relevante/adequado”, observa-se a presença de avaliações intermediárias, indicando a necessidade de pequenos ajustes estruturais. Esse achado aponta para oportunidades de aprimoramento na disposição dos conteúdos ou na navegação do guia, sem comprometer sua efetividade geral.

Os critérios de relevância e aplicabilidade prática também foram majoritariamente avaliados de forma positiva, ainda que com algumas respostas indicando necessidade de pequenas revisões. Esses resultados sugerem que, embora o guia atenda às demandas do

trabalho na Atenção Primária, há espaço para aperfeiçoamentos pontuais que possam ampliar sua aderência aos diferentes contextos territoriais e realidades dos serviços.

De modo geral, os dados indicam que o guia prático se configura como uma ferramenta pertinente e útil para apoiar os processos de trabalho na Atenção Primária à Saúde, contribuindo para a organização do cuidado, o acesso à informação e a qualificação das práticas profissionais. As sugestões implícitas nas avaliações intermediárias reforçam a importância de processos contínuos de revisão e atualização do material, em consonância com os princípios da educação permanente em saúde.

Parte III– Avaliação global

Figura 28. Questão 1 da seção III da avaliação do guia no Questionário 2.

O conteúdo do guia, de forma geral, é adequado para o contexto da Atenção Primária à Saúde?

8 respostas

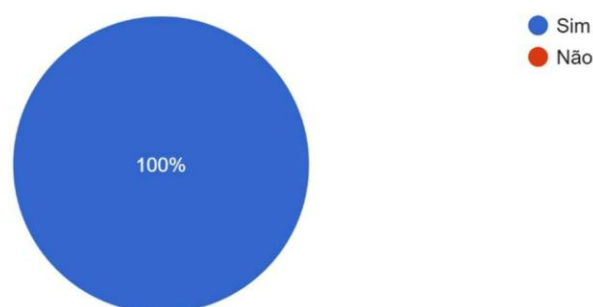


Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Questionário 2 da pesquisa (2026).

Figura 29. Questão 2 da seção III da avaliação do guia no Questionário 2

Você recomendaria a utilização deste guia após eventuais ajustes?

8 respostas



Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Questionário 2 da pesquisa (2026).

Na Parte III do instrumento, que trata da Avaliação Global do Guia, obteve-se unanimidade (100%) entre os respondentes quanto à adequação do conteúdo ao contexto da Atenção Primária à Saúde (APS) e à recomendação de sua utilização após os ajustes sugeridos.

Este resultado é particularmente significativo quando cruzado com o tempo de serviço dos participantes (média de 12 anos). O fato de profissionais experientes e com longa trajetória na rede validarem o instrumento indica que o Guia não apenas atende aos requisitos teóricos, mas possui aderência à realidade operacional do serviço. A recomendação unânime sugere que o Guia preenche uma lacuna de padronização ou suporte à decisão clínica/gerencial sentida por quem atua na ponta.

Embora a amostra seja reduzida e possivelmente enviesada pela maior participação de profissionais estatutários, o consenso absoluto reforça a potencialidade do Guia como ferramenta de gestão. A validação integral por este grupo confere ao material a legitimidade necessária para ser proposto como uma tecnologia leve de organização do trabalho, capaz de nortear inclusive os profissionais que ingressam na rede via novos contratos de gestão, auxiliando na mitigação dos efeitos da rotatividade.

A análise qualitativa dos comentários revelou uma alta aceitação da ferramenta, destacando sua potencialidade em substituir fluxos informais de comunicação (como arquivos em aplicativos de mensagens) por uma plataforma centralizada e fidedigna. As sugestões dos participantes convergiram para a necessidade de maior consistência visual e redução da carga

cognitiva, através de explicações breves nos títulos e manutenção de padrões estéticos entre os agravos. Notavelmente, a demanda por conteúdo multimídia e a preocupação com a expansão futura do Guia para outras patologias demonstram que o produto é percebido pelos profissionais como uma tecnologia necessária e sustentável para a rotina da APS, validando a clareza e a objetividade da estrutura proposta.

Parte IV – Sugestões e comentários

Espaço para sugestões de melhoria, ajustes de conteúdo, linguagem ou estrutura: Questão:
Deixe aqui sua sugestão ou comentário

A questão aberta “Deixe aqui sua sugestão ou comentário” possibilitou aos participantes registrarem percepções, críticas e propostas de aprimoramento relacionadas aos fluxos assistenciais. As contribuições foram analisadas, categorizadas e organizadas no quadro a seguir, já acompanhadas dos respectivos encaminhamentos definidos a partir da análise.

Quadro 2 - Síntese de sugestões dos participantes e dos encaminhamentos após análise.

Categoria	Sugestão do Participante	Encaminhamento/Ação no Guia
Interface	Manter o mesmo padrão de layout e cores de fundo entre os fluxos.	Implementado: Padronização da paleta de cores e tipografia em todos os agravos, garantindo identidade visual
Navegação	Evitar direcionamento para páginas externas; manter o conteúdo na mesma página	Implementado: Substituição de links externos por janelas sobrepostas ou expansores de texto

Conteúdo	Inserir breve explicativo abaixo dos títulos, especialmente nos Cards Rápidos.	Proposta futura: Será avaliado melhor, pois o objetivo é um guia prático
Multimídia	Inserir vídeos instrucionais para apoiar testes rápidos e procedimentos.	Proposta futura: Inclusão de hiperlinks para vídeos curtos do Ministério da Saúde e da SMS.
Arquitetura da Informação	Organizar patologias no menu prevendo expansão futura	Implementado: Reestruturação do menu lateral por categorias expansíveis, permitindo escalabilidade.
Funcionalidade	Transformar o Guia em aplicativo (app)	Proposta Futura: A autora possui interesse no desenvolvimento de uma versão em formato de aplicativo
Síntese dos protocolos.	Trazer protocolos de forma resumida para facilitar o manuseio durante o atendimento.	Implementado: Criação de uma seção com os principais protocolos da APS

Fonte: Elaboração própria, com base nas sugestões dos participantes e análise da autora (2025).

A etapa de avaliação do Guia da Atenção Primária à Saúde extrapolou a mera coleta de dados quantitativos, configurando-se como um processo dialógico de troca de saberes entre a academia e o serviço. Em um contexto marcado por desafios estruturais na APS de Porto Alegre, especialmente relacionados à terceirização da gestão e à elevada rotatividade de profissionais,

a participação de sujeitos com média de 12 anos de atuação constituiu-se como o principal diferencial qualitativo desta pesquisa.

Esses profissionais, que possuem uma memória técnica e institucional da rede, conferiram ao Guia a legitimidade necessária para sua aplicação prática. A concordância unânime quanto à adequação e à recomendação do material não se apresenta apenas como um indicador de êxito metodológico, mas como evidência de que o instrumento responde a uma demanda concreta por maior organização, padronização e agilidade nos fluxos assistenciais.

As críticas e sugestões apresentadas foram determinantes para o aprimoramento do produto educacional, promovendo ajustes que abrangeram desde aspectos visuais e de usabilidade até a proposição de recursos multimídia. A centralização e a sistematização de orientações anteriormente dispersas em grupos informais de comunicação e documentos não estruturados fortalecem a segurança do profissional no processo decisório e qualificam o cuidado prestado.

Além disso, o Guia assume papel estratégico na redução dos impactos negativos decorrentes da rotatividade de profissionais, ao oferecer um referencial único, atualizado e acessível, capaz de sustentar a continuidade e a eficiência do atendimento, independentemente da composição das equipes.

5.3 A CONSTRUÇÃO DO PRODUTO

Materiais de orientação subsidiam a orientação verbal dos profissionais da saúde aos pacientes e familiares, reforçando assim, a educação em saúde (Echer, 2005) e contribuindo para um melhor encaminhamento das questões pertinentes a fluxos e encaminhamentos gerais dentro da APS.

Observa-se um movimento crescente na produção de materiais educativos em saúde, especialmente voltados às doenças crônicas não transmissíveis. Recursos como cartilhas, folders e mídias digitais têm sido utilizados por profissionais de enfermagem, cuja atuação, em conjunto com equipes multiprofissionais, favorece a elaboração de conteúdos mais precisos e eficazes. O aprimoramento dos desenhos metodológicos e a definição de protocolos específicos são fundamentais para garantir maior fidedignidade dos dados e aceitação dos materiais. Nesse contexto, as pesquisas desenvolvidas demonstram o potencial da enfermagem na qualificação das práticas assistenciais em diferentes cenários de cuidado. (Galvão et al., 2022)

A organização do processo de trabalho constitui elemento fundamental para o alcance do conjunto de ações coordenadas pela Atenção Primária à Saúde (APS), viabilizando a atenção integral e contribuindo para o avanço na gestão do cuidado, bem como para o adequado ordenamento da rede de atenção à saúde. (Gleriano et al., 2021). Esta organização, ou melhor, esta reorganização dos fluxos de trabalho nas unidades configura-se como uma estratégia essencial para assegurar a qualidade da assistência prestada, de modo a garantir que o usuário encontre resolutividade e orientações adequadas ao buscar atendimento. Considerando que a Atenção Primária representa a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e desempenha o papel de eixo articulador do acesso aos demais níveis de atenção, a eficiência de seus processos internos torna-se determinante para a efetividade do sistema como um todo. (Lima; Souza; Vasconcelos, 2023)

Entretanto, o elevado volume de atendimentos demandados diariamente nesse nível de atenção tem resultado em sobrecarga assistencial, situação que, além de potencializar o risco de esgotamento físico e emocional das equipes multiprofissionais, pode comprometer a satisfação dos usuários. Nesse contexto, a reorganização dos fluxos de trabalho revela-se imprescindível, não pela criação de novos processos, mas pela qualificação e pelo aprimoramento daqueles já instituídos, visando ampliar a resolutividade da atenção prestada (Lima; Souza; Vasconcelos, 2023). Observa-se, ainda, uma forte relação entre a organização do processo de trabalho e o alcance de ações e serviços capazes de promover uma abordagem mais efetiva para a atenção integral (Gleriano et al., 2021).

Com base nos objetivos estabelecidos e a partir das respostas obtidas dos profissionais sobre as dificuldades enfrentadas no cotidiano do serviço, abordando especificamente os fluxos e encaminhamentos na APS foi desenvolvido um guia digital de apoio aos profissionais de saúde que ingressam na Atenção Primária à Saúde (APS). Esse guia prático digital foi desenvolvido com materiais didáticos de fácil consulta, contendo cards com resumos rápidos e links úteis e atualizados, para esclarecer dúvidas frequentes e facilitar a tomada de decisões no dia a dia. Este conjunto de recursos visa qualificar os atendimentos e otimizar a gestão do serviço, promovendo maior eficiência na comunicação e no encaminhamento de questões dentro da APS.

A organização dos serviços de saúde constitui um elemento essencial para a gestão da clínica e do cuidado. Para que essa organização se efetive, torna-se necessário recorrer a diferentes tecnologias e estratégias que favoreçam melhorias no acesso aos serviços e no

gerenciamento dos processos de trabalho. Sobretudo, espera-se que tais medidas repercutam positivamente nos indicadores de saúde, os quais representam um importante termômetro da efetividade da Atenção Primária à Saúde (APS).

O guia foi idealizado com o objetivo de apoiar os profissionais no trabalho cotidiano, reunindo os principais temas e fluxos da Atenção Primária de forma organizada. A proposta consiste em facilitar o acesso às informações, permitindo que dúvidas sejam resolvidas com agilidade e que os encaminhamentos sejam realizados de maneira mais precisa e eficiente. Ressalta-se que o referido guia não tem a finalidade de orientar o manejo clínico. Seu propósito é organizar os fluxos já existentes, facilitando o trabalho das equipes e garantindo maior alinhamento na rede de atenção.

A construção do guia foi realizada a partir da sistematização de protocolos, notas técnicas e materiais do BVAPS, organizando esse conteúdo disperso em um único instrumento de consulta. A pesquisa evidenciou a ausência de um espaço claro no qual os profissionais pudessem sanar dúvidas do cotidiano, o que gerava insegurança, retrabalho e variações nas condutas. A partir dessa lacuna, o guia surge como uma resposta prática, reunindo informações validadas e de uso frequente, de modo a fortalecer a autonomia das equipes e qualificar os processos da Atenção Primária à Saúde.

O guia começou a ser elaborado a partir dos temas que observo com maior frequência nas dúvidas trazidas durante meu trabalho de assessoria e monitoramento. Muitas vezes, eu mesma enfrento dificuldade para localizar os documentos norteadores ou identificar qual referência utilizar em cada situação. Essa experiência evidenciou a necessidade de reunir essas informações de forma organizada e acessível, o que motivou o desenvolvimento do material.

Optou-se por iniciar a construção do guia pelo tema HIV, considerando tratar-se de um assunto complexo, com grande volume de informações e frequentes dúvidas no cotidiano das equipes. O processo demandou vários dias de consulta à BVAPS, ao grupo de matriciamento via WhatsApp, além da revisão de protocolos e notas técnicas municipais. Contudo, na etapa referente à solicitação de exames, não foi localizada na BVAPS a versão editável do formulário para solicitação de carga viral do HIV. O documento foi obtido posteriormente por meio de contato informal com uma profissional que atua em serviço de coleta, que o disponibilizou via WhatsApp. Tal situação evidenciou a dificuldade de acesso a determinados materiais institucionais e reforçou a importância de organizar e centralizar esses recursos em um instrumento acessível aos profissionais, especialmente àqueles que não dispõem de redes

informais de apoio. Essa dificuldade não é um episódio isolado, mas um reflexo de uma fragilidade estrutural na disponibilização e atualização de documentos essenciais para o trabalho na atenção primária. A ausência de um repositório centralizado, alinhado e de fácil acesso faz com que profissionais recorram a soluções informais, como grupos de mensagens, colegas ou materiais desatualizados. Isso amplia o risco de inconsistências, gera insegurança nas condutas e impacta diretamente a qualidade do cuidado.

Na prática, realizar o manejo adequado é percebido como algo difícil para os profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde de Porto Alegre, devido a diversos fatores, como carga de trabalho, falta de materiais e ferramentas adaptados à realidade do município e incertezas sobre as formas de tratamento e controle adequadas. Existem também constantes esforços da gestão municipal relativos à vigilância, à prevenção e ao tratamento do HIV, assim como diversos relatos dos profissionais de saúde sobre casos detectados no âmbito assistencial (Pontes, 2024).

Ao reconhecer esse cenário, o guia assume um papel estratégico. Ele não apenas organiza conteúdos já existentes, mas também busca reduzir essa dependência de redes informais e garantir que informações fidedignas estejam disponíveis de forma confiável, atualizada e prática. Dessa forma, o guia se torna um instrumento de apoio ao trabalho, fortalecendo a autonomia profissional e contribuindo para a padronização de práticas na atenção primária.

Ao buscar materiais sobre sífilis, foi encontrado um material muito bom justamente com as fichas editáveis para solicitação de medicamentos e exames de HIV, estava dentro do protocolo de IST para enfermagem. Isso nos faz perceber que, embora também tenhamos ótimos materiais, eles estão muito dispersos. No dia a dia, os profissionais não têm tempo para ficar procurando informações em vários lugares. Por isso, organizar esses conteúdos de forma prática e acessível faz toda a diferença para apoiar o cuidado e agilizar os fluxos de trabalho.

Há bastante material qualificado sobre sífilis, mas ele está muito disperso. Para os profissionais, isso dificulta o acesso rápido à informação, já que ninguém consegue ficar abrindo vários documentos durante o atendimento. Reunir tudo em um único local ajudaria a agilizar o trabalho e garantir uma atuação mais segura.

A pesquisa bibliográfica no portal da BVAPS revelou dificuldades na localização de conteúdos sobre hanseníase, uma vez que os resultados priorizam conteúdos jornalísticos(notícias) em detrimento de materiais técnicos. Uma possibilidade de melhoria

identificada é a criação de uma divisão no site da BVAPS entre conteúdos destinados aos profissionais de saúde e aqueles voltados ao público em geral, uma vez que a ausência dessa segmentação dificulta a pesquisa por assunto e o acesso direcionado às informações. Embora exista a opção de filtro, entre notícias e serviços, a opção serviços não especifica que seja sobre a área profissional ou serviços prestados sobre aquela temática.

Figura 30. Captura de tela da busca por “hanseníase” no site BVAPS de POA

porto alegre
PREFEITURA

Serviços Prefeitura ▼ Órgãos ▼

INÍCIO > PESQUISA

Buscar

hanseníase

Tipo de conteúdo

Serviços ▼

Q Buscar

Não há resultados para a consulta.

Fonte: BVAPS Porto Alegre, captura de tela realizada pela autora (2025).

Não foram identificadas, no site BVAPS, informações direcionadas ao profissional de saúde sobre hanseníase, conforme evidenciado na figura acima.

Posteriormente, foi identificado que, há algum tempo, foi criada uma página específica destinada à vigilância. No entanto, essa informação poderia estar devidamente sinalizada na BVAPS ou, ainda, ao realizar uma busca pelo termo hanseníase, o acesso poderia direcionar automaticamente para a página da vigilância. Na ausência dessa sinalização, o profissional que não possui conhecimento prévio sobre a existência dessa página tende a não localizar os materiais de apoio disponíveis no âmbito municipal.

A temática seguinte abordada foi a tuberculose. Inicialmente, pressupôs-se que o conteúdo estivesse disponível na página da vigilância, por se tratar de um agravo transmissível. Contudo, tal material não foi encontrado nesse espaço. Diante disso, a busca foi retomada na BVAPS, onde os documentos foram localizados na aba “Políticas”. Essa experiência traz reflexões acerca do tempo disponível dos profissionais de saúde para realizar esse tipo de busca, considerando

que a organização do site não se dá por categorias de agravos, mas pela divisão entre programas, políticas e áreas profissionais.

Na prática, essa estrutura organizacional tende a dificultar a pesquisa durante o horário de trabalho, especialmente em situações nas quais o profissional necessita esclarecer dúvidas de forma rápida e objetiva. Ademais, ao navegar pela aba referente à tuberculose, constatou-se a disponibilização de quantidade reduzida de materiais. A partir dessa constatação, recordou-se que, no ano de 2025, a Prefeitura publicou um protocolo específico sobre tuberculose; entretanto, o referido documento não se encontra disponível nesse setor da BVAPS, conforme evidenciado no registro da pesquisa apresentado a seguir.

Figura 31. Captura de tela da busca por “tuberculose” no site BVAPS de POA



^ TUBERCULOSE	
 Orientações - Consulta de Resultado Online.pdf	363.31 KB
 Guia e Orientações - Coleta de Escarro.pdf	1.04 MB
 Solicitação de Radiografia (RX) - Tórax - Tuberculose.pdf	370.77 KB
 Prova Tuberculínica - Técnicas de Aplicação e Leitura.pdf	4.77 MB
 Documento - Transferência de Usuário - Fora do Município - Tuberculose.pdf	256.16 KB
 Formulário - Ficha - Notificação - Tuberculose.pdf	308.55 KB
 NI 01-25 - Metodologias para TDO.pdf	57.56 KB

Fonte: BVAPS Porto Alegre, captura de tela realizada pela autora (2025).

Figura 32. Captura de tela da busca por “tuberculose” no site BVAPS de Porto Alegre na aba Protocolos de Enfermagem

A Coordenação de Enfermagem (COENF), subordinada à DAPS, é responsável pela supervisão técnica e pela garantia da qualidade nos serviços de enfermagem na Atenção Primária à Saúde, em conformidade a legislação vigente. Suas atividades incluem a elaboração de contratos e protocolos, controle de insumos e padronização de materiais, além de visitas técnicas para assegurar a qualidade dos serviços. A COENF também promove capacitações, educação continuada e ações para melhorar a cobertura vacinal, integrando-se aos programas municipais e residência multiprofissional.

Para entrar em contato você pode enviar um e-mail para: coordenacaodeenfermagemdaps@portoalegre.rs.gov.br

^ PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM	
 Protocolo - Guia - Programa Municipal de Controle do Tabagismo - Porto Alegre.pdf	4.28 MB
 Nota Técnica - Orientações - Programa Municipal de Controle do Tabagismo - Porto Alegre - Protocolo.pdf	82.5 KB
 Protocolo - Enfermagem - Saúde do Adulto - 2025.pdf	13.19 MB
 Portaria - Enfermagem - Saúde do Adulto - Protocolo - 2025.pdf	65.08 KB
 Protocolo - Tuberculose - Atenção Primária à Saúde.pdf	2.73 MB

Fonte: BVAPS Porto Alegre, captura de tela realizada pela autora (2025).

O Protocolo encontra-se na aba áreas profissionais/enfermagem/Protocolo.

Dessa forma, localizar os materiais produzidos pelo Município não se mostra uma tarefa simples, pois o profissional precisa buscar o mesmo tema em diferentes espaços até encontrar o conteúdo de que necessita.

Após a leitura do Protocolo e da necessidade de inserir os links no Guia, foi preciso retomar a navegação pela aba Políticas. Para um profissional novo e com tempo reduzido de atendimento por consulta, torna-se bastante difícil permanecer navegando pelo site da BVAPS para sanar suas dúvidas.

Ao analisar as informações referentes aos resultados de exames, identificou-se com facilidade o conteúdo relacionado ao Laboratório Central na aba em que se encontrava a navegação. Contudo, não foram localizadas informações sobre o GAL, sistema gerenciador dos resultados de exames de tuberculose utilizado em determinados serviços. Considerou-se, inicialmente, que esse conteúdo pudesse estar disponível na aba referente ao Laboratório. Ao acessar a seção “Serviços”, foi identificada a existência dessa aba; entretanto, constatou-se que ela se encontrava vazia, conforme evidenciado na análise apresentada a seguir

Figura 33. Captura de tela da busca por “Serviços Laboratoriais” no site BVAPS de Porto Alegre

Serviços Laboratoriais

BIBLIOTECA VIRTUAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida João Pessoa, 325
Porto Alegre/RS
CEP 90040-000

(51) 3289-2778

 repositorio.sms@portoalegre.rs.gov.br

Fonte: BVAPS Porto Alegre, captura de tela realizada pela autora (2025).

As informações sobre o GAL foram encontradas no Protocolo de Enfermagem de Tuberculose. Em relação à notificação, foi localizada a ficha do SINAN na aba Políticas, porém não há referência ao sistema Sentinela, que aparece apenas no Protocolo. Também foi localizado, no drive da CAIST (Coordenação de atenção a tuberculose e infecções transmissíveis), um instrutivo com o passo a passo para a notificação de tuberculose no Sentinela, encontrado apenas após extensa pesquisa sobre o tema. No entanto, esse drive está acessível apenas na descrição de um grupo de matriciamento da CAIST e não na BVAPS. Não se trata apenas da notificação: diversos outros materiais relevantes estão disponíveis nesse drive e não constam na BVAPS ou não são facilmente localizados, o que acaba prejudicando os profissionais que não participam desse grupo de matriciamento.

Na busca por informações relacionadas à anemia falciforme, o primeiro acesso foi realizado na página da Vigilância, especificamente na aba referente às doenças não transmissíveis. Após a navegação por todo o site, não foram identificados materiais sobre o tema. Em seguida, a pesquisa foi retomada na BVAPS, sem êxito na seção “Áreas Profissionais”, mais especificamente na aba “Atenção Especializada”.

Figura 34. Captura de tela da busca por “Políticas-População Negra” no site BVAPS de Porto Alegre.



Fonte: BVAPS Porto Alegre, captura de tela realizada pela autora (2025)

Posteriormente, ao recordar que esse agravo está diretamente relacionado à área da saúde da população negra, realizou-se novo acesso à aba “Saúde da População Negra”, na qual foram localizados materiais referentes à anemia falciforme. Esse percurso evidencia a fragmentação na organização dos conteúdos e a consequente dificuldade de acesso à informação, especialmente para profissionais que não possuem conhecimento prévio sobre a estrutura do site.

Em relação à dengue, Porto Alegre conta com um site específico sobre o *Aedes aegypti*, que permite a navegação e o acesso a diversas informações. O site dispõe de uma aba voltada especificamente para profissionais, na qual é possível encontrar documentos como o Plano de Contingência vigente, outros materiais técnicos e link que direciona para a BVAPS.

Foi constatado a existência de diversos materiais relacionados à dengue, porém não foi possível localizar, na BVAPS, informações sobre os locais que realizam a coleta de exames. Tampouco no site da Assistência Laboratorial essa informação é facilmente acessível, sendo que o conhecimento sobre a existência desse site ocorreu apenas por meio de divulgação em um grupo institucional. Na BVAPS, ao realizar a busca na aba de laboratórios, não há qualquer referência ou direcionamento para esse site.

Figura 35. Captura de tela do site “Assistência Laboratorial” de Porto Alegre.



Fonte: Site Assistência Laboratorial, captura de tela realizada pela autora (2025)

No Plano de Contingência da Dengue de 2026, os locais de coleta constam apenas como anexo, sem a disponibilização de um link direto, o que inviabiliza sua inclusão no guia. Além disso, o link apresentado no próprio Plano, referente aos locais de coleta, direciona novamente para a BVAPS, onde essas informações não estão descritas.

Figura 36. Captura de tela da busca por “Tabagismo” no site BVAPS de POA



Fonte: BVAPS Porto Alegre, captura de tela realizada pela autora (2025).

Ao contrário dos diversos temas pesquisados anteriormente, o tabagismo mostrou-se um tema de fácil localização na BVAPS. As informações encontram-se organizadas em um único espaço, o que facilita o acesso e é bastante positivo para os profissionais de saúde.

Já o Programa Porto Olhar Alegre não apresenta a mesma facilidade de localização, sendo necessário acessar a aba do Programa Saúde na Escola para encontrar as informações relacionadas. O material está direcionado principalmente aos profissionais responsáveis pela realização da acuidade visual nas escolas, bem como a algumas orientações destinadas aos pais e às crianças. No entanto, observa-se a ausência de materiais de apoio para o profissional que receberá a criança ou adolescente na unidade de saúde e necessita conhecer o fluxo de encaminhamento e de orientação para a confecção dos óculos.

Ao realizar a revisão das comunicações institucionais recebidas por correio eletrônico, foi identificada uma mensagem que menciona o Programa Porto Olhar Alegre com ações voltadas à população idosa. No entanto, ao acessar a BVAPS, na aba de políticas públicas e no recorte específico de idosos, não foi localizado nenhum material ou referência ao referido programa.

Figura 37. Captura de tela da busca por “Programa Saúde na Escola” no site BVAPS de Porto Alegre

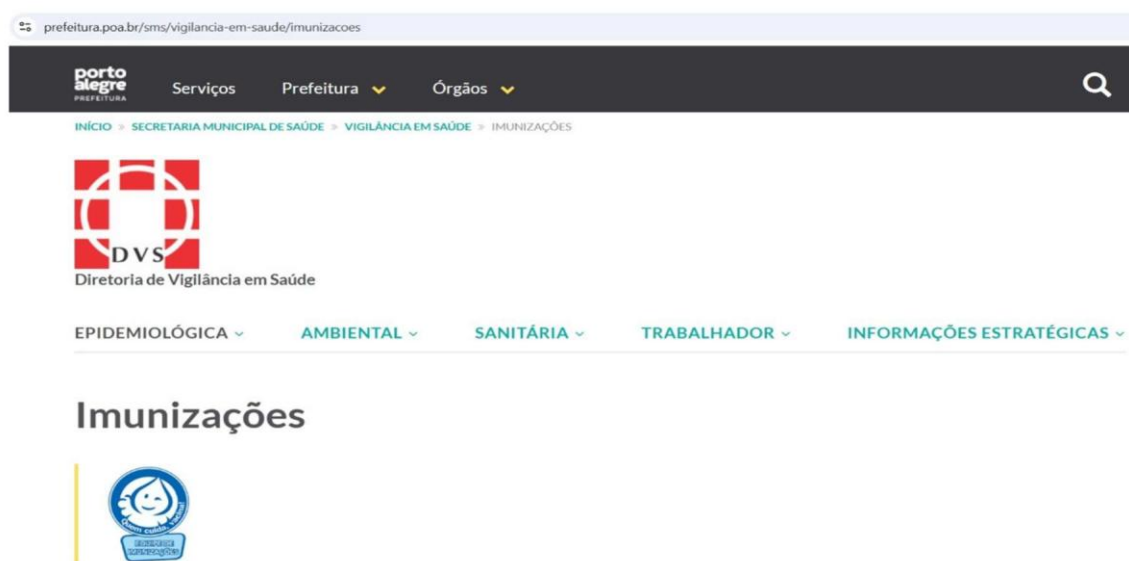
PROGRAMA PORTO OLHAR ALEGRE	
Acuidade Visual - Porto Olhar Alegre.pdf	1.03 MB
Atividade de Acuidade Visual - Porto Olhar Alegre.pdf	352.62 KB
Guia - Acuidade Visual - Porto Olhar Alegre.pdf	1.49 MB
Saúde Ocular - Porto Olhar Alegre.pdf	2.51 MB
Como está a Saúde dos Seus Olhos - Porto Olhar Alegre.pdf	1.39 MB

Fonte: BVAPS Porto Alegre, captura de tela realizada pela autora (2025)

Em relação à esporotricose, não foram encontrados materiais informativos nem no site da Vigilância nem na BVAPS. A única referência disponível foi uma nota técnica compartilhada informalmente por meio de grupo de WhatsApp e encaminhada às unidades via processo eletrônico no SEI. Diante disso, questiona-se como o profissional consegue acessar informações sobre o tema por meio dos materiais oficiais de apoio da Prefeitura, uma vez que, na prática, o acesso acaba dependendo da solicitação direta a colegas ou à chefia.

Em relação ao CRIE, foram encontradas informações no site da Vigilância, na aba de imunizações, com material completo e de fácil compreensão.

Figura 38. Captura de tela da busca por “Imunizações” no site da Vigilância de Porto Alegre.



Fonte: Site da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, captura de tela realizada pela autora (2025)

5.4 O GUIA DIGITAL

O site foi desenvolvido por meio de programação em linguagem de código HTML, CSS e Javascript, estruturado para organização e disponibilização dos conteúdos de forma sistematizada e de fácil navegação. A construção envolveu a definição da arquitetura das páginas, inserção dos links institucionais previamente selecionados e organização das informações em seções temáticas.

Após sua finalização, o site foi publicado em ambiente online, com acesso público, permitindo que os profissionais possam consultá-lo livremente pela internet. Trata-se de um produto digital de caráter organizacional, destinado a facilitar o acesso às informações já existentes, sem alteração de fluxos ou normativas institucionais.

O guia digital foi concebido no formato de site, considerando a necessidade de ampliar o alcance e facilitar o acesso dos profissionais às informações sistematizadas. A opção por uma plataforma online permite consulta rápida, navegação intuitiva e atualização contínua do conteúdo, características essenciais para apoiar o processo de trabalho na Atenção Primária à Saúde.

A escolha desse formato mostrou-se mais adequada em comparação a materiais estáticos, como arquivos em PDF, por possibilitar organização dinâmica dos links, melhor experiência de uso e acesso remoto a partir de diferentes dispositivos. Dessa forma, o guia em formato de site potencializa sua utilização cotidiana e amplia sua capilaridade entre as equipes.

O guia digital está disponível para acesso público no endereço eletrônico: <https://guiapratico-aps-poa.netlify.app/>

Este guia constitui um primeiro passo no processo de organização e sistematização das informações relacionadas aos fluxos assistenciais. Não se trata de um produto finalizado ou estático, mas de uma ferramenta em construção, passível de aprimoramentos contínuos.

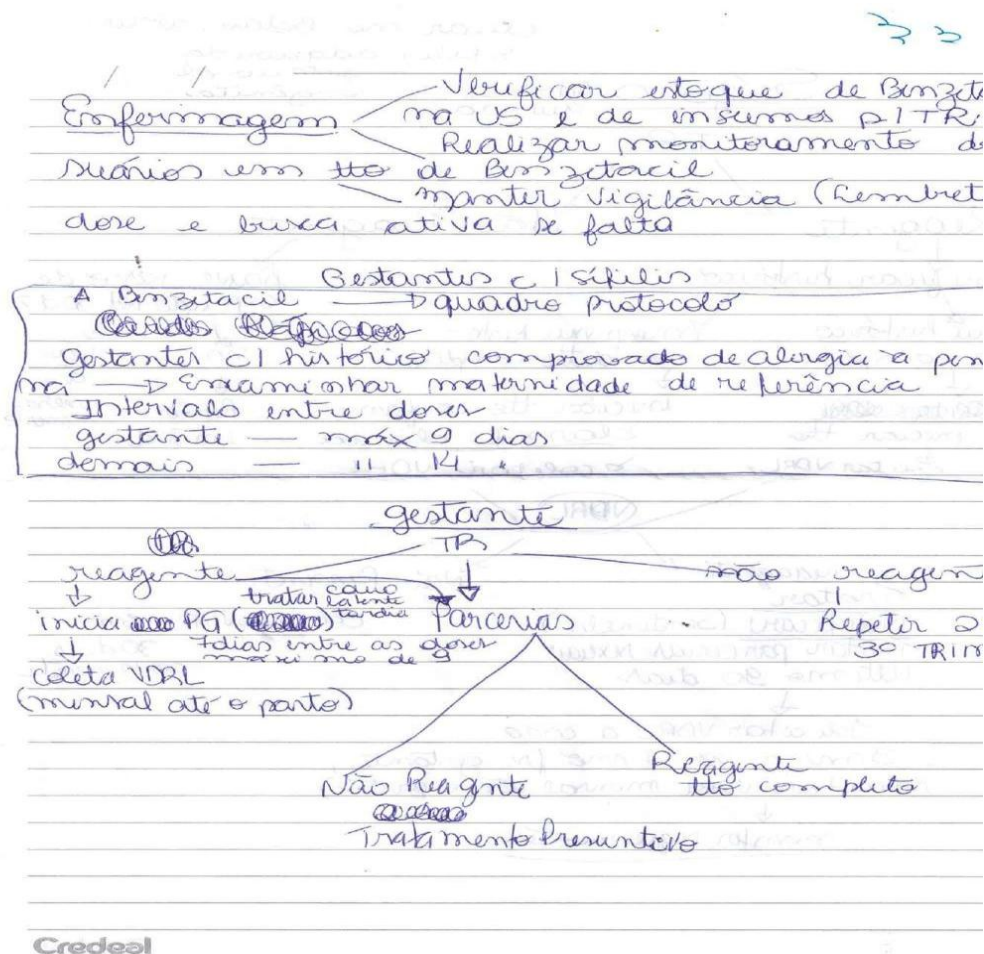
Considerando o caráter dinâmico da Atenção Primária à Saúde, marcado por atualizações frequentes de normativas, protocolos e reorganizações da rede, reconhece-se que o conteúdo do guia demandará revisões periódicas. Nesse sentido, sua estrutura foi pensada para permitir atualizações ágeis, garantindo maior alinhamento com as diretrizes institucionais vigentes.

Além disso, em função da minha atuação como assessora de monitoramento, assumo o compromisso de acompanhar as mudanças nos fluxos e documentos oficiais, promovendo as atualizações necessárias para que o guia permaneça como instrumento confiável de apoio às equipes.

Seguem as digitalizações de esboços iniciais elaborados pela autora durante o processo de concepção do guia, com o objetivo de evidenciar a construção das ideias, a organização dos conteúdos e a estrutura do material. Esses registros ilustram as etapas de desenvolvimento do produto, demonstrando que a concepção do guia partiu da autora, ainda que sua implementação técnica tenha contado com apoio para codificação.

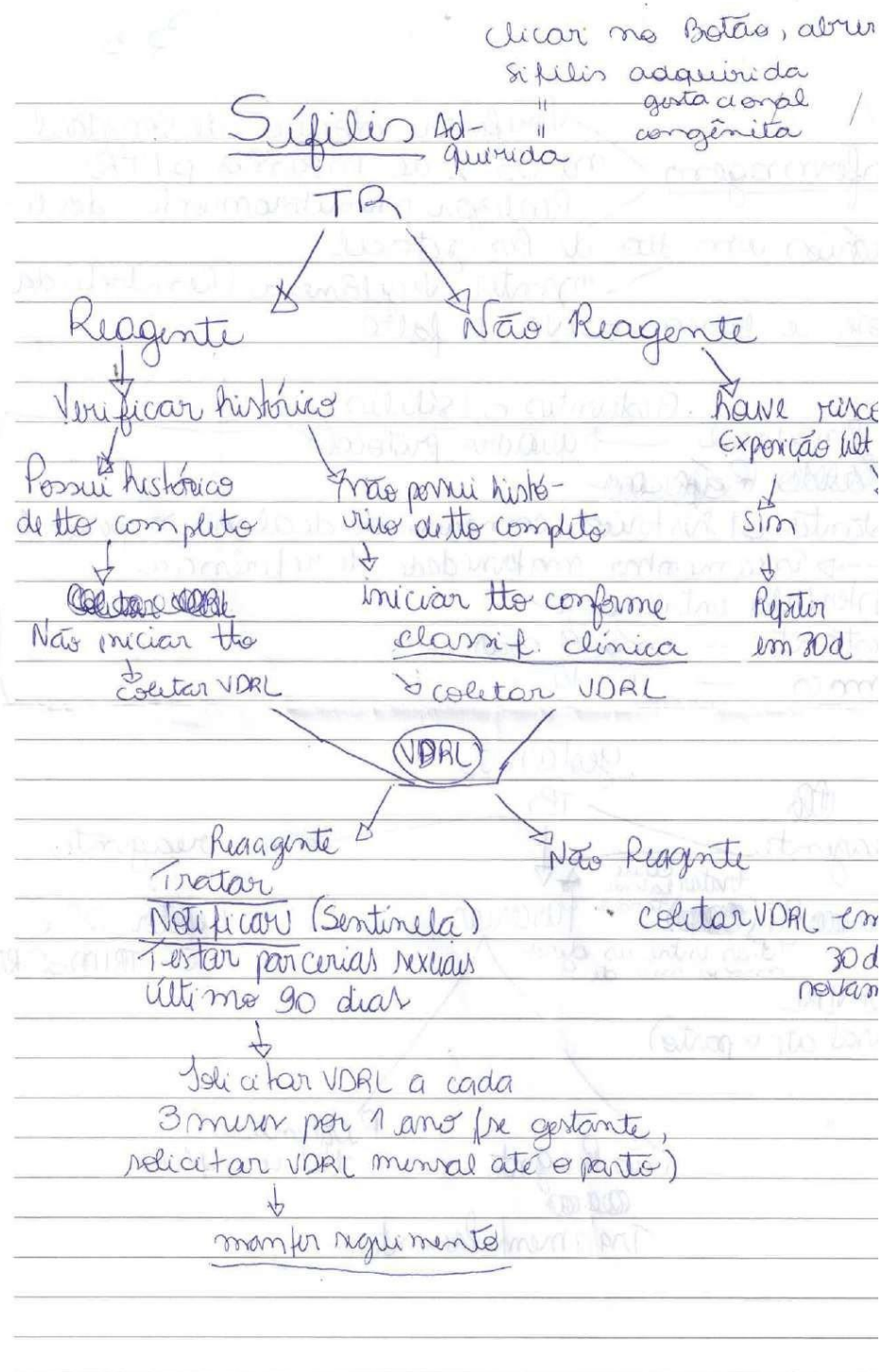
Ressalta-se que não foram incluídas todas as digitalizações dos esboços produzidos ao longo desse processo, tendo sido selecionados registros representativos, com caráter ilustrativo, de modo a evidenciar a evolução das ideias sem tornar o capítulo excessivamente extenso.

Figura 39. Digitalização de esboço inicial da estrutura do guia, elaborado pela autora.



Fonte: Elaboração própria (2025).

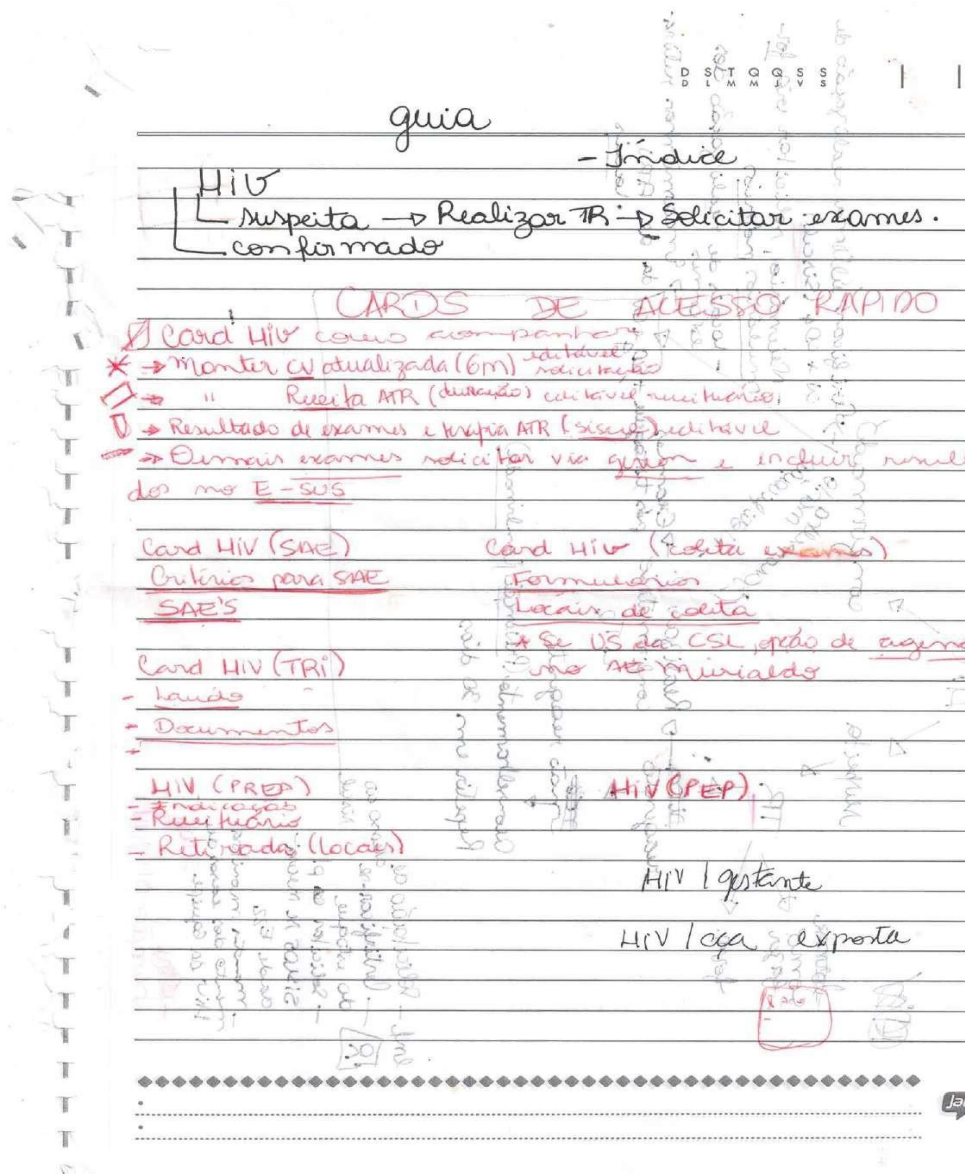
Figura 40. Digitalização de esboço inicial da estrutura do guia, elaborado pela autora.



Cre

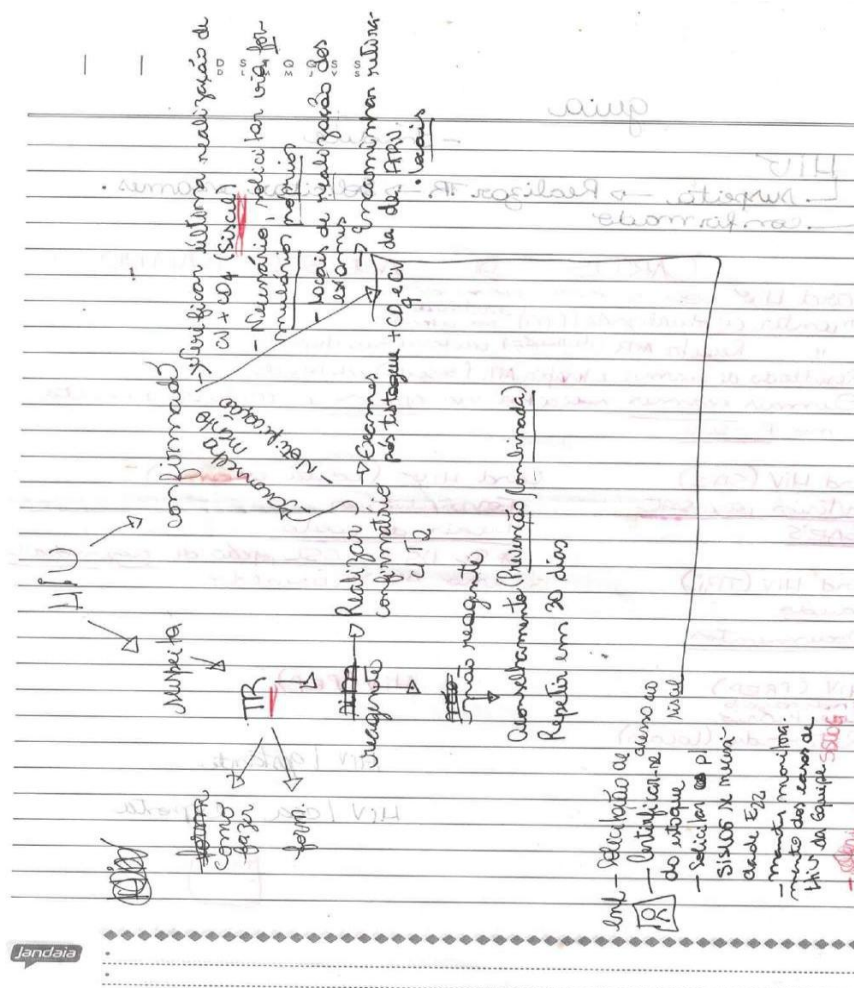
Fonte: Elaboração própria (2025).

Figura 41. Digitalização de esboço inicial da estrutura do guia, elaborado pela autora.



Fonte: Elaboração própria (2025).

Figura 42. Digitalização de esboço inicial da estrutura do guia, elaborado pela autora.



Fonte: Elaboração própria (2025).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa permitiu analisar a percepção dos profissionais da Atenção Primária à Saúde quanto à sua aptidão para realizar encaminhamentos em diferentes temáticas assistenciais, evidenciando níveis variados de segurança e familiaridade com os fluxos existentes. Os resultados demonstraram que, embora algumas áreas apresentem maior consolidação no cotidiano das equipes, outras ainda revelam fragilidades relacionadas principalmente ao acesso às informações e à organização dos conteúdos institucionais.

A integração dos dados quantitativos e qualitativos possibilitou identificar convergências importantes, especialmente no que se refere à dispersão dos materiais orientadores e à dificuldade de localizar links e normativas oficiais. Observou-se que a insegurança percebida nem sempre está associada à ausência de protocolos, mas, muitas vezes, à fragmentação das informações e à falta de sistematização em um único ambiente de consulta.

Os resultados indicam que parte dessas fragilidades não decorrem da ausência de fluxos ou protocolos formais, mas da dispersão das informações e da dificuldade de acesso aos documentos oficiais. A fragmentação dos conteúdos institucionais, somada à rotatividade frequente de profissionais nas equipes, contribui para o desconhecimento dos fluxos locais e para a descontinuidade de saberes construídos no serviço. Nesse contexto, a organização sistematizada das informações mostra-se não apenas uma estratégia operacional, mas também um dispositivo de apoio à integração e qualificação permanente das equipes.

A construção do guia digital, disponibilizado em formato de site, configura-se como intervenção aplicada voltada à melhoria do processo de trabalho. O produto não cria novos fluxos nem altera normativas vigentes, mas reúne e organiza, em um único ambiente virtual, os links e documentos já existentes, facilitando o acesso e fortalecendo a autonomia profissional. A escolha do formato online amplia seu alcance, favorece a utilização cotidiana e permite atualização contínua, característica fundamental diante do dinamismo da rede assistencial.

Mesmo em sua versão inicial, o guia foi submetido a pré-avaliação, apresentando resultados satisfatórios para os profissionais quanto à clareza, organização e utilidade prática. Esse retorno reforça sua pertinência como ferramenta de apoio à tomada de decisão e indica potencial de consolidação como instrumento institucional de referência, desde que mantido em processo permanente de atualização.

A pesquisa também trouxe à tona aspectos estruturais relevantes, como a baixa presença de profissionais negros nos cargos de médicos e enfermeiros entre os participantes. Esse achado evidencia desigualdades ainda presentes na composição das equipes de saúde e aponta para a necessidade de ampliar o debate sobre equidade, diversidade e acesso às posições de maior reconhecimento técnico no sistema de saúde.

Conclui-se que a qualificação da Atenção Primária à Saúde exige não apenas a produção de novas diretrizes, mas a organização, acessibilidade e inteligibilidade das informações já existentes. Intervenções contextualizadas, viáveis e ancoradas nas demandas reais do serviço podem produzir impactos significativos na rotina assistencial. O guia digital representa um primeiro passo nesse percurso, com potencial de contribuir para maior segurança profissional, integração da rede e fortalecimento da gestão do cuidado, mantendo-se como instrumento em constante construção, alinhado às transformações do sistema e às necessidades das equipes.

Embora a pesquisa tenha sido desenvolvida em um contexto específico, o estudo apresenta limitações relacionadas ao recorte institucional e ao número de participantes. Ao evidenciar que a organização da informação é componente estratégico da gestão do cuidado, o estudo reafirma a centralidade da sistematização do conhecimento como eixo estruturante da qualificação da Atenção Primária à Saúde.

REFERÊNCIAS

- AGOSTINHO, M. R. de et al. Autopercepção da saúde entre usuários da Atenção Primária em Porto Alegre. *Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade*, Florianópolis, v. 5, n. 17, p. 9-15, jan./dez. 2010.
- ALEXANDRE, N. M. C.; COLUCI, M. Z. O. Validade de conteúdo nos processos de construção e adaptação de instrumentos de medidas. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 16, n. 7, p. 3061-3068, 2011.
- ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018.
- BARATIERI, T. et al. Nova Política Nacional de Atenção Básica Brasileira: um passo para o desmonte do Sistema Único de Saúde? In: *CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE SALUD*, 2018, Havana. Anais [...]. Havana: Cuba Salud, 2018.
- BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. Lisboa: Edições 70, 1977.
- BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.
- BATISTA, L. E.; WERNECK, J. Saúde da população negra: desafios e perspectivas. *Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 43, n. esp. 8, p. 305-318, 2019.
- BERBEL, N. A. M.; GAMBOA, S. A. S. A metodologia da problematização com o Arco de Maguerez: uma perspectiva teórica e epistemológica. *Filosofia e Educação*, Campinas, v. 3, n. 2, p. 264-287, 2011.
- BEVERIDGE, W. O Plano Beveridge: relatório sobre o seguro social e serviços afins. Rio de Janeiro: José Olympio, 1942.
- BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. *Atenção Primária e Promoção da Saúde*. Brasília: CONASS, 2011.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.488/GM/MS, de 24 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 25 out. 2011.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 22 set. 2017.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 635, de 22 de maio de 2023. Institui, dispõe e regulamenta o custeio das equipes multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br>. Acesso em: 18 set. 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. *Registro de Saúde na APS (E-book 2): educação permanente para enfermeiros, médicos da equipe de saúde da família, cirurgiões-dentistas e equipes multiprofissionais*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Dispõe sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 2012. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em: 24 out. 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. *O que é Atenção Primária?* Brasília: Ministério da Saúde, [2024?]. Disponível em: <https://aps.saude.gov.br/atencao-primaria>. Acesso em: 18 set. 2024.

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa; AMARANTE, P. A saúde mental no SUS: o cuidado em liberdade, a gestão e os direitos. In: GIOVANELLA, L. et al. (org.). Políticas e sistema de saúde no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2015. p. 639-665.

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa; FERRAZ, Flávio. Educação Permanente em Saúde e o trabalho em equipe: desafios e possibilidades. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 25, n. 1, p. 39-46, 2020.

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa; MALIK, Ana Maria. Planejamento e gestão em saúde: teoria e prática. São Paulo: Hucitec, 2008.

CARNEIRO, Carla Cabral et al. Configurações do trabalho na Atenção Primária: modalidades de contratação. 2. Boletim da Pesquisa “Desafios do Trabalho na Atenção Primária à Saúde na Perspectiva dos Trabalhadores”. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, nov. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.29327/5340980>. Acesso em: 10 jan. 2025.

CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira. Apontamentos teórico-conceituais sobre processos avaliativos considerando as múltiplas dimensões da integralidade da atenção à saúde. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, 2011.

CECCIM, Ricardo Burg. Educação permanente em saúde: desafio ambicioso e necessário. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, Botucatu, v. 9, n. 16, p. 161-168, 2005.

CECCIM, Ricardo Burg; FEUERWERKER, Laura C. Educação permanente em saúde: abrindo a roda das relações em saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, p. 161-167, 2004.

CÔRTEZ, S. V. Sistema Único de Saúde: espaços decisórios e a arena política de saúde. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 25, n. 7, p. 1626-1633, jul. 2009.

COSTA, P. P. Dos projetos à política pública: reconstruindo a história da educação permanente em saúde. 2006. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2006.

CYRINO, E. G.; PEREIRA, M. L. T. Trabalhando com estratégias de ensino-aprendizado por descoberta na área da saúde: a problematização e a aprendizagem baseada em problemas. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, p. 780-788, 2004.

DAMASCENO, A. M.; SAID, F. A. O método problematizador no cuidado educativo com mulheres no preparo ao parto. *Cogitare Enfermagem*, Curitiba, v. 13, n. 2, p. 173-183, 2008.

ECHER, I. C. Elaboração de manuais de orientação para o cuidado em saúde. *Revista Latinoamericana de Enfermagem*, Ribeirão Preto, v. 13, n. 5, out. 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/6ZJ3s4DtMzZvSJn4JbpD3WB/>. Acesso em: 5 dez. 2024.

FAUSTO, M. C. R.; MATTA, G. C. Atenção Primária à Saúde: histórico e perspectivas. In: MOROSINI, M. V. G. C.; CORBO, A. D. (org.). Modelos de atenção e a saúde da família. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GALVÃO, Paulo César da Costa et al. Caracterização dos estudos metodológicos em enfermagem: revisão integrativa. *International Journal of Development Research*, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 54315-54317, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.37118/ijdr.23954.03.2022>.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2008.

- GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- GIL, A. C. Pesquisa-ação: uma estratégia de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2019.
- GIOVANELLA, L. Atenção básica ou atenção primária à saúde? Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 34, n. 8, p. 11-15, 2018.
- GIOVANELLA, L.; FRANCO, C. M.; ALMEIDA, P. F. Atenção Primária à Saúde no Brasil: conceitos, práticas e pesquisa. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2021.
- GIOVANELLA, L.; FRANCO, C. M.; ALMEIDA, P. F. Política Nacional de Atenção Básica: para onde vamos? Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 25, n. 4, p. 1475-1482, 2020.
- GLERIANO, Josué Souza et al. Organização do processo de trabalho para atenção integral: potencialidades e desafios. Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro, São João del-Rei, v. 11, e4092, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.19175/recom.v11i0.4092>.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Classificação e categorias de cor ou raça. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.
- KRIEGER, C. S.; TODESCHINI, G. S. O desmonte da Atenção Básica e do SUS em Porto Alegre durante a pandemia: a crescente privatização da Atenção Primária de Saúde preocupa à medida que acompanhamos o desmonte do SUS. Brasil de Fato, [S. l.], 2021.
- KRINSKI, L. M. et al. Grupo de cessação de tabagismo na Atenção Primária à Saúde: experiência de uma unidade de saúde de Porto Alegre/RS. Revista APS, Juiz de Fora, v. 21, n. 2, p. 273-282, 2018.
- LEITE, Maria de Fátima Gomes; ROCHA, Patrícia Teixeira. Educação permanente em saúde: desafios na qualificação do trabalho na atenção básica. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 51, supl. 2, 2017.
- LIMA, Rosangelica Bonfim Silva; SOUSA, Vitória Talya dos Santos; VASCONCELOS, Patrícia Freire de. (Re)organização de fluxos de trabalho na Atenção Primária à Saúde. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira, Redenção, 2023. Disponível em: <https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4529>. Acesso em: 18 ago. 2025.
- LOPES, F. M.; ALMEIDA, S. Relações étnico-raciais e formação em saúde: desafios para a integralidade do cuidado. Interface – Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 24, e190234, 2020.
- LOPES, M. J. M.; LEAL, S. M. C. Gênero, saúde e enfermagem: uma reflexão a partir da divisão sexual do trabalho. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, DF, v. 58, n. 3, p. 330-335, 2005.
- MACHADO, M. H. A feminização do mercado de trabalho em saúde no Brasil. Revista Divulgação em Saúde para Debate, Rio de Janeiro, n. 45, p. 58-75, 2010.
- MACHADO, Maria Helena (org.). Gestão do trabalho e da educação na saúde: perspectivas e desafios. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2014.
- MAMEDE, S. Os modelos tradicionais para a educação continuada e seus resultados. Fortaleza: Instituto Inovare, 2005.
- MARTINS, M. B.; CARBONAI, D. Atenção Primária à Saúde: a trajetória brasileira e o contexto local em Porto Alegre (RS). REAd. Revista Eletrônica de Administração, Porto Alegre, v. 27, n. 3, p. 725-748, dez. 2021.

MELO, Eduardo Alves; MENDONÇA, Maria Helena Magalhães de; TEIXEIRA, Carmen Fontes; HEIMANN, Luiza Sterman. Mudanças na Política Nacional de Atenção Básica: entre retrocessos e desafios. *Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 42, n. spe1, p. 38-51, 2018.

MELO, G. A.; FONTANELLA, B. J. B.; DEMARZO, M. M. P. Atenção básica e atenção primária à saúde: origens e diferenças conceituais. *Revista APS*, Juiz de Fora, v. 12, n. 2, p. 204-213, abr./jun. 2009.

MELO, Karen Cristina Correa de. Contratualização da Atenção Primária à Saúde às Organizações da Sociedade Civil em Porto Alegre: fragilidade do monitoramento e consequências para o direito à saúde à porta de entrada do SUS. 2023. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023.

MENDES, Eugênio Vilaça. A construção social da Atenção Primária à Saúde. Brasília: Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 2015.

MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2010.

MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. Brasília: OPAS, 2011.

MENDES, Eugênio Vilaça. O cuidado das condições crônicas na Atenção Primária à Saúde: o imperativo da consolidação da Estratégia Saúde da Família. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2012.

MENICUCCI, Telma Maria Gonçalves; GOMES, Maria Lúcia Teixeira. Parcerias público-privadas e a gestão do SUS: implicações para o trabalho e a oferta de serviços. *Revista de Administração Pública*, Rio de Janeiro, v. 52, n. 5, p. 863-883, 2018.

MERHY, Emerson Elias. O cuidado é um acontecimento e não um ato: notas sobre o trabalho vivo em saúde. In: FRANCO, T. B.; MERHY, E. E. (org.). Trabalho, produção do cuidado e subjetividade em saúde. São Paulo: Hucitec, 2014.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2010.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

NAYARA, C. R. O.; LAÍS, M. C. A. Fluxos de serviços e procedimentos assistenciais: elaboração de fluxos para melhor impacto na efetividade do cuidado assistencial ao usuário. [S. l.: s. n., 20--?]. Disponível em: <https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/14746/1/06%20NAYARA.pdf>.

NEVES, G.; GUIMARÃES, A.; JÚNIOR, A. Um novo modelo de administração pública. Macroplan, 3 jul. 2017. Disponível em: <https://www.macroplan.com.br/p/um-novo-modelo-de-administracao-publica/>. Acesso em: 10 abr. 2025.

NUNES, Everardo Duarte; BARROS, Nelson Filice de. Pesquisa qualitativa em saúde: múltiplos olhares. São Paulo: Hucitec, 2020.

OLIVEIRA, M. A. C.; PEREIRA, I. C. Atributos essenciais da Atenção Primária e a Estratégia Saúde da Família. *Revista Brasileira de Enfermagem*, Brasília, DF, v. 66, n. esp., p. 158-164, set. 2013.

PASQUALI, L. Instrumentação psicológica: fundamentos e práticas. Porto Alegre: Artmed, 2010.

PEDUZZI, M. et al. Atividades educativas de trabalhadores da atenção primária: concepções de educação permanente e educação continuada em saúde presentes no cotidiano de Unidades Básicas de Saúde em São Paulo. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, Botucatu, v. 13, n. 30, p. 121-134, 2009.

PINTO, I. C. M. et al. Raça/cor e desigualdades na força de trabalho em saúde: uma análise da PNAD 2015. *Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 42, n. esp. 2, p. 100-114, 2018.

PIRES, Denise Elvira. Reestruturação produtiva e consequências para o trabalho em saúde. *Revista Brasileira de Enfermagem*, Brasília, DF, v. 53, n. 2, p. 251-263, abr./jun. 2000.

POLIT, D. F.; BECK, C. T. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: avaliação de evidências para a prática da enfermagem. Porto Alegre: Artmed, 2011.

PONTES, Lucas Oliveira. Guia rápido de abordagem inicial a pessoas com HIV/AIDS. 2025. Dissertação (Mestrado em Ensino na Saúde) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2025.

PORTELA, Margareth Crisóstomo. Atenção Primária à Saúde: um ensaio sobre conceitos aplicados aos estudos nacionais. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, p. 255-276, 2017.

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. Página inicial. Porto Alegre: Prefeitura Municipal, 2024. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br>. Acesso em: 31 jul. 2024.

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. Plano Municipal de Saúde 2022-2025. Porto Alegre: SMS, 2022. Disponível em: https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/usu_doc/sites/sms/PLANO%20MUNICIPAL%20DE%20SAÚDE%202022-2025.pdf. Acesso em: 17 out. 2024.

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. Plano Municipal de Saúde 2026-2029. Porto Alegre: SMS, 2022. Disponível em: https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/usu_doc/sites/sms/PLANO%20MUNICIPAL%20DE%20SA%C3%9ADE%202026-2029_v4_compressed.pdf. Acesso em: 26 fev. 2026.

PORTO ALEGRE. Secretaria Municipal de Saúde. Doença falciforme: linha de cuidado e fluxo de atendimento. Porto Alegre: SMS, 2023.

PORTO ALEGRE. Secretaria Municipal de Saúde. Relatório de Gestão Municipal de Saúde. Porto Alegre: SMS, 2023.

PRETTO, L.; RECH, R.; FAUSTINO-SILVA, D. Grupos de cessação de tabaco: série histórica de um serviço de atenção primária à saúde no sul do Brasil. *Cadernos Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 30, n. 2, p. 244-254, abr./jun. 2022.

SANTOS, Débora Cristina Pereira dos et al. Sobrecarga de trabalho na Estratégia Saúde da Família: implicações para a saúde do trabalhador. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, São Paulo, v. 44, e18, 2019.

STARFIELD, Barbara. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: UNESCO; Ministério da Saúde, 2002.

TRIPP, D. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443-466, set. 2005.

VALENTIM, M. L. P.; TEIXEIRA, T. M. C. Fluxos de informação e linguagem em ambientes organizacionais. *Informação e Sociedade*, João Pessoa, v. 22, n. 2, p. 151-156, 2012.

WERMELINGER, M. et al. Transformações recentes no trabalho em saúde no Brasil: tendências e desafios. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 25, n. 1, p. 53-61, 2020.

WERNECK, Jurema. Racismo institucional e saúde da população negra. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 25, n. 3, p. 535-549, 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global strategy on digital health 2020–2025. Geneva: WHO, 2021.

ZILS, A. A. et al. Satisfação dos usuários da rede de Atenção Primária de Porto Alegre. *Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade*, Rio de Janeiro, v. 4, n. 16, p. 270-276, 2009.

Apêndice A
Questionário 1

Formulário da Pesquisa:

1.Qual seu cargo?

2.Qual seu gênero? Qual sua raça/cor?

3.Quanto tempo você trabalha na APS de Porto Alegre?

4.Quando ingressou na Atenção Primária de Porto Alegre foi oferecido algum encontro em forma de oficina, curso ou capacitação com objetivo de fornecer informações a respeito do trabalho que seria desenvolvido no dia a dia?

☐sim ☐ não ☐em parte

5.Quando ingressou na Atenção Primária de Porto Alegre foi oferecido algum material como referências para estudo e para ser utilizado em caso de dúvidas?

☐sim ☐não ☐em parte

6.Quando ingressou na Atenção Primária de Porto Alegre considera que teria sido importante um material que servisse de apoio para a tomada de decisões referentes aos processos de trabalho?

☐ sim ☐ não ☐ em parte

7.Sobre quais temas teve ou tem mais dificuldade de saber os fluxos e realizar encaminhamentos?

7.1 Gostaria de deixar uma sugestão sobre o que poderia ser feito em relação à questão anterior (7)?

8.Você considera que hoje consegue solucionar a maioria das suas dúvidas de forma rápida e eficaz?

8.1 Gostaria de deixar uma sugestão sobre o que poderia ser feito em relação à questão anterior (8)?

9.Numa pontuação de 0 à 5, o quão você considera que está apto a fazer os encaminhamentos pertinentes às seguintes temáticas, sendo 0 nenhuma aptidão e 5 muita aptidão:

9.1 Hanseníase

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

9.2 Tuberculose

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

9.3 Dengue

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

9.4 Anemia falciforme

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

9.5 Gestante com HIV

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

9.6 Criança exposta ao HIV

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

9.7 Tabagismo

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

9.8 Vacinação com indicação para CRIE

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

9.9 Programa Porto Olhar Alegre

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

9.10 Saúde da População Negra

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

9.11 Saúde da População Imigrante

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

10. Gostaria de sugerir temas que possui dificuldades em obter informações sobre atendimentos e encaminhamentos na Atenção Primária de Porto Alegre?

10.1 Gostaria de deixar uma sugestão sobre como poderia ser feito em relação à questão anterior (10) ?

Apêndice B

Questionário 2

Instrumento de avaliação do Guia Digital

Parte I – Caracterização do avaliador

Formação profissional:

Área de atuação:

Tempo de experiência na área (anos):

Função atual:

Parte II – Avaliação do conteúdo do guia

Item avaliado	1	2	3	4
Clareza dos objetivos do guia				
Adequação do conteúdo ao público-alvo				
Coerência do conteúdo com os princípios da Atenção Primária à Saúde				
Coerência do conteúdo com a Atenção Primária à Saúde				
Linguagem clara e acessível				
Organização e estrutura do material				

Relevância do conteúdo para a prática profissional				
Aplicabilidade do guia no cotidiano dos serviços de saúde				

Parte III – Avaliação global

O conteúdo do guia, de forma geral, é adequado para o contexto da Atenção Primária à Saúde?

☐ Sim

☐ Parcialmente

☐ Não

Você recomendaria a utilização deste guia após eventuais ajustes?

☐ Sim

☐ Não

Parte IV – Sugestões e comentários

Espaço para sugestões de melhoria, ajustes de conteúdo, linguagem ou estrutura:

APÊNDICE C

TCLE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado (a) , Convidamos você a participar de uma pesquisa intitulada: “GUIA PRÁTICO SOBRE FLUXOS E DIRECIONAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DA APS DE PORTO ALEGRE”. A pesquisa tem por objetivo desenvolver um produto técnico para auxiliar na execução e contribuir para a promoção da saúde em Unidades de Saúde de Porto Alegre. Percebe-se a necessidade de fornecer aos profissionais um guia para apoio em caso de dúvidas, tanto no ingresso quanto na atuação diária dos profissionais na APS. Gostaríamos de utilizar as informações produzidas nesse Projeto para criar um banco de dados para uso em projetos de pesquisa, produção de artigos e também para compor material para fins acadêmicos e didáticos. Assim, estamos solicitando sua autorização para que suas respostas ao questionário no ambiente virtual sejam utilizadas para este fim. Os resultados serão apresentados de forma agrupada, não permitindo a identificação do participante. Sua participação consiste em responder as perguntas em um questionário online. O tempo destinado ao preenchimento depende de cada participante, estimando-se em 15 minutos neste primeiro questionário encaminhado. Caso identifique seu email , o que não é obrigatório, será enviado posteriormente o segundo questionário, que também tem um tempo estimado de resposta de 15 minutos e consiste na avaliação do guia finalizado. Será enviado um segundo link para o segundo questionário. Se você não concordar em participar ou quiser desistir em qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você prestadas. Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa. Os questionários respondidos serão armazenados em arquivos digitais por, no mínimo, cinco anos. Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variadas. Os riscos de sua participação neste estudo podem ser: algum constrangimento ao refletir e responder sobre aspectos da condição de serviço; porém,

esse risco será minimizado ao garantir que sua identidade não será identificada quando das suas respostas no questionário do curso. Os formulários serão codificados e terão ausência de informações que os vinculam ao participante. Será feita a publicação agrupada dos dados e o armazenamento dos dados sob a responsabilidade do pesquisador principal será por no mínimo 5 anos. Já os benefícios que esse estudo poderá trazer aos participantes serão o conhecimento e potenciais na forma de desenvolvimento das ações de promoção da saúde e educação em saúde para profissionais que atuam no município de Porto Alegre na Atenção Básica. Também agregar na colaboração de avanços de materiais didáticos como auxílio para os profissionais da saúde atuantes da prática de promoção de saúde nos educandos. Caso você tenha dúvidas ou necessite algum esclarecimento, entrar em contato com o pesquisador responsável: Mariangela Kraemer Lenz Ziede pelo telefone (51) 981369546 e e-mail mariangelaziede@gmail.com ou com a mestrande Denise Wisniewski de Mattos pelo telefone (51) 985178598 e e-mail denisemattos265@gmail.com. O contato pode ser realizado também com a Comissão de Pesquisa e Comitê de Ética da UFRGS: Endereço: Av. Paulo Gama, 110, Sala 311 - Prédio Anexo I da Reitoria - Campus Centro - Porto Alegre/RS - CEP: 90040-060 Email: etica@propesq.ufrgs.br Telefone: (51) 3308-3738 Horário de Funcionamento: de segunda a sexta, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h e/ou CEP SMSPA, fica localizado na Rua Capitão Montanha, 27-6º andar (Centro Histórico) email: cep_sms@hotmail.com Fone: 32892899. Será garantido aos participantes o acesso aos resultados da pesquisa através de envio do manual para o e-mail informado e no caso de não ter sido informado, todas Coordenadorias irão receber o manual e terão a possibilidade de divulgar para os serviços e participantes ou não participantes da pesquisa, tendo o pesquisador o compromisso de divulgar os resultados da pesquisa em formato plenamente acessível e compreensível ao grupo ou população que foi pesquisada. O participante da pesquisa que vier a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou não no Registro de Consentimento Livre e Esclarecido, e terá direito a ser indenizado pelo dano decorrente da pesquisa, nos termos da Lei (Res. CNS 510, VI, Art. 9). O projeto foi avaliado pelo CEP-UFRGS, órgão colegiado, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, cuja finalidade é avaliar, emitir parecer e acompanhar os projetos de pesquisa envolvendo

seres humanos, em seus aspectos éticos e metodológicos, realizados no âmbito da instituição. Meios de contato com o CEP UFRGS: Av. Paulo Gama, 110, Sala 311, Prédio Anexo I da Reitoria - Campus Centro, Porto Alegre/RS - CEP: 90040-060. Fone: +55 51 3308 3787 E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br Horário de Funcionamento: de segunda a sexta, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30h . Este projeto também foi avaliado pelo CEP SMSPA, fica localizado na Rua Capitão Montanha, 27-6º andar (Centro Histórico) email: cep_sms@hotmail.com. Fone: 32892899. Será disponibilizada a possibilidade de você salvar/guardar uma via do TCLE devidamente assinada pelo pesquisador principal. Se diante das explicações aqui descritas você se considera suficientemente informado (a) respeito da pesquisa que será realizada e concorda (via online) de livre e espontânea vontade em participar, selecione a opção “Sim, aceito participar”, caso contrário, se não se sente à vontade para participar, selecione a opção “Não aceito participar”.

☐ Sim, autorizo e aceito participar ☐ Não Autorizo e não aceito participar

APÊNDICE D PRODUTO

Portas Abertas

Guia Prático sobre fluxos na APS de Porto Alegre



Agravos

Selecione uma das opções abaixo para visualizar o fluxo de atendimento na APS.

HIV

SÍFILIS

TUBERCULOSE

HANSENÍASE

ANEMIA FALCIFORME

DENGUE

HIV

Cards Rápidos



Painel de Gestão do Cuidado em HIV

Acessar painel de controle de testes e acompanhamento da equipe.

Selecione o Fluxo de Atendimento:

SUSPEITA DE HIV

CASO CONFIRMADO DE HIV

Fluxograma de Testagem Rápida

Como Fazer (POP 18)

Formulário de Registro de TR

Realizar Teste Rápido (Porto Alegre preconiza a realização de testes rápido para HIV)

Não Reagente

ACONSELHAMENTO
[Ver Prevenção Combinada](#)

Repetir em 30 dias

Reagente

1. CONFIRMATÓRIO C/ T2
 Consultar POP 18

Ação Integrada:
 Aconselhamento

2. SEGUIMENTO
 Exames Pós Testagem + CD4 e CV

Obrigatório:
 Notificação **Sentinela**

Fluxo de Abordagem Inicial

1. Abordagem Inicial

(Vinculação ao Serviço)

2. Avaliação Clínica

Histórico médico, exame físico, exames complementares.

ATENÇÃO ESPECIAL NA AVALIAÇÃO:

- Identificar estágio clínico
- Presença de coinfeções ou comorbidades
- Conhecer vulnerabilidades socioculturais

3. Investigação e Conduta

Investigar tuberculose

Continuar ou retomar TARV

Verificar vacinação

Painel de Gestão do Cuidado em HIV

Gerenciamento de tarefas, acesso a sistemas e acompanhamento da equipe.

Solicitação de acesso ao
Siscel

Manter monitoramento dos
casos de HIV da equipe

Certificar-se do estoque
de testes rápidos

Solicitação de testes no
Sislog
(SEI 25.0.000021906-4)

Vacinação para HIV

PREP E PEP extra muros

Sífilis

[Notificações](#)

Painel de Gestão do Cuidado em Sífilis

Gerenciar tarefas, estoque e busca ativa da equipe.

Acesse:

[Sífilis Adquirida](#)[Sífilis Gestacional](#)[Sífilis Congênita](#)

Fluxograma: Sífilis Adquirida

Realizar Teste Rápido (Porto Alegre preconiza a realização de testagem rápida para Sífilis)

TR Reagente

Ofertar TR HIV e Hepatites

VERIFICAR HISTÓRICO DE TRATAMENTO ANTERIOR:

- **Histórico completo e sem exposição após tratamento:**
Não iniciar tratamento e solicitar VDRL.
- **Não possui histórico completo:**
Iniciar tratamento conforme [classificação clínica](#) e solicitar VDRL.

SE VDRL REAGENTE:

- Tratar
- Notificar ([Sentinela](#))
- Testar parcerias sexuais dos últimos 90 dias

Conduta: Solicitar VDRL a cada 3 meses por 1 ano (se gestante, mensal até o parto). [Manter seguimento](#).

SE VDRL NÃO REAGENTE:

Coletar VDRL em 30 dias novamente.

TR Não Reagente

HOUVE RISCO DE EXPOSIÇÃO NOS ÚLTIMOS 30 DIAS?

SIM: Repetir em 30 dias.

NÃO: Aconselhamento.

Fluxograma: Sífilis Gestacional

Teste Rápido (TR)

TR Reagente

CONDUTA COM A GESTANTE:

1. Iniciar PG

(Tratar como latente tardia)

2. Coleta VDRL

(Mensal até o parto; após, solicitar a cada 3 meses totalizando 1 ano de tratamento)

REALIZAR TESTE RÁPIDO EM PARCEIRIAS:

- **Parceria Não Reagente:**
Tratamento presuntivo.
- **Parceria Reagente:**
Ofertar TR HIV e hepatites → Tratamento completo.

TR Não Reagente

ACOMPANHAMENTO:

Repetir no 2º e 3º trimestre.

Sífilis Congênita

Condutas baseadas na avaliação do histórico materno

Cenário 1

SITUAÇÃO MATERNA

Gestante com tratamento adequado e documentado e sem risco de reinfecção.

CONDUTA RN

Condição: RN assintomático com VDRL não reagente, ou VDRL reagente com titulação menor ou igual a materna.

- Consulta habitual puericultura 1, 2, 4, 6, 9, 12 e 18 meses
- VDRL com 1, 3, 6, 12 e 18 meses (interromper após 2 testes não reagentes)
- Monitorar sinais e sintomas de sífilis congênita
- Monitorar desenvolvimento neuropsicomotor
- Avaliar risco de outras ISTs maternas

Cenário 2

SITUAÇÃO MATERNA

Gestante com tratamento inadequado ou não documentado.

CONDUTA RN

- Consulta habitual de puericultura 1, 2, 4, 6, 9, 12 e 18 meses. Avaliar sintomas da sífilis congênita e desenvolvimento neuropsicomotor.
- VDRL com 1, 3, 6, 12 e 18 meses (interromper após 2 testes não reagentes).
- Outros exames conforme sintomas: Hemograma, plaquetas, função hepática, eletrólitos, raio-x de tórax, raio-x de ossos longos.
- **Neurosífilis:** líquor de 6/6 meses (acompanhar na rede especializada).
- Consultas oftalmológicas semestrais por 2 anos.
- Consultas audiológicas semestrais por 2 anos.
- Consultas neurológicas semestrais por 2 anos.

Cenário 3

FALHA NO TRATAMENTO

Falha no tratamento preventivo de sífilis da criança.

CONDUTA RN

Considerar falha quando:

- Persistência de VDRL reagente aos seis meses; **OU**
- Aumento do VDRL em duas diluições.

Encaminhar para agenda no Gercon: INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA.

Tuberculose



Painel de Gestão do Cuidado em Tuberculose

Gerencie tarefas, estoque e acompanhamentos da equipe.

Coleta de Escarro

Raio X (Gercon)

Resultados Escarro (Lab.
Central)

GAL

Notificação SINAN

Notificação SENTINELA

Tratamento/Medicação

TDO

Contatos

PPD

PCDT

Guia Rápido para
Profissionais

Notificação ILTB/Plataforma

Matriciamento

Transferência de Usuário

CRTB's

Hanseníase

PCDT Hanseníase Completo

PCDT Hanseníase Resumido

Formulário Avaliação
Neurológica Simplificado

Formulário de Vigilância de
Contatos Intradomiciliares

POP Coleta de Baciloscopia
(Raspado Intradérmico)

POP Teste Rápido para
Contatos

Questionário de Suspeição

Notificação via E-mail
(epidemio@portoalegre.rs.gov.br)

Estesiômetro: Auxílio na
Avaliação Neurológica

Recursos Adicionais

Programa Municipal de Controle (site da
Vigilância)

Aplicativo do Ministério da Saúde

Contato Vigilância: 3289-2474 / Whats:
3289-3976

Anemia Falciforme

Linha de Cuidado - Fluxo de Atendimento - Doença Falciforme - 2023

Doença Falciforme - O Papel da Escola - 2023

Dengue



Painel de Gestão do Cuidado em Dengue

Gerencie tarefas, estoque e acompanhamentos da equipe.

Plano de Contingência para o ano de 2026

Onde está o Aedes?

Dengue - Diagnóstico e Manejo Clínico da criança e do adulto

Locais de coleta de exame para dengue (Porto Alegre)

Dengue: Manual Gestação e Puerpério

Ferramenta de classificação de risco de paciente (RS)

Fluxograma - Suspeita de Dengue

Resultado de exames (Sou: Cliente Usuário: vigilancia Senha: Vig.123)

Calculadora de hidratação

Notificação Sentinela

Vacina

Prova do Laço: Régua

Como Fazer a Prova do Laço - Vídeo

Políticas Afirmativas

Selecione uma das opções abaixo para visualizar o fluxo de atendimento na APS.

POPULAÇÃO NEGRA

POPULAÇÃO IMIGRANTE

POPULAÇÃO LGBTQIAP+

População Negra

Racismo Institucional - Vídeo
1

Racismo Institucional - Vídeo
2

Vídeo Quesito Raça-Cor -
2016

Texto - Dia Internacional da
Mulher Negra Latino-
americana e Caribenha

Livro - Implementação da
Política Nacional de Saúde
Integral da População Negra
(Semeando o Baobá)

Livro - Vigilância de Fatores
de Risco (Vigitel)

População Haitiana

Livro - Equidade Étnicorracial
no SUS: População Negra e
Indígena

Ebook - Saberes Negros

População Imigrante

Card - Mediadores
Interculturais

Guia de acolhimento para
imigrantes Haitianos na APS

Lei Ordinária Nº 13.527 - 2023

CARTILHA PARA
ACOLHIMENTO DE
MIGRANTES
INTERNACIONAIS

População LGBTQIAP+

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS	Guia de Retificação de nome civil	Curso EAD - Promotores e Promotoras da Saúde LGBT	Cartilha - Justiça Reprodutiva Para Tódes
Guia de cuidado nutricional para a população trans, travesti e não binária na APS	Guia - Tele Condutas - Atendimento às Pessoas Transexuais e Travestis	Guia - Trabalhadores de Saúde - Técnicas de Acolhimento	

Tabagismo

Documentos, Manuais e Notas Técnicas do Programa Municipal de Controle do Tabagismo.



Painel de Gestão do Cuidado no controle do Tabagismo

Gerencie tarefas, estoque e acompanhamentos da equipe.

Nota Técnica do Programa Municipal de Controle (POA)	Guia do Programa Municipal de Controle (V.2 10.2025)	Nota Técnica - Prescrição e Dispensação (Reposição de Nicotina)	Manual de Cessação - Manual do Coordenador
Manual de Cessação - Volume 1	Manual de Cessação - Volume 2	Manual de Cessação - Volume 3	Manual de Cessação - Volume 4
Teste de Fagerström (Calculadora)	Escala de Motivação (Cessação do Tabagismo)	Vídeos de Apoio (Sugestão para TVs das Unidades)	Instrução: Uso Correto do Adesivo Transdérmico (Para Usuários)
Alerta INCA: Risco dos Cigarros Eletrônicos	Nota Técnica: Tratamento - Cigarros Eletrônicos (2025)		

CRIE

Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais

MANUAL CRIE

**Hospital Materno Infantil
Presidente Vargas**

[Ver Informações](#)

**Hospital Sanatório
Partenon**

[Ver Informações](#)

Vacinas Disponíveis

[Ver Lista Completa](#)

Porto Olhar Alegre



Painel de Gestão do Cuidado do programa Porto Olhar Alegre

Gerencie tarefas, estoque e acompanhamentos da equipe.

Guia - acuidade visual

Folder - Saúde Ocular

Folder - Acuidade Visual

Programa Visão 60+
Gercon - Consultas -
Programa Visão 60+
Local: óticas disponíveis no
cupom